

ASUHAN KEBIDANAN KOMPLEMENTER PADA MASA NIFAS

Tonasih, SST.,M.Kes

Bdn. Lia Fitria, S.ST.,M. Keb

Bdn. Dewi Andariya Ningsih, S.ST.,M. Keb

Evi Dwi Prastiwi, SST., M.Kes.

Muayah, S.KM., SST., M.Tr.Keb

Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.Si.T., M.Keb

Niken Bayu Argaheni, S.ST., M.Keb.

Bdn. Kusumastuti, S.Si.T., M.Kes.

Siti Rusyanti, S.ST., M.Keb

Shinta Wurdiana Rhomadona, S.ST., M.Tr.Keb

Rini Deska, S.ST. M.KM.CTM-MT

Bdn. Pande Putu Indah Purnamayanthi, S.ST., M.Kes

Wahidah Rohmawati, S.Tr.Keb., M.Kes



ASUHAN KEBIDANAN KOMPLEMENTER PADA MASA NIFAS

Penulis Utama:

Tonasih, SST.,M.Kes

Penulis:

Bdn. Lia Fitria, S.ST.,M. Keb

Bdn. Dewi Andariya Ningsih, S.ST.,M. Keb

Evi Dwi Prastiwi, SST., M.Kes.

Muayah, S.KM., SST., M.Tr.Keb

Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.Si.T., M.Keb

Niken Bayu Argaheni, S.ST., M.Keb.

Bdn. Kusumastuti, S.Si.T., M.Kes.

Siti Rusyanti, S.ST., M.Keb

Shinta Wurdiana Rhomadona, S.ST., M.Tr.Keb

Rini Deska, S.ST. M.KM.CTM-MT

Bdn. Pande Putu Indah Purnamayanthi, S.ST., M.Kes

Wahidah Rohmawati, S.Tr.Keb., M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

ASUHAN KEBIDANAN KOMPLEMENTER PADA MASA NIFAS

Penulis Utama:

Tonasih, SST.,M.Kes

Penulis:

Bdn. Lia Fitria, S.ST.,M. Keb
Bdn. Dewi Andariya Ningsih, S.ST.,M. Keb
Evi Dwi Prastiwi, SST., M.Kes.
Muayah, S.KM., SST., M.Tr.Keb
Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.Si.T., M.Keb
Niken Bayu Argaheni, S.ST.,M.Keb.
Bdn. Kusumastuti, S.Si.T., M.Kes.
Siti Rusyanti, S.ST.,M.Keb
Shinta Wurdiana Rhomadona, S.ST.,M.Tr.Keb
Rini Deska, S.ST. M.KM.CTM-MT
Bdn. Pande Putu Indah Purnamayanthi, S.ST., M.Kes
Wahidah Rohmawati, S.Tr.Keb.,M.Kes

Desain Cover:

Ivan Zumarano

Tata Letak:

Deni Sutrisno

Achmad Faisal

ISBN: 978-623-8411-31-3

Cetakan Pertama: **November, 2023**

Hak Cipta 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah
Jakarta Barat

Website: www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas sebagai dosen yaitu mengembangkan bahan ajar dengan menulis buku Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas.

Buku ini berjudul "**Asuhan Kebidanan Komplementer pada Masa Nifas**". Adapun topik bahasannya yaitu membahas tentang terapi komplementer yang biasa diterapkan pada ibu nifas dan menyusui. Tujuan penulisan buku ini yaitu untuk membantu para pembaca agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan bermacam-macam terapi atau pengobatan komplementer pada ibu masa nifas dan menyusui.

Buku ini tidak dapat terselesaikan, apabila penulis tidak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Tim Optimal yang telah begitu banyak memberikan bantuan baik moril maupun materiil
2. Kepada teman-teman penulis yang di Tengah-tengah kesibukan sebagai dosen dapat meluangkan waktunya demi terselesaikannya buku ini
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak mendukung dan membantu penyelesaian buku ini.

Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlimpah, dan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 06 November 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP DASAR TERAPI KOMPLEMENTER	1
A. Definisi Terapi Komplementer	2
B. Perkembangan Praktik Komplementer	2
C. Tujuan Terapi Komplementer	3
D. Klasifikasi Terapi Komplementer	4
E. Integrasi Pelayanan Kebidanan	4
F. Kategori dan Jenis Terapi Komplementer dalam Kebidanan	5
G. Metode Terapi Komplementer pada Ibu Nifas dan Menyusui	8
H. Dasar Hukum Praktik Komplementer	8
I. Perawatan Masa Nifas dalam Adat Budaya	10
DAFTAR PUSTAKA	15
BAB 2 AKUPRESSURE PADA IBU NIFAS	17
A. Pengertian <i>Akupressure</i>	18
B. Prinsip <i>Kerja Akupresure</i>	18
C. Teori <i>Yin dan Yang</i>	18
D. Manfaat <i>Terapi Akupresure</i>	19
E. Meridian dan Titik Pijat	20
F. Cara Kerja <i>Akupresure</i>	20
G. Teknik Manipulasi Pemijatan <i>Akupresure</i>	20
H. Jenis Akupresur	21
I. Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan oleh Terapis sebelum Melaksanakan <i>Akupresure</i>	21
J. Tujuan Terapi Shiatsu	21
K. Kondisi Pasien yang Dilarang untuk Terapi <i>Akupresure</i>	22
L. Tanggapan Masyarakat/Ibu Nifas Terhadap Terapi <i>Akupresure</i>	22
M. Larangan Pemijatan	22
N. Manfaat Akupresure pada Ibu Nifas	23
DAFTAR PUSTAKA	32
BAB 3 PIJAT ENDORPHIN PADA IBU NIFAS	35
A. Pendahuluan	36
B. Pemberian ASI	36
C. ASI	37
D. Analisis Data	39
E. <i>Endorphin Massage</i>	40
F. <i>Rapaport</i>	40
G. Pijat Punggung	41

DAFTAR PUSTAKA.....	44
BAB 4 PIJAT OKSITOSIN PADA IBU NIFAS	47
A. Pengertian Pijat Oksitosin.....	48
B. Manfaat Pijat Oksitosin.....	48
C. Mekanisme Pijat Oksitosin	49
D. Proses Pembentukan atau Produksi ASI.....	51
E. Langkah-Langkah Melakukan Pijat Oksitsin	52
F. Beberapa Penelitian Terkait Pijat Oksitosin Pada Ibu Nifas.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
BAB 5 YOGA PADA IBU NIFAS	57
A. Deskripsi.....	58
B. Pengertian Yoga Nifas	58
C. Fisiologi Yoga Nifas.....	59
D. Indikasi dan Kontra Indikasi Yoga Nifas	61
E. Manfaat Yoga.....	61
F. Gerakan Yoga Ibu Nifas.....	63
G. <i>Evidence Based</i> Kebidanan.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
BAB 6 PILATES UNTUK MASA NIFAS	69
A. Pendahuluan.....	70
B. Manfaat Pilates Pasca Melahirkan	72
C. Latihan Pilates pasca Melahirkan Menggunakan Bola dan Matras	73
DAFTAR PUSTAKA.....	77
BAB 7 PIJAT PADA IBU NIFAS.....	79
A. Pendahuluan.....	80
B. Pijat	81
C. Tahapan Dalam Pemijatan.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	85
BAB 8 AROMATERAPI PADA MASA POST PARTUM	87
A. Pendahuluan.....	88
B. Aromaterapi.....	88
C. Lavender Oil.....	90
D. Chamomile Oil	92
E. Lemon Oil (Citrus Limonia).....	93
F. Mawar oil	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
BAB 9 SENAM NIFAS.....	99
A. Pengertian	100
B. Tujuan Manfaat.....	100
C. Manfaat	101
D. Kontra Indikasi Senam Nifas	101
E. Waktu Pelaksanaan	101

F. Kerugian Bila Tidak Melakukan Senam Nifas	102
G. Pelaksanaan Senam Nifas	102
H. Persiapan Senam Nifas	107
I. Pengaruh Senam Nifas Terhadap Penurunan Tinggi Fundus Uteri.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
BAB 10 MANFAAT MADU PADA MASA NIFAS & LAKTASI.....	109
A. Madu dan Kesehatan.....	110
B. Manfaat Madu pada Masa Nifas dan Laktasi	111
DAFTAR PUSTAKA.....	119
BAB 11 HERBAL STEAM BATH UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI ASI 121	
A. Pengertian	122
B. Manfaat Herbal <i>Steam Bath</i>	123
C. Tanaman Herbal Yang Digunakan.....	124
D. Pelaksanaan Herbal <i>Steam Bath</i>	127
E. Evidence Based Kebidanan.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	130
BAB 12 HYPNOBREASTFEEDING	131
A. Pengertian Hypnosis/Hypnoterapi.....	132
B. Pengertian Hipnobreastfeeding	133
C. Manfaat Hipnobreastfeeding	133
D. Tujuan Hipnobreastfeeding	134
E. Syarat Melakukan Hipnobreastfeeding	134
F. Teknik Terapi	134
G. Teknik Relaksasi.....	135
H. Pikiran, Tubuh dan ASI.....	136
I. Menyusui dan Relaksasi	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138
BAB 13 PARENTING SELF-EFFICACY PADA IBU NIFAS	139
A. Parenting Self-Efficacy	140
B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi <i>Parenting Self-Efficacy</i>	141
C. Dimensi <i>Self-Efficacy</i>	142
D. Parenting Self-Efficacy Pada Ibu Nifas	144
E. Instrumen Parenting <i>Self-Efficacy</i>	146
DAFTAR PUSTAKA.....	149
BIOGRAFI PENULIS	151
SINOPSIS.....	158

BAB 1

KONSEP DASAR TERAPI KOMPLEMENTER

PADA IBU NIFAS DAN MENYUSUI

Evi Dwi Prastiwi, SST, M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 1

KONSEP DASAR TERAPI KOMPLEMENTER

PADA IBU NIFAS DAN MENYUSUI

Oleh: Evi Dwi Prastiwi,SST,M.Kes

A. Definisi Terapi Komplementer

Terapi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi kesehatan seseorang yang sakit, diantaranya meliputi perawatan (*treatment*) dan pengobatan penyakit. Komplementer merupakan suatu tindakan saling mengisi dan melengkapi (KBBI). Terapi Komplementer adalah sebuah kelompok dari macam-macam sistem pengobatan dan perawatan kesehatan, praktik dan produk yang secara umum tidak menjadi bagian dari pengobatan konvensional (Fatimah, 2017). Terapi komplementer berarti suatu upaya pengobatan yang dapat digunakan bersamaan dengan perawatan medis konvensional (bukan pengganti perawatan medis konvensional). Terapi ini dapat membantu merasa lebih baik dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup, serta dapat membantu mengatasi gejala-gejala suatu penyakit tertentu.

Pengobatan komplementer dilakukan dengan tujuan melengkapi pengobatan medis konvensional dan bersifat rasional yang tidak bertentangan dengan nilai dan hukum kesehatan di Indonesia. Adapun standar praktik pengobatan komplementer telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan bahwa pengobatan komplementer tradisional alternatif (*Complementary Alternative Medicine/CAM*) diartikan sebagai suatu pengobatan non konvensional yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Tindakan pengobatan komplementer tradisional alternatif meliputi upaya-upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pelayanan kebidanan komplementer merupakan pilihan bagi bidan maupun perempuan untuk mengurangi intervensi medis saat hamil, persalinan dan masa nifas, dan berdasarkan pengalaman hal tersebut cukup membantu dalam melakukan penanganan dan perawatan. Terapi komplementer pada masa nifas merupakan salah satu alternatif non medis yang dapat dimanfaatkan oleh ibu dalam mengatasi keluhan dan pemulihan selama masa nifas karena dapat menghindari efek samping dari penggunaan obat-obatan dan bahan kimia.

B. Perkembangan Praktik Komplementer

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tentang penggunaan pengobatan tradisional termasuk di dalamnya pengobatan

komplementer alternatif yang meningkat dari tahun ke tahun, bahkan hasil penelitian Tahun 2010 telah digunakan oleh 40% dari penduduk Indonesia.

Era modern seperti sekarang ini jika seseorang terdiagnosa penyakit kronis, biasanya langsung mengunjungi pusat pelayanan kesehatan modern dengan terapi obat kimia. Pengobatan modern biasanya menggunakan obat yang berasal dari kimia. Obat modern memang mempunyai reaksi mengurangi atau menyembuhkan penyakit dengan cepat. Namun tidak sedikit efek samping dari obat modern yang berasal dari bahan kimia. Oleh sebab itu, saat ini masyarakat mulai beralih dari pengobatan modern dengan bahan kimia yang mempunyai reaksi cepat namun menimbulkan banyak efek samping ke pengobatan tradisional atau komplementer dengan bahan herbal.

Pengobatan tradisional atau komplementer dapat menjadi solusi untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan bahkan dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Pengobatan ini lebih aman dan memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan obat modern dengan bahan kimia. Meskipun pengobatan tradisional atau komplementer relatif lebih aman namun bukan berarti tidak menimbulkan risiko. Keadaan yang tidak diperkenankan dalam mengkonsumsi obat herbal yaitu dalam kondisi hamil dan menyusui karena harus waspada terhadap risiko yang mungkin terjadi pada bayinya melalui barrier plasenta maupun ASI. Misalnya penggunaan rumput Fatimah dilarang dikonsumsi oleh ibu hamil karena kandungan rumput Fatimah terdapat oksitosin yang merangsang kontraksi. Kontraksi yang terjadi sebelum waktu persalinan maka menyebabkan persalinan prematur. Selain itu juga, dapat menyebabkan risiko perdarahan pada proses persalinan karena belum diketahui secara pasti jumlah kandungan oksitosin pada rumput Fatimah yang dikonsumsi.

C. Tujuan Terapi Komplementer

Terapi Komplementer bertujuan untuk memperbaiki fungsi dari sistem-sistem tubuh terutama sistem kekebalan dan pertahanan tubuh agar tubuh dapat menyembuhkan tubuhnya sendiri yang sedang sakit, karena tubuh memiliki kemampuan dalam menyembuhkan dirinya sendiri secara alami, melalui asupan nutrisi yang cukup dan perawatan (*treatment*) yang tepat. (Prasetyaningati, 2019)

Ibu nifas merupakan kelompok yang dianjurkan memanfaatkan terapi atau pengobatan komplementer dalam mengatasi keluhan yang dirasakan, karena dengan terapi komplementer dapat menghindari efek samping dari pengobatan konvensional dan memiliki kontrol yang besar terhadap kesehatan sendiri.

Selain penatalaksanaan sesuai *evidence based* kebidanan terkadang ibu nifas juga menggunakan terapi komplementer untuk mengatasi keluhan yang dialami oleh ibu nifas seperti menggunakan ramuan herbal untuk memperbanyak produksi ASI

atau untuk mengurangi nyeri pada luka perineum. Selain itu juga terdapat beberapa metode untuk mempercepat pemulihan kondisi kesehatan ibu nifas menggunakan Pilis, Parem, Tapel atau Penggunaan Bengkung (Akhiar, 2016; Windayanti, 2017).

D. Klasifikasi Terapi Komplementer

Klasifikasi Komplementer di Indonesia dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pelayanan Kesehatan Tradisional merupakan suatu jenis pengobatan dan perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Adapun contoh pelayanan kesehatan tradisional adalah penggunaan bengkung pada ibu nifas.

2. Pelayanan Kesehatan Ramuan

Pelayanan kesehatan ramuan merupakan pelayanan kesehatan tradisional yang telah terbukti secara empiris dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Ramuan tradisional tersebut dikemas secara efektif, efisien, dan modern sehingga mudah digunakan oleh masyarakat. Contoh penggunaan pelayanan kesehatan ramuan adalah Pilis, Tapel, Parem, Jamu.

3. Pelayanan Kesehatan Ketrampilan

Pelayanan kesehatan ketrampilan terdiri dari:

- a. Pijat
- b. Akupunktur
- c. Akupresur

(Widaryanti, 2019)

E. Integrasi Pelayanan Kebidanan

WHO membagi integrasi pelayanan kebidanan menjadi 3 jenis yaitu:

1. Integrasi Penuh

Merupakan pelayanan kesehatan tradisional sudah terintegrasi secara keseluruhan ke dalam sistem kesehatan suatu Negara yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah/ swasta, pendidikan/ pelatihan, regulasi pelayanan, regulasi penyediaan, registrasi obat dan asuransi)

2. Integrasi Inklusif

Merupakan sebagian aspek pelayanan kesehatan tradisional berintegrasi ke dalam sistem kesehatan suatu negara

3. Integrasi Toleransi

Merupakan seluruh sistem kesehatan nasional suatu Negara berlandaskan kedokteran konvensional tetapi beberapa jenis pelayanan kesehatan tradisional masih dapat diterima oleh Undang- Undang.
(Widaryanti, 2019)

F. Kategori dan Jenis Terapi Komplementer dalam Kebidanan

1. Terapi Tradisional

Pengobatan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya mengacu pada pengalaman, ketrampilan turun temurun, pendidikan/ pelatihan yang diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Adapun jenis terapi tradisional diantaranya yaitu:

a. Akupunktur

Teknik pengobatan tradisional yang dilakukan dengan cara menusukkan jari pada titik-titik tertentu pada tubuh pasien. Tujuan dilakukan akupunktur adalah untuk mengembalikan sistem keseimbangan tubuh agar pasien dapat kembali sehat seperti sedia kala. Akupunktur bermanfaat sebagai pengobatan tambahan atau alternatif yang dapat diterima atau dimasukkan dalam program manajemen pemulihan komprehensif.

b. *Ayurveda*

Teknik pengobatan yang menekankan pada pencegahan dan pemeliharaan kesehatan melalui perhatian penuh terhadap keseimbangan dalam kehidupan seseorang. Keseimbangan yang harus diupayakan adalah pikiran positif, pola makan, gaya hidup dan juga bahan herbal. Teknik ini menggunakan semua aspek kehidupan, tubuh, pikiran dan jiwa.

c. *Homeopati*

Pengobatan holistik yang menggunakan zat-zat khusus untuk menyembuhkan pasien. Zat yang biasa digunakan dalam bentuk tablet dan bertujuan untuk memicu mekanisme penyembuhan pada tubuh sendiri. Prinsip pengobatan ini yaitu dengan adanya pemahaman bahwa suatu zat yang dapat mengganggu kesehatan adalah apabila digunakan dalam jumlah dan dosis yang besar, dan dapat digunakan untuk mengobati gejala yang sama apabila digunakan dalam jumlah kecil.

d. *Naturopati*

Sistem penyembuhan yang bertujuan untuk memberikan perawatan kesehatan holistik. Terapi ini menggunakan kekuatan penyembuhan alami tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri dan berfokus pada mengobati penyebab penyakit daripada gejalanya. Tujuan pengobatan ini adalah mengobati secara keseluruhan meliputi tubuh, pikiran dan jiwa. Manfaat *neuropati* dalam kebidanan adalah dapat menangani kasus infertil pada

Pasangan Usia Subur (PUS) serta dapat mengatasi ketidakseimbangan hormon dalam tubuh.

e. Pengobatan tradisional Cina

Beberapa jenis pengobatan tradisional yaitu:

- 1) Terapi *Moksibusi*
- 2) Pijat Tuina
- 3) Bekam
- 4) Gua Sha
- 5) Herbal China
- 6) Pengaturan Pola Makan (diet) China
- 7) *Chinese Tongue*

2. Terapi Tubuh

Bentuk terapi tubuh yang paling umum dilakukan yaitu Pijat.

Adapun jenis terapi tubuh sebagai berikut:

a. *Kiropratik*

Terapi yang dilakukan untuk mengobati dan mengatasi masalah sistem musculoskeletal. Manfaatnya yaitu mengobati nyeri leher, nyeri punggung bawah, dan nyeri dada.

b. *Osteopati*

Terapi manual non invasif yang bebas obat dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan tubuh dengan memanipulasi dan memperkuat muskuloskeletal.

Tujuannya yaitu meningkatkan kerja sistem syaraf, peredaran darah, dan limfatik tubuh.

Manfaat:

- 1) Mengurangi nyeri punggung
- 2) Mengatasi gangguan tidur
- 3) Mengatasi gangguan sistem tubuh

c. *Terapi Pijat*

Terapi dengan memberikan tekanan pada seluruh bagian tubuh sehingga kulit, otot dan urat mendapatkan tekanan.

Tujuan terapi pijat diantaranya:

- 1) Memberikan relaksasi
- 2) Meredakan depresi serta kecemasan
- 3) Menghilangkan rasa lelah pada tubuh
- 4) Meningkatkan kualitas tidur
- 5) Meningkatkan kekebalan tubuh

3. Terapi Gerakan

Merupakan suatu terapi yang menggunakan gerakan seperti teknik Tarian, Taichi dan Yoga.

Adapun tujuan dari terapi ini diantaranya:

- a. Untuk meningkatkan keseimbangan, kekuatan dan fleksibilitas
 - b. Meningkatkan tonus otot dan koordinasi serta ketahanan sendi
- Manfaat terapi gerakan adalah untuk mengobati masalah fisik (hipertensi, penyakit kardiovaskuler), kesehatan mental (gelisah, depresi, gangguan makan, dan stress paska trauma), kognitif (dimensia dan masalah komunikasi), isu social (trauma kekerasan dalam rumah tangga, interaksi social, dan konflik keluarga)

4. Diet dan Herbal

Merupakan teknik penyembuhan dan pengobatan dengan menggunakan tanaman. Pengobatan herbal menggunakan tanaman herbal untuk penyembuhan. Diet merupakan upaya mengatur pola nutrisi yang masuk dalam tubuh.

5. Terapi Energi

Tujuan dari penggunaan terapi energi yaitu untuk membawa energi ke pasien atau menyeimbangkan energi di dalam tubuh pasien. Beberapa jenis terapi energi yang dapat dilakukan kepada pasien diantaranya sebagai berikut:

- a. Terapi Suara
Terapi yang menggunakan terapi musik yang bertujuan untuk memberikan efek kenyamanan dan rileksasi
- b. Terapi Elektromagnetik
Terapi ini diterapkan pada tubuh untuk memperbaiki ketidakseimbangan dengan cara mengontrol detak jatuh, menstimulasi otot.
- c. *Reiki*
Teknik pengobatan komplementer untuk mengurangi stres dan mendorong penyembuhan
- d. *Qi Gong*
Terapi energi yang dilakukan dengan gerakan lembut yang diulang beberapa kali dengan meregangkan tubuh untuk meningkatkan pergerakan cairan tubuh serta membangun kesadaran tentang bagaimana tubuh bergerak melalui ruang.

6. Terapi Pikiran

Merupakan suatu upaya penyembuhan yang dilakukan dengan memadukan pikiran dan tubuh. Teknik yang dapat memadukan unsur tersebut diantaranya adalah meditasi dan *hipnoterapi*. Meditasi merupakan kegiatan yang berfokus pada napas. Meditasi yang dapat dilakukan adalah meditasi konsentrasi dan meditasi pikiran. *Hipnoterapi* adalah kegiatan membimbing pasien dalam kondisi *trance* untuk keperluan terapi/ pengobatan. (Akhiriyanti, 2020)

G. Metode Terapi Komplementer pada Ibu Nifas dan Menyusui

1. Akupresure
2. Pijat Endorphin
3. Pijat Oksitosin
4. Yoga
5. Pilates
6. Pijat
7. Aromatherapi
8. Senam Nifas
9. Terapi Madu
10. Herbal Steam Bath
11. Hypnobreastfeeding
12. Parenting Self-Efficacy

H. Dasar Hukum Praktik Komplementer

1. Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - a. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, bulir 16 yang berbunyi "*Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah Pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.*"
 - b. Bab III Pelayanan Kesehatan Tradisional Pasal 59, 60, dan 61

Pasal 59 bulir 1 berbunyi "*Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ketrampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.*"

Pasal 59 bulir kedua berbunyi "*Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.*"

Pasal 59 bulir ketiga berbunyi "*ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.*"

Pasal 60 bulir pertama berbunyi "*Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.*"

Pasal 60 bulir kedua berbunyi "*Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus data dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.*"

Pasal 61 bulir pertama berbunyi "*Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.*"

Pasal 61 bulir kedua berbunyi "*Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada kewanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.*"

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1076/Menkes/SK/2003 tentang Pengobatan Tradisional (Cara dan Syarat mendapatkan izin praktik pengobatan tradisional)
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, meliputi:
 - a. Pelayanan Pengobatan Alternatif meliputi Akupunktur, Akupresur, Naturopati, Homeopati, Aromaterapi, Ayurveda
 - b. Intervensi tubuh dan pikiran (*mind and body interventions*) meliputi praktik Hipnoterapi, Mediasi, Penyembuhan Spiritual, dan Yoga
 - c. Pengobatan manual, meliputi praktik *Kiropraktik, Healing Touch*, Pemijatan, *Shiatsu, dan Osteopati*
 - d. Pengobatan Farmakologi dan biologi, meliputi Jamu, Obat Herbal, Gurah
 - e. Pengaturan Pola Makan dan Nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan meliputi diet *macro nutrient* dan *diet micro nutrient*
 - f. Terapi lain berdasarkan diagnosis dan pengobatan, meliputi terapi ozon, terapi *hiperbarik*.
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 120/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan *Hiperbarik*
5. Keputusan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor HK.03.05/I/199/2010 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Metode Pengobatan Komplementer dan Alternatif yang dapat diintegrasikan pada fasilitas pelayanan kesehatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 003/MENKES/PER/I/2010 tentang Sainifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 121 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Medik Herbal

I. Perawatan Masa Nifas dalam Adat Budaya

Masa nifas merupakan masa yang penting, karena risiko kesakitan dan kematian ibu dan bayi meningkat pada masa ini. Perdarahan merupakan penyebab utama kematian ibu di dunia dan sebagian besar terjadi sebelum 24 jam pasca persalinan. Oleh karena itu penolong persalinan harus memastikan bahwa uterus berkontraksi dengan baik, sehingga tidak terjadi perdarahan. Masa nifas dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah sosial budaya.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku dan budaya yang mempunyai tradisi kesehatan masing-masing. Tidak semua tradisi yang ada mempunyai efek yang buruk terhadap kesehatan namun ada juga beberapa yang mempunyai dampak positif bagi kesehatan (Widaryanti & Riska, 2019).

Di daerah Jawa terdapat tradisi penggunaan Bengkung/Stagen. Bengkung merupakan kain panjang yang digunakan untuk membebat perut ibu dengan lebar 20 cm dan panjang 5 cm. Cara penggunaan bengkung yaitu dengan melilitkan pada pinggang dan perut berkali-kali hingga kain habis. Bengkung dipercaya dapat mengembalikan bentuk perut seperti sebelum hamil. Bengkung jika digunakan secara tepat memiliki beberapa manfaat antara lain:

- a. Memaksimalkan involusi uterus
- b. Memulihkan tonus abdomen
- c. Mengurangi nyeri punggung dan menyangga punggung ibu nifas sehingga membantu pembentukan postur tubuh

Pada ibu nifas perubahan fisiologis dapat menyebabkan sakit punggung salah satu cara mengatasinya dengan menggunakan bengkung atau gurita. Penggunaan bengkung sebaiknya digunakan oleh ibu yang melahirkan secara normal dan tidak mengalami komplikasi selama persalinan maupun nifas, tehnik penggunaan bengkung yang kurang tepat akan menyebabkan terganggunya proses pemulihan kesehatan ibu nifas (Widaryanti & Riska, 2019). Bengkung atau gurita dapat dipakai maksimal 4-6 jam perhari dan dipakai setelah mandi, bengkung harus diganti setiap hari agar tidak menimbulkan masalah kulit pada abdomen, penggunaan bengkung atau gurita tidak boleh terlalu erat agar ibu dapat merasa nyaman dan tidak sesak napas (Rahayu, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Benjamin (2014) yaitu ibu nifas yang menggunakan kain penyangga bisa mendapatkan kompresi atau tekanan pada perut sehingga membantu menyangga perut dan daerah *lumbopelvic* dengan memberikan sedikit tekanan pada otot *transversus abdominis* sehingga pada akhirnya akan membantu otot perut bekerja lebih sempurna. Otot perut yang lemah ikut menyumbang terjadinya nyeri punggung selama dan sesudah kehamilan. Penggunaan bengkung dan disertai dengan latihan fisik yang adekuat akan membantu mengurangi insiden nyeri punggung pada ibu nifas.

Penelitian Rahayu (2018) yaitu bengkung yang jarang diganti dapat mengakibatkan rasa gatal pada kulit ibu. Pemilihan bahan kain bengkung disesuaikan dengan kulit ibu karena ada beberapa model kain bengkung yang menyebabkan rasa gatal pada kulit. Kesalahan penggunaan bengkung yaitu diantaranya adalah penggunaan yang terlalu ketat (bisa menyebabkan sesak napas), pemakaian yang terlalu lama dan jarang diganti.

Perawatan masa nifas lainnya adalah penggunaan Pilis, Tapel Dan Parem. Pilis merupakan ramuan tradisional yang berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, mencegah nyeri, rasa sakit dan pusing pada kepala. Pilis ini berbentuk padat atau pasta yang cara penggunaannya dioleskan di dahi. Penggunaan pilis di masyarakat sudah mulai di tinggalkan, hal ini terbukti bahwa penerimaan masyarakat tentang pilis yang rendah yaitu 11,3%. Banyak ibu nifas terutama yang tinggal di perkotaan sudah tidak lagi menggunakan pilis hal ini di karenakan kurangnya pengetahuan tentang manfaat dari pilis. Selain itu penggunaan pilis juga kurang diminati karena cara penggunaan yang tidak praktis dan dirasa tidak *fashionable*. Pilis harus dioleskan pada dahi setelah ibu nifas selesai mandi, warna dari pilis juga mencolok sehingga membuat ibu nifas tidak percaya diri untuk menggunakannya. Padahal banyak manfaat yang diperoleh dari penggunaan pilis antara lain menghilangkan rasa pusing yang diakibatkan kelelahan saat proses persalinan. Pilis terbuat dari pala dan cengkeh sehingga menimbulkan rasa hangat yang dapat meningkatkan rasa nyaman di bagian kepala. Pasca persalinan pandangan mata ibu menjadi berkurang karena proses mendedan, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan pilis selama masa nifas. (Fuadi, 2019)

Tapel adalah campuran dari kapur sirih, jeruk nipis, dan minyak kayu putih yang bermanfaat untuk menghangatkan perut yang membuat usus bekerja atau berkontraksi lebih cepat sehingga angin yang berada di dalam perut dapat keluar dengan mudah. Pada ibu yang melahirkan dengan cara operasi SC maka tapel baru boleh digunakan setelah luka operasi sembuh karena pemakaian tapel tidak boleh mengenai luka bekas operasi (berisiko meningkatkan infeksi). Ramuan ini (tapel) digunakan pada bagian perut yang bermanfaat untuk mengurangi selulit dan mengecilkan perut setelah proses kehamilan dan persalinan. Sama seperti pilis penggunaan tapel sudah mulai ditinggalkan karena cara mempersiapkan ramuan ini yang rumit dan berisiko terjadi alergi pada ibu yang mempunyai kulit sensitif (Widaryanti & Riska, 2019). Dari hasil penelitian ini hanya 9,4% ibu yang setuju menggunakan tapel. Sebelum menggunakan bengkung tapel dioleskan pada perut dan digunakan selama masa nifas dan setiap sepuluh hari jenis ramuan yang digunakan akan diganti jenisnya. (Fuadi, 2019)

Parem yaitu bedak yang berbentuk bulat dan padat yang terbuat dari Jahe, Pala, Kencur, Tepung Beras, Lempuyang, Temu Giring, Cengkeh, Adas Pulowaras, Minyak Gondopuro, Kayu Manis dan air secukupnya yang bermanfaat untuk melembaskan

otot-otot badan yang terasa kaku, mengurangi risiko kram, kaki bengkak, kelelahan bagian kaki akibat kehamilan dan menghangatkan kaki sehingga aliran darah menjadi lancar. Pada ibu yang memiliki kulit sensitif tidak dianjurkan menggunakan parem karena bersifat panas. Selain itu hindari penggunaan pada daerah payudara dan perut karena sebagian besar daerah ini berupa jaringan lemak sedangkan parem bekerja pada otot. Penggunaan parem dapat mengurangi rasa pegal pada otot tangan dan kaki ibu setelah melahirkan.

Di kota daerah perkotaan parem sudah jarang digunakan, karena tidak semua ibu suka dengan aroma herbal selain itu menggunakan parem juga dapat menyebabkan iritasi pada ibu yang memiliki kulit sensitif. Pada penelitian ini hampir semua responden (98,1%) tidak setuju dengan penggunaan parem, mereka beranggapan bahwa penggunaan parem tidak praktis, dan dapat mengotori pakaian. Namun di daerah lain parem masih sering digunakan, mereka mendapatkan parem dari bidan maupun dari penjual jamu herbal. Parem dijual sudah dalam bentuk bulat seperti kue kering kemudian jika akan digunakan dilarutkan dalam air dan dioleskan (Zumaidar, Saudah, Rasnovi, & Harnelly, 2019).

Pada ibu nifas pemberian air rebusan Daun Binahong sangat baik untuk penyembuhan luka perineum. Kandungan antiseptik dalam tanaman Binahong dapat membunuh kuman, meningkatkan daya tahan terhadap infeksi, serta mempercepat penyembuhan luka. 12 Senyawa kimia yang terkandung dalam Daun Binahong adalah Saponin, Alkaloid, Polifenol, Flavonoid Dan Mono Polisakarida yang termasuk dalam golongan Larabinose, D-galaktose, L-rhamnose, Dglukosa.

Hal ini sesuai dengan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Ariani, dkk (2022) bahwa setelah dievaluasi menunjukkan data survei yang lebih efektif untuk mengeringkan luka perineum adalah daun Binahong karena ibu yang menggunakan rebusan air Binahong luka jahitan perineum kering sempurna dalam waktu 4 hari sedangkan ibu yang menggunakan air rebusan daun sirih luka jahitan perineum kering sempurna dalam waktu 7 hari. Namun setelah ditelaah sugesti juga dapat memengaruhi percepatan luka perineum.

Salah satu perawatan tradisional yang dilakukan ibu nifas di Aceh diantaranya yaitu menggunakan ramuan oral maupun topikal, melakukan *massage* (pijat), dan pantangan makanan. Ibu nifas mengkonsumsi ramuan yang terbuat dari bahan herbal seperti Kunyit, Asam Jawa, dan tanaman herbal lainnya. Konsumsi tanaman herbal dapat membantu memulihkan tenaga lebih cepat, menghangatkan tubuh, mempercepat penyembuhan luka pada jalan lahir, memperlancar laktea, dan mengurangi rasa nyeri. Jamu yang digunakan ibu nifas tidak hanya dikonsumsi melainkan juga ada yang digunakan secara topikal yaitu mengoleskan pada seluruh tubuh atau bagian tubuh tertentu misal dada atau kaki.

Pijat yang direkomendasikan pada ibu nifas adalah pijat oksitosin. Keuntungan pijat oksitosin bagi ibu nifas yaitu memperlancar pengeluaran ASI. Penelitian Rahayu

dan Yuniarsih (2018) bahwa pijat oksitosin meningkatkan kenyamanan dan produksi ASI pada ibu nifas. Pijat oksitosin dapat digunakan sebagai intervensi alternatif dalam memberikan asuhan pada ibu nifas terutama untuk mencegah permasalahan menyusui.

Laktogogum merupakan zat yang dapat meningkatkan dan melancarkan produksi ASI. Setiap daerah memiliki laktogogum masing-masing diantaranya daerah Sumatra (khususnya Batak) memiliki kepercayaan terhadap daun bangun- bangun (*Coleus Amboinicus*), di Jawa mempercayai Daun Katuk, Jagung Muda, Jantung Pisang, Daun Pepaya, Daun Kelor, dan masih banyak lagi tanaman yang dianggap sebagai tanaman untuk memperlancar ASI.

Berikut beberapa hasil penelitian mengenai tanaman yang dipercaya dapat memperlancar ASI diantaranya sebagai berikut:

- a. Jamu Uyup-Uyup
merupakan jamu tradisional khas Jawa yang terbuat dari bahan Kencur, Jahe, Bangle, Lengkuas, Kunyit, Daun Katuk, Temulawak, Puyang, Temugiring dan air secukupnya. Cara membuatnya yaitu semua bahan dicuci bersih tanpa dikupas kemudian ditumbuk kasar lalu diperas. Perasan lalu dimasukkan ke dalam air matang yang sudah dingin lalu tambahkan gula sesuai selera. Jamu ini secara empiris telah digunakan secara turun temurun dari jaman dulu dan terbukti dapat memperlancar produksi ASI.
- b. Daun bangun-bangun atau daun jintan
Merupakan tanaman yang banyak dikonsumsi oleh ibu-ibu setelah melahirkan di daerah Toba, Sumatra Utara. Tanaman ini dijadikan makanan pendamping nasi (sayuran). Kadar FeSO_4 pada daun bangun-bangun data diandalkan sebagai sumber besi *non heme* bagi ibu menyusui.
- c. Daun Katuk
Pada masyarakat Jawa, Daun Katuk merupakan tanaman yang berkhasiat dalam peningkatan produksi ASI. Ibu menyusui mengkonsumsi daun katuk dengan membuat lalapan atau sayur rebus. Daun katuk mengandung steroid dan polifenol yang dapat meningkatkan kadar prolactin. Kadar prolaktin yang tinggi akan meningkatkan, mempercepat dan memperlancar produksi ASI.
- d. Daun kacang panjang
Penelitian yang dilakukan oleh Djama (2018) pemberian daun kacang panjang dapat memengaruhi peningkatan produksi ASI ibu menyusui. Daun kacang panjang memiliki potensi menstimulasi hormon oksitosin dan prolaktin.
- e. Daun Adas
Tanaman Adas dikenal oleh masyarakat Jawa dapat memperlancar dan memproduksi ASI pada Ibu Menyusui. Daun Adas digunakan sebagai sayuran yang dikonsumsi sehari-hari.
- f. Daun dan buah pepaya

Adanya tradisi ibu menyusui harus mengkonsumsi buah pepaya muda atau daun pepaya untuk memperbanyak produksi ASI. Getah atau lateks pada pepaya muda memiliki efek yang sama dengan hormone oksitosin dan prolactin, setiap daerah mempunyai konsumsi yang berbeda dalam upaya memproduksi ASI diantaranya ada yang membuat sop pepaya muda dan juga mengkonsumsi daun pepaya.

g. Daun Kelor

Di Sulawesi terdapat tradisi mengkonsumsi daun kelor. Daun kelor mengandung senyawa fitosterol yang dapat meningkatkan produksi ASI. Penelitian yang dilakukan oleh Zakaria (2016) bahwa pemberian ekstra daun kelor dapat meningkatkan produksi ASI secara signifikan, tetapi tidak memengaruhi kualitas ASI. Selain mengandung fitosterol daun kelor juga mengandung zat besi yang juga dapat mengatasi anemia pada ibu nifas. Penelitian Adi (2018) bahwa masyarakat yang rajin mengkonsumsi daun kelor lebih berenergi dan sehat karena daun kelor dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh.

h. Daun Pakis

Bagi Ibu Menyusui daun pakis merupakan salah satu alternatif sayuran yang dapat meningkatkan produksi ASI.

Pantangan makanan pada ibu nifas meliputi jenis makanan dan porsi. Pantangan makan ini bertujuan untuk menjaga berat badan dan bentuk tubuh, menjaga kualitas ASI, dan menjaga kesehatan ibu. Jenis makanan yang dilarang untuk ibu nifas diantaranya yaitu makanan pedas, makanan yang digoreng, nangka, durian, telur, seafood, cabai dan lada. Ibu nifas membutuhkan tambahan kalori 200-500 kalori dari kebutuhan sebelum hamil. Asupan nutrisi dapat membantu proses penyembuhan luka pada ibu nifas. (Tumanserry, 2018)

Penelitian tentang efek salep kayu manis 2% pada nyeri perineum dan proses kesembuhan luka episiotomi menunjukkan hasil bahwa kayu manis dapat digunakan untuk mengurangi nyeri perineum dan mempercepat proses kesembuhan dari luka episiotomi dan masih banyak lagi tanaman herbal yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri pada perineum. (Wulandari dan Kumalasari, 2017)

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiar, S. K. B. (2016). Amalan Dan Penggunaan Herba Dalam Perubatan Tradisional Melayu Selepas Bersalin Di Zon Tengah, Semenanjung Malaysia. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,
- Akhiriyanti, Evi Nur. (2020). Mengenal Terapi Komplementer Pada Ibu Nifas, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita. Jakarta: CV. Trans Info Media
- Ariani, Antri.dkk. (2022). Pengembangan Komplementer Pada Ibu Nifas dengan Pendekatan Terapi Menggunakan Daun Sirih dan Daun Binahong Untuk Mempercepat Penyembuhan Luka. Jurnal Paradigma (Pemberdayaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat)
- Ayuningtyas, Ika Fitria. (2019). Kebidanan Komplementer Terapi Komplementer Dalam Kebidanan. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Benjamin,D., Van De Water,A & Peiris,C,J.P. (2014). Effect of Exercise on Diastasis of the rectus abdominalis muscle in the antenatal and postnatal periods : a sistematic review.100,1-8
- Djama, N.J.J.R.K. (2018) Pengaruh Konsumsi Daun Kacang Panjang Terhadap Peningkatan Produksi ASI Pada Ibu Menyusui
- Fuadi, T. M. J. P. B. (2019). Pengobatan Tradisional Madeung Dan Sale Pada Ibu Masa Nifas Dalam Masyarakat Aceh. 5(1).
- Jayanti, Nicky Danur.dkk. (2022). Asuhan Komplementer Tata Laksana Afterpain Pada Ibu Post Partum : Literature Review. Jurnal Ilmiah Kebidanan
- Mariyati, Tumanserry. (2018). Perawatan Diri Berbasis Budaya Selama Masa Nifas Pada Ibu Postpartum. Jurnal Ilmu Keperawatan 6:1 ISSN :2338-6371, eISSN 2550-018x
- Rahayu, D. T. J. a.-t. J. P. k. M. (2018). Pendidikan Komunitas Tentang Pemakaian Bengkung Pada Ibu Nifas Di Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. 1(1), 35-44.
- Rahayu, I. S., Mudatsir, M., & Hasballah, K. J. J. I. K. (2017). Faktor budaya dalam perawatan ibu nifas. 5(1), 36-49.
- Trionggo, I., dkk., (2013), Panduan Sehat Sembuhkan Penyakit dengan Pijat dan Herbal. Indotoleransi:Yogyakarta
- Widaryanti, Rahayu. (2019). Terapi Komplementer Pelayanan Kebidanan Berdasarkan Bukti Scientific dan Empiris. Yogyakarta: Deepublish
- Windayanti, H. (2017). Pemanfaatan Herbal Pada Asuhan Ibu Nifas. Paper presented at the Seminar Nasional Kebidanan.
- Wulandari, E.T & Kumalasari, D.J.A.J.I.K. (2017) Herbal untuk Perawatan Masa Nifas; Penggunaan Kayu Manis untuk Nyeri Perinium dan Luka Episiotomi.2.

Zumaidar, Z., Saudah, S., Rasnovi, S., & Harnelly, E. J. A.-K. J. B. (2019). Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional Pasca Melahirkan Oleh Suku Aceh Di Kabupaten Pidie. 12(2), 157-163.

BAB 2

AKUPRESSURE PADA IBU NIFAS

Tonasih, SST.,M.Kes



BAB 2

AKUPRESSURE PADA IBU NIFAS

Oleh: Tonasih, SST.,M.Kes

A. Pengertian *Akupressure*

Akupressure merupakan suatu pelayanan kesehatan alternatif yang asalnya dari Jepang, bertujuan untuk membantu meningkatkan kebugaran tubuh dan mengatasi masalah kesehatan, caranya yaitu titik-titik meridian tertentu dirangsang dengan cara permukaan tubuh ditekan memakai jari tangan atau benda-benda yang tumpul. (Hanum, Sri Mukhodim. Widowati, Hesty & Arti 2021)

B. Prinsip Kerja *Akupresure*

Prinsip kerja *Akupresure* sama seperti akupuntur yaitu untuk menyeimbangkan *bioenergy* pada badan antara *Yin*, *Yang* serta *Qi (Chee)* dengan cara merangsang empat belas (14) sistem meridian. (Putri, Dewi Murdiyanti & Amalia 2019)

C. Teori *Yin* dan *Yang*

Ada beberapa penerapan *Yin* dan *Yang* dalam (Hanum, Sri Mukhodim. Widowati, Hesty & Arti 2021), antara lain:

1. Penerapan "*Yin*" dan "*Yang*" pada Alam Semesta

Tabel 2.1
Penerapan "*Yin*" dan "*Yang*" di Dunia

" <i>YIN</i> "	" <i>YANG</i> "
Gulita	Terang
Malam	Siang
Sejuk	Panas
Bawah	Atas
Barat	Timur

2. Penerapan "*Yin*" dan "*Yang*" pada Badan

Tabel 2.2
Penerapan "*Yin*" dan "*Yang*" pada Badan Manusia

YIN	YANG
Wanita	Pria
Kanan	Kiri
Ovum	Sperma

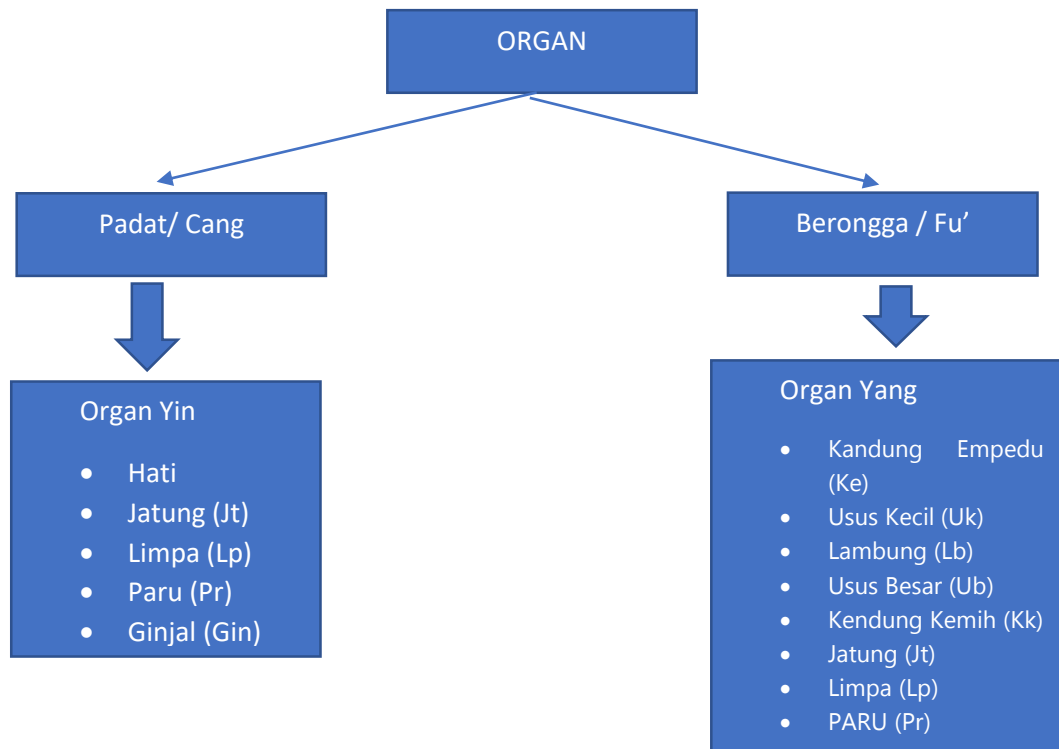
YIN	YANG
Dalam	Luar

3. Penerapan Yin dan Yang dalam Gejala

Tabel 2.3
Penerapan "Yin" dan "Yang" pada Tanda Gejala

YIN	YANG
Kritis	Akut
Tentram	Gelisah
Sejuk	Panas

4. Penerapan "Yin" dan "Yang" pada Badan Orang



Gambar 2.1
Pembagian Organ Yin dan Yang
Sumber: (Hanum, Sri Mukhodim. Widowati, Hesty & Arti 2021)

D. Manfaat *Terapi Akupresure*

Ada beberapa manfaat terapi *akupresure* antara lain:

1. Dapat mencegah dan menyembuhkan penyakit serta rehabilitasi (pemulihan)
2. Meningkatkan daya tahan tubuh
3. Mengurangi rasa sakit dan keluhan bermacam-macam penyakit, misalnya *Low Back Pain (LBP)* serta menurunkan jumlah detak jantung (*heart rate*) klien stroke.

(Hanum, Sri Mukhodim. Widowati, Hesty & Arti 2021)

E. Meridian dan Titik Pijat

Tabel 2.4
Meridian Umum dan Titik Wajib *Akupresure*

No	Organ	Kode	Letak	Jumlah Titik	Titik Wajib
I	PARU	LU	Tangan	11	1, 7, 9
II	USUS BESAR	LI	Tangan	20	4 dan 6
III	LAMBUNG	ST	Kaki	45	36, 37, 38, 40, dan 42
IV	LIMPA	SP	Kaki	21	3, 4, 6, 8, 9 dan 10
V	JANTUNG	HT	Tangan	3, 5, dan 7	3, 5, dan 7
VI	USUS KECIL	SI	Tangan	19	3, 4, dan 7
VII	KANDUNG KEMIH	BL	Kaki	67	39, 40, 60, 62, dan 64
VIII	GINJAL	KI	Kaki	27	3, 6, 7
IX	SELAPUT JANTUNG	PC	Tangan	9	6, 7
X	TRI PEMANAS	TE	Tangan	23	4, 5
XI	KANDUNG EMPEDU	GB	Kaki	44	21, 34, 39, 40, 41
XII	HATI	LV	Kaki	14	2, 3, 14
XIII	REN	CV	Depan	24	8, 17
XIV	DU'	GV	Belakang	28	4, 14, 20 dan 26

Sumber: (Hanum, Sri Mukhodim. Widowati, Hesty & Arti 2021)

F. Cara Kerja *Akupresure*

Suatu penyakit diidentifikasi didasarkan pada beberapa titik *akupresure/accupoint* yang ada pada aliran meridian. Pemijatan yang dilakukan pada titik-titik tersebut dapat menjadikan aliran energinya menjadi seimbang sehingga dapat menurunkan nyeri yang dirasakan. (Hanum, Sri Mukhodim. Widowati, Hesty & Arti 2021)

G. Teknik Manipulasi Pemijatan *Akupresure*

Teknik Pemijatan *Akupresure* adalah cara penekanan/pemijatan yang dilaksanakan atas dasar hasil pemeriksaan pasien serta diagnosa yang ditegakkan.

Teknik manipulasi penekanan *akupresure* terbagi 2 yaitu:

1. Teknik *Tonifikasi*/Penguatan
 - a. Penekanan dilaksanakan di titik *akupresure* yang sesuai paling lama 30 putaran/tekanan
 - b. Arah putaran searah dengan jarum jam
 - c. Pemijatan/tekanan yang dipakai sedang
 - d. Titik yang sesuai paling banyak 10 titik *akupresure*
 - e. Bila penekanan dilaksanakan di saluran meridian, arah penekanan harus searah dengan saluran lintasan meridian

2. Teknik Sedasi/Pelemahan

- a. Penekanan dilaksanakan di titik *akupresure* yang sesuai sebanyak 40-60 putaran/pijatan
- b. Arah putaran berlawanan dengan jarum jam
- c. Pijatan yang dipakai sedang hingga kuat
- d. Titik yang dipilih diselaraskan dengan kebutuhan
- e. Bila penekanan dilaksanakan di daerah aliran meridian, arah penekanan harus berlawanan arah dengan saluran lintasan meridian.

(Hanum, Sri Mukhodim. Widowati, Hesty & Arti 2021)

H. Jenis Akupresur

Salah satu jenis *akupresure* yaitu "Shiatsu". Shiatsu berasal dari Cina. Jepang mulai mengembangkan Teknik Shiatsu sejak tahun 1900-an.

Asal kata Shiatsu yaitu "Shi" yang artinya jari tangan, dan "Atshu" yang artinya menekan. Jadi dapat diartikan bahwa "Shiatsu" adalah penekanan pada *acupoint* dengan melakukan gosokan, tekanan, pijatan, tepukan, dan dipanaskan. Shiatsu dapat dipadu padankan dengan terapi magnetic yang bisa membuat otot relaks, melancarkan peredaran darah dan menyeimbangkan "Qi". (Hanum, Sri Mukhodim. Widowati, Hesty & Arti 2021)

I. Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan oleh Terapis sebelum Melaksanakan Akupresure

1. Cuci tangan menggunakan air dan sabun.
2. Lakukan pengkajian kepada klien tentang keadaan nadi, lidah
3. Lakukan observasi
4. Lakukan wawancara
5. Lakukan palpasi pada perut dan punggung
6. Gunakan baju yang tidak ketat dan berbahan lembut/halus
7. Lakukan pijatan dengan halus sepanjang meridian tangan, kaki, punggung, leher, dan kepala untuk membuka aliran energi. (manfaat melakukan pijatan dengan halus yaitu membuat klien berada dalam keadaan rileks)

(Putri, Dewi Murdiyanti & Amalia 2019)

J. Tujuan Terapi Shiatsu

Terapi Shiatsu mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

1. Keseimbangan energi dalam badan
2. Badan menjadi rileks
3. Meningkatkan energi
4. Keseimbangan hormon dalam badan

5. Meningkatkan sirkulasi serta mobilitas otot
6. Meningkatkan system imun
7. Menurunkan stress
8. Meningkatkan kesehatan fisik dan mental

K. Kondisi Pasien yang Dilarang untuk Terapi *Akupresure*

Beberapa penyakit yang dilarang diberikan terapi *akupresure* karena bisa mengakibatkan kematian mendadak antara lain:

1. Saat kejadian serangan jantung
2. Kegagalan Pernapasan
3. Penyakit syaraf otak, seperti stroke, gegar otak, pembuluh darah pecah.

Jika ditemukan gejala tersebut, lakukan rujukan ke RS karena kesalahan penanganan bisa berakibat keterlambatan memperoleh perawatan yang sesuai.

L. Tanggapan Masyarakat/Ibu Nifas Terhadap Terapi *Akupresure*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Susanti, NLP Dina, Nuartini, N. Miyuliati n.d.) menyatakan bahwa ibu nifas sudah pernah melakukan perawatan alternatif misalnya pijat, tetapi untuk terapi *akupresure* sendiri tidak terlalu mengenalnya. Sesudah dilakukan pelayanan *akupresure* dari Bidan, tanggapan ibu nifas sangat baik dan mempunyai persepsi bahwa *akupresure* sangat berguna dalam meningkatkan produksi ASI.

M. Larangan Pemijatan

Area yang tidak boleh dilakukan *akupresure* antara lain:

1. Area yang sakit
2. Badan panas
3. Flu berat
4. *Rematoid Arthritis*
5. Koma
6. Area kelamin
7. Kamar yang lembab

Keadaan klien yang tidak boleh dilakukan *akupresure*, antara lain:

1. Sangat lapar
2. Sangat kenyang
3. Terlalu lelah
4. Sedang marah
5. Sesudah berdonor darah
6. Sesudah berolah raga

N. Manfaat Akupresure pada Ibu Nifas

1. Meningkatkan Produksi ASI Ibu Menyusui

Beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa *akupresure* dapat meningkatkan produksi ASI ibu menyusui, antara lain:

- a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fetrisia 2019) yang meneliti tentang "Pengaruh *Acupresure Point For Lactation* Terhadap Produksi ASI Ibu Menyusui" bahwa ada beberapa manfaat Teknik *Acupresure Points For Lactation* antara lain:

- 1) Membantu mengoptimalkan reseptor prolaktin serta oksitosin dan meminimalisasi *side effect* dari tertundanya proses menyusui oleh bayi.

- 2) Membantu peningkatan perasaan tenang pada ibu nifas

Acupresure points for lactation melalui titik meridian sesuai dengan organ yang akan dituju dapat membantu mengurangi rasa ketidaknyamanan.

Akupresure dapat berdampak meningkatnya kadar endorfin dalam darah maupun sistemik. Stimulasi *akupresure* bisa membawa hubungan substansi untuk pelepasan zat yang mampu menghambat sinyal rasa sakit ke otak. Efek rangsangan titik *akupresure* bisa lewat syaraf dan bisa melalui *transmitter humoral* yang belum bisa dijelaskan secara detail.

- 3) Membantu peningkatan *comfort* dan produksi ASI pada ibu nifas

Acupresure points for lactation setiap dua hari sekali selama dua pekan (6 x *akupresure*).

Terdapat 3 titik pokok yang akan dilakukan pijatan/tekanan pada payudara yaitu:

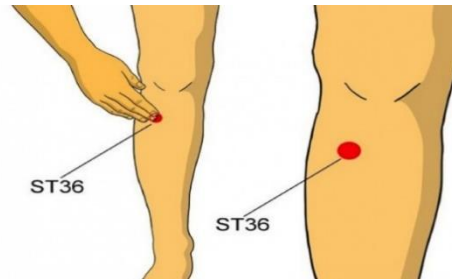
- a) Satu titik di atas puting
- b) Tepat di puting payudara
- c) Titik di bawah puting.



Gambar 2.2

Titik Akupresur untuk Produksi ASI pada Ibu Menyusui
(Hanum, Sri Mukhodim. Widowati, Hesty & Arti 2021)

Apabila *akupresure* ini diberikan secara rutin dan benar, usaha ini dapat melancarkan produksi ASI. Selain titik-titik di payudara, titik di bawah lutut (titik ST 36) juga dapat membantu kelancaran ASI. (Rahayu (2015)



Gambar 2.3

Titik *Akupresure* ST 36

Sumber: (Verina 2022)

b. Pengaruh Akupresur Terhadap Produksi Air Susu Ibu (ASI)

Menurut (Wulandari, Hasanah, and Sabrian 2019) , ada Teknik-teknik atau cara lain untuk merangsang produksi ASI antara lain dengan memakan daun katuk dan teknik *akupresure* yang bisa merangsang hormon prolaktin dan oksitosin (Wong, 2012). *Akupresure* itu bisa memberi perintah pada hipofisis untuk mengeluarkan hormon prolaktin dan oksitosin.

- 1) Hasil penelitian yang dilakukan Wulandari didapatkan bahwa ada pengaruh *akupresure* terhadap produksi air susu ibu, di mana *akupresur* dapat meningkatkan produksi ASI sebesar 3,00 poin.

Hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini, antara lain:

- a) Hasil penelitian Djanah dan Muslihatun (2015), didapatkan bahwa ada perbedaan antara produksi ASI yang diberikan *akupresur* dibandingkan dengan tidak diberikan *akupresur*.
- b) Hasil penelitian Susilawati dan Halim (2018) menyatakan bahwa ada perbedaan antara produksi ASI sebelum dan setelah dilakukan intervensi akupresur yang meningkat menjadi 46,8%.

c. Produksi ASI Ibu dengan Intervensi *Acupresure Point For Lactation* dan Pijat Oksitosin (*The Difference in Breastmilk Production between Acupresure Point for Lactation and Oxytocin Massage*)

- 1) Hasil penelitian bahwa peneliti melakukan intervensi *acupresure point for lactation* dan pijat oksitosin untuk meningkatkan produksi ASI dengan pendekatan *comfort theory* dari Kolcaba.

- a) Teknik *acupresure points for lactation*

Manfaat Teknik *acupresure points for lactation* antara lain:

- 1) Untuk mengatasi ketidaklancaran produksi ASI (Anamed, 2012).
- 2) Dapat membantu memaksimalkan reseptor prolaktin dan oksitosin serta meminimalkan efek samping dari tertundanya proses menyusui oleh bayi (Evariny, 2008).
- 3) Dapat meningkatkan perasaan rileks
- 4) Dapat membantu mengurangi rasa ketidaknyamanan
- 5) Dapat meningkatkan kadar endorfin dalam darah maupun sistemik.
- 6) Dapat membawa hubungan substansi untuk pelepasan zat yang mampu menghambat sinyal rasa sakit ke otak.
- 7) Dapat melalui saraf dan dapat melalui transmitter humoral yang belum dapat diterangkan dengan jelas (Garret et al. 2003, dalam Apriany, 2010; Saputra, 2000).

Teori neurotransmitter yang menghasilkan endorfin yaitu dengan memengaruhi area otak, menstimulasi sekresi beta-endorphin dan enkepalin pada otak dan *spinal cord*. Pelepasan neurotransmitter memengaruhi sistem imun dan sistem antinoceptive. (Saputra, 2000).

Endorfin merupakan opiat tubuh secara alami dihasilkan oleh kelenjar pituitary yang berguna untuk mengurangi nyeri, memengaruhi memori dan *mood* yang kemudian akan memberikan perasaan rileks (Tuner, 2010 dalam Apriany, 2010). (Rahayu, Dwi, Santoso, Budi & Yunitasari 2015)

b) Pijat oksitosin

1) Pengertian

Menurut (Biancuzzo, 2003; Yohmi & Roesli, 2009) dalam (Rahayu, Dwi, Santoso, Budi & Yunitasari 2015), Pijat oksitosin yaitu tekanan/pijatan yang dilakukan di sepanjang tulang belakang (*vertebrae*) sampai tulang *costae* kelima-keenam dan merupakan upaya untuk menstimulasi hormon prolaktin dan oksitosin setelah persalinan

2) Fungsi Pijat Oksitosin

- (a) Untuk meningkatkan hormon oksitosin yang mampu membuat ibu tenang sehingga merangsang ASI keluar.
- (b) Meningkatkan kenyamanan.

Menurut Kolcaba, perawatan untuk meningkatkan kenyamanan membutuhkan sekurang-kurangnya 3 tipe intervensi *comfort* yaitu: teknis pengukuran kenyamanan, *coaching* (mengajarkan) dan *comfort food for the soul* (Kolcaba, 2011). Pada penelitian ini, intervensi yang digunakan

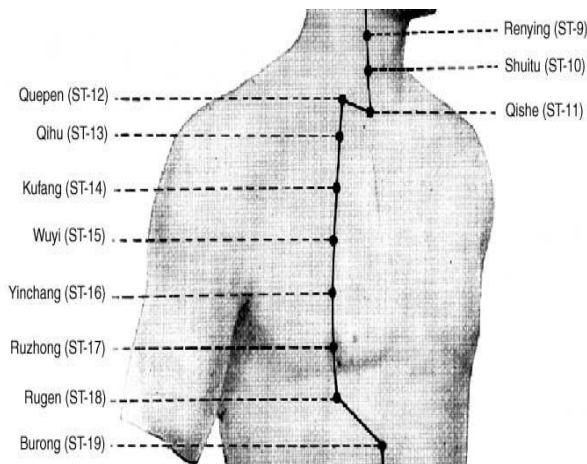
oleh peneliti yaitu *comfort food for the soul*, terapi untuk kenyamanan pasien yang meliputi pemijatan. Dalam hal ini peneliti mengaplikasikan teknik *acupressure point for lactation* dan pijat oksitosin untuk memberikan stimulasi kutaneus yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan klien, menstimulasi keluarnya oksitosin, sehingga terjadi peningkatan produksi ASI.

d. Efektivitas *Akupresure* terhadap Produksi ASI pada Masa Nifas

- 1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Renityas, (2020) menunjukkan bahwa ada perbedaan kritis dalam perawatan ASI sebelum perawatan.

Pijat titik tekan yang diakhiri dengan gosokan punggung kanan, selama 5-10 menit dan rutin 3x dalam beberapa minggu dapat meningkatkan produksi ASI dan dapat memicu datangnya zat kimia prolaktin dan oksitosin.

Titik meridian itu sendiri, sesuai penelitian Renityas, (2020) dilakukan pada tanda bagian tengah tubuh, khususnya ST 16 (di atas areola), 17 (berdekatan dengan areola), dan 18 (di bawah areola).



Gambar 2.4

Titik Akupresur ST 16, 17 dan 18

Sumber: (Sukarno 2014)

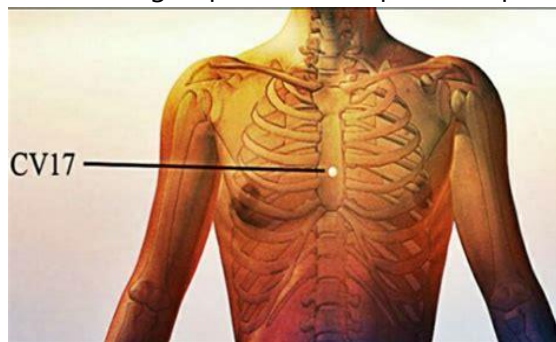
- 2) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fetrisia & Yanti, (2019) ada peningkatan tergantung pada eksplorasi yang dirujuk tidak hanya pada ruang di mana pijatan punggung dilakukan tetapi juga fokus pada hal utama untuk bekerja dengan menyusui, khususnya langsung pada areola, satu titik di bawahnya areola, satu titik di atas areola, dan satu titik di atas areola. ST 36 fokus di bawah lutut.

- 3) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadani et al., (2019) metode pijat titik tekan yang dilakukan dengan aman, tidak melukai kulit, dan tidak membuat urat.

Tanda tengah ST adalah 15, 16, 18 untuk curah susu dada.

- 4) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulymbona et al., (2020) efek samping dari penyelidikan.

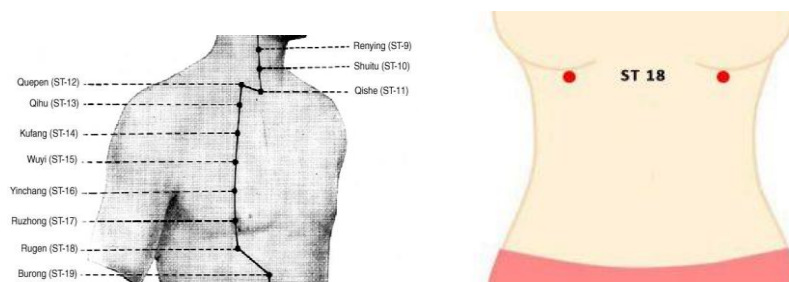
Kelompok yang tidak diberi pijat titik tekan mengalami peningkatan produksi ASI yang tidak signifikan, sedangkan kelompok yang diberi pijat titik tekan mengalami peningkatan yang signifikan. Pijat titik tekan pada fokus CV17, ST18, SI 1 dengan pengulangan 3 kali setiap minggu selama tiga minggu dapat membangun produksi ASI pada ibu pasca kehamilan.



Gambar 2.5

Titik *Akupresure* CV 17

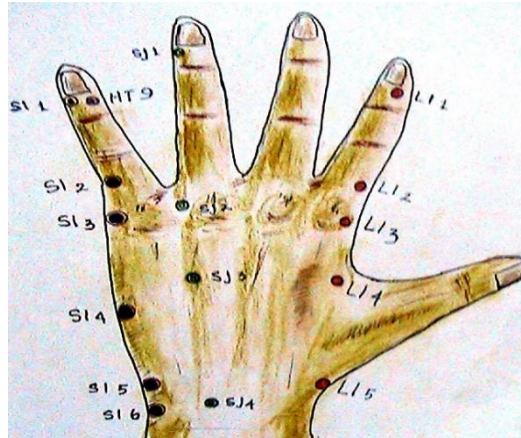
Sumber: (Syafaatfmz 2018)



Gambar 2.6

Titik *Akupresure* ST 18

(Massager 2021)



Gambar 2.7

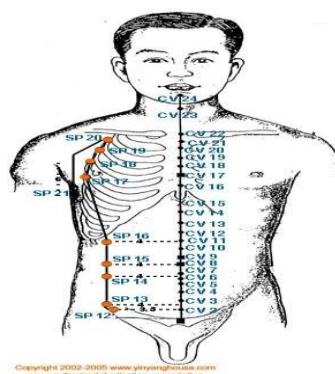
Titik *Akupresure* SI 1

Sumber: (Josep 2017)

Pemijatan titik penekan adalah tanda produksi susu dimana rangsangan pemijatan titik penekan akan dialirkan ke tulang belakang atau vertebra dan serebrum melalui saraf akson sehingga akan ada sinyal penghasutan di tempat pikiran. Pemberlakuan sistem sensorik fokus menyebabkan perubahan bahan kimia, kerangka tahan, dampak biomekanik, dan sebagainya.

Jadi motivasi di balik pijat titik tekanan itu sendiri adalah untuk bekerja dengan meridian qi dalam tubuh manusia. Untuk dapat memfasilitasi produksi ASI pada ibu pasca kehamilan, penting untuk memuluskan penggunaannya dengan area yang memiliki area pijat titik tekanan.

Lakukan penekanan titik pijat gosok dengan pijatan punggung ringan ke arah memutar dada ke luar dengan fokus meridian ST 15, ST 16, ST 18, CV 17, ST 36, SI 1, dan pada titik meridian SP 18 faktor penekanan meridian diperkuat (KEMENKES RI, 2014, 2015).



Gambar 2.8

Titik *Akupresure* SP 18

Sumber: (Xym n.d.)

- 5) Pijatan pada titik tekan yang dilakukan pada titik fokus ST 15, ST 16, ST 18, CV 17, ST 36, SI 1, dan pada titik meridian SP 18 dapat memicu masuknya zat kimia prolaktin dan oksitosin sehingga akan membentuk ASI. (Dapat dilihat pada gambar di atas).

Bila pijatan titik tekan dilakukan secara konsisten maka produksi ASI akan meningkat sehingga anak dapat memenuhi kebutuhan ASInya. Hal ini menunjukkan bahwa pijat titik tekanan memengaruhi produksi ASI yang berkembang pada ibu pasca kehamilan.

Kelangsungan pijat titik tekan pada pembuatan ASI adalah sesuai dengan audit penulisan hasil pemeriksaan oleh Masdinarsah et al, (2019). Metode ini dapat dilakukan pada SI 1 (ujung kuku kelingking), LI 4 (antara telunjuk dan ibu jari), dan ST 18 (tulang rusuk kelima tepat di bawah areola).

- 6) Hasil penelitian (Wulandari, Hasanah, and Sabrian 2019) didapatkan pengaruh pijat titik tekan terhadap peningkatan takaran ASI, sedangkan pada kelompok yang tidak diberi pijat titik tekan takaran ASI tidak bertambah.

Konsekuensi dari penelitian ini, pijat titik tekan pada fokus ST 15, ST 16 dan LI 4 dapat diresepkan untuk ibu menyusui untuk membangun produksi ASI. Berdasarkan hipotesis D. Rahayu, Santoso, & Esti Yunitasari (2015) ibu yang diberikan perawatan pijat titik tekan dengan fokus meridian bekerja dengan produksi ASI sangat berpengaruh pada ibu menyusui, ibu menyusui yang diberikan perawatan pijat titik tekan terasa bahwa mereka lebih longgar, menyenangkan, dan menyebabkan keyakinan bahwa ibu dapat mengalahkan produksi susu yang tidak lancar.

Menurut Apriany (2010), pijat titik tekanan dapat menghidupkan hubungan zat dengan kedatangan zat yang dapat menahan tanda-tanda siksaan ke otak besar. Dampak ini dapat menghidupkan fokus pijat titik tekanan melalui saraf dan melalui pemancar humoral. Pijat titik tekanan juga dapat membangun sensasi bersantai dan mengurangi stres pada ibu pasca kehamilan. Pijat titik tekanan dapat memperkuat titik akupunktur di mana fokus ini dapat membantu mengelola siklus involusi uterus dan keluarnya ASI serta membangun kembali keharmonisan selama periode pasca kehamilan (Rahayu (2015).

- 7) Menurut dokter spesialis, meremas titik tengah ST 1, LI 4 dan ST 18 dapat memperbanyak zat prolaktin dan membuat ibu lebih rileks, sehingga produksi ASI dapat meningkat.

Strategi ini berhasil memperluas produksi ASI. Pijat titik tekan adalah sistem yang tidak mengganggu, mudah dilakukan, memiliki hasil yang dapat diabaikan, selain itu pijat titik tekan juga dapat mendekatkan

hubungan perbaikan antara pelanggan dan asisten bersalin sehingga spesialis bersalin dapat berubah menjadi pengumpulan informasi dalam menerapkan perawatan pijat titik tekan pada ibu agar produksi dan penggunaan ASI meningkat.

Kelangsungan pemijatan titik tekan pada produksi ASI sesuai dengan penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa adanya pengaruh yang efektif *akupresure* terhadap peningkatan produksi ASI ibu nifas sehingga *akupresure* dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan produksi ASI secara optimal karena aman, efektif, dan dapat dipelajari oleh siapa saja. (Saputri 2021)

2. Menurunkan Tekanan Darah serta Jumlah Perdarahan Pada Ibu Nifas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sarli, Desi & Putri 2020) bahwa *akupresure* dapat menurunkan tekanan darah dan jumlah perdarahan pada ibu nifas. Berikut ini adalah penjelasannya:

- a. Terdapat pengaruh *Acupressure Point GB 21* terhadap Tekanan Darah Sistolik pada ibu 2 jam *postpartum*

Pengaruh *Acupressure Point GB 21* terhadap Tekanan Darah Sistolik pada ibu 2 jam *postpartum* lebih rendah pada kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Rata-rata tekanan darah sistolik pada kelompok intervensi adalah 112,50 mmHg sedangkan pada kelompok kontrol 118,44 mmHg. Hasil uji statistik diperoleh nilai p value < 0,05. Menurut penelitian yang dilakukan Fitriani (2015) dalam (Sarli, Desi & Putri 2020), sekarang ini terapi yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi diupayakan dengan bermacam-macam cara, yang salah satunya yaitu dengan teknik *akupresure*.

Teknik *akupresure* memiliki dampak pada kelancaran sirkulasi darah, dapat menjaga keseimbangan aliran energi di dalam badan serta melemaskan ketegangan ketegangan otot. Menurut penelitian (Sarli, Desi & Sari 2018) menyatakan bahwa Penekanan/pijatan mengatur sistem syaraf otonom sehingga dapat menurunkan kadar kortisol, adrenalin, dan noradrenalin. Hal ini juga bisa menyesuaikan aktifitas syaraf, otak frontal, dan jaringan kontrol. Selain itu, pijat merangsang sensorik serat aferen di kulit, yang memengaruhi tubuh dan pikiran manusia. Tekanan intermiten diterapkan selama pijat meningkatkan sirkulasi darah dan drainase limfatik, yang menyebabkan perubahan denyut jantung dan tekanan darah.

- b. Beberapa penelitian yang mendukung hasil penelitian di atas antara lain:
 - 1) Penelitian yang dilakukan oleh (Sarli, D & Agus 2014) menyatakan bahwa ibu yang melahirkan yang dipijat otot tulang belakangnya dapat

mengurangi jumlah perdarahan *postpartum*. Jumlah perdarahan minimal pada ibu 2 jam *postpartum* sebanyak 110 ml dan jumlah perdarahan maksimal sebanyak 385 ml dengan rata-rata jumlah perdarahan ibu 2 jam *postpartum* adalah 211.03 ml.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, Diyah & Iswari 2016) menyatakan bahwa nyeri yang terjadi selama persalinan disebabkan karena kontraksi uterus, dilatasi dan penipisan serviks, serta penurunan janin selama persalinan. *Akupresure* bisa memperlancar proses kelahiran sebab meningkatkan efektifitas kontraksi uterus, sehingga dapat mencegah perdarahan pada kelahiran.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh (Anuhgera, Kuncoro, Sumarni, Mardiyono 2017) didapatkan hasil bahwa pemijatan yang dilakukan pada ibu *postpartum* dapat meningkatkan kadar hormon prolaktin dan oksitosin, sehingga akan mencegah terjadinya perdarahan pada ibu nifas dan meningkatkan produksi ASI.

Akupresure yang dilakukan pada titik GB 21, terjadi stimulasi pada Korda spinalis yang berfungsi untuk menghubungkan syaraf antara otak dan sistem syaraf perifer. Seluruh komunikasi ke atas dan ke bawah korda spinalis berada di jaras-jaras (*tractus*) *ascendens* yang menyalurkan sinyal dari masukan aferen ke otak. Substansia grisea yang terletak di tengah korda spinalis mengandung penghubung antarneuron yang terletak antara masukan aferen dan keluaran eferen serta badan sel neuron eferen. Serat aferen dan eferen, yang masing-masing membawa sinyal ke dan dari korda spinalis, menyatu menjadi saraf spinalis. Saraf-saraf ini melekat ke korda spinalis berpasangan di sepanjang korda. Neuron inhibitorik dan neuron kolimergik eksitatorik membuat kontak sinaps dengan neuron oksitosin neurosekretorik di nucleus paraventrikularis dan supraoptikus. Kemudian hipotalamus memproduksi hormon oksitosin dan dialirkan menuju hipofisis posterior, oksitosin menuju ke uterus maka mioendometrium akan mengalami kontraksi sehingga merangsang terjadinya kontraksi dan mengurangi jumlah perdarahan pada kala IV. (Sarli, Desi & Putri 2020)

DAFTAR PUSTAKA

- Anuhgera, Kuncoro, Sumarni, Mardiyono, Suwondo. 2017. "Hypnotherapy Is More Effective than Acupressure in the Production of Prolactin Hormone and Breast Milk among Women Having given Birth with Caesarean Section." *Medicine Science International Medical Journal* 7(1): 25–29.
- Fetrisia, Wiwit & Yanti. 2019. "Pengaruh Acupressure Point For Lactation Terhadap Produksi ASI Ibu Menyusui." *Jurnal Kesehatan* 10(01): 41–46.
- Hanum, Sri Mukhodim. Widowati, Hesty & Arti, Widi. 2021. *Akupressure Untuk Ibu Dan Anak*. ed. Herista Novia Wildanti. Sidoarjo.
- Josep. 2017. "Akupunktur Akupresur Nanjing Jakarta Selatan." 08 April 2017. <https://akupunkturakupresurnanjing.blogspot.com/2017/04/pijat-energy-qi-4.html>.
- Massager, Peak. 2021. "ST 18 ACUPUNCTURE POINT(RUGEN) OR STOMACH 18." 31 Maret 2021. <https://www.peakmassager.com/st-18-acupuncture-point/>.
- Putri, Dewi Murdiyanti & Amalia, Rahmita Nuril. 2019. *Terapi Komplementer Konsep Dan Aplikasi Dalam Keperawatan*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Rahayu, Dwi, Santoso, Budi & Yunitasari, Esti. 2015. "Produksi ASI Ibu Dengan Intervensi Acupressure Point For Lactation Dan Pijat Oksitosin." *Jurnal Ners* 10(1): 9–19.
- Rahmawati, Diyah & Iswari, Indra. 2016. "Efektivitas Akupresur Selama Persalinan (Studi Tinjauan Pustaka)." *Jurnal Ilmiah Bidan* 1(2): 14–18.
- Saputri, Retno Dwi. 2021. "Efektivitas Akupresur Terhadap Produksi ASI Pada Masa Nifas." Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang.
- Sarli, D & Agus, M. 2014. "Research Articles The Effect of Differences Oxytocin Levels Through Oxytocin Massage Against Number of Bleeding in Mother 2 Hours Postpartum." *Jurnal Kesehatan Andalas* 4(3): 743–50.
- Sarli, Desi & Putri, Arfianingsih Dwi. 2020. "Acupressure Point Gall Bladder 21 (Gb21) Terhadap Tekanan Darah Dan Jumlah Perdarahan Pada Ibu Postpartum." *Jurnal Ilmu Kesehatan* 4(2): 89–94.
- Sarli, Desi & Sari, F.N. 2018. "The Effect of Massage Therapy with Effleurage Techniques as A Prevention of Baby Blues Prevention on Postpartum Mother." *International Journal of Advancement in Life Sciences Research* 1(3): 15–21.
- Sukarno. 2014. "Akupunktur Untuk Asma." 17 September 2014. <https://meridianlimaunsur.blogspot.com/2014/09/akupunktur-untuk-asma-paru-meridian.html>.
- Susanti, NLP Dina, Nuartini, N. Miyuliaty, N. "Penerimaan Ibu Nifas Terhadap Terapi Akupresur Untuk Meningkatkan Produksi ASI Ditinjau Dari Sudut Penerima Dan Pemberi Layanan Di Puskesmas Tabanan III."

- Syafaatfmz. 2018. "Tekan Titik Ini Untuk Redakan Stres Dan Kecemasan Dalam Sekejap Artikel Ini Sudah Tayang Di VIVA.Co.Id Pada Hari Senin, 21 Mei 2018 - 07:30 WIB Judul Artikel : Tekan Titik Ini Untuk Redakan Stres Dan Kecemasan Dalam Sekejap Link Artikel : <https://www.viva.co.id/blog/kesehatan/1038112-tekan-titik-ini-untuk-redakan-stres-dan-kecemasan-dalam-sekejap>.
- Verina, Christine. 2022. "Akupunktur: Jenis, Prosedur, Dan Efek Samping." <https://idnmedis.com/akupunktur>.
- Wulandari, Aydia, Oswati Hasanah, and Febriana Sabrian. 2019. "PENGARUH AKUPRESUR TERHADAP PRODUKSI AIR SUSU IBU (ASI)." *Jurnal Ners Indonesia* 1: 51–60.
- Xym, Krizek. "Meridian Acupuncture."

BAB 3

PIJAT *ENDORPHIN* PADA IBU NIFAS

Dewi Andariya Ningsih, S.ST., M. Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 3

PIJAT *ENDORPHIN* PADA IBU NIFAS

Oleh: Dewi Andariya Ningsih, S.ST., M. Keb

A. Pendahuluan

Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan pemberian ASI eksklusif untuk bayi baru lahir sejak hari pertama kehidupan hingga anak berusia 6 bulan. Karena mengandung begitu banyak nutrisi yang baik untuk kesehatan dan pertumbuhan bayi. ASI merupakan makanan tunggal terbaik untuk bayi baru lahir (BBL) dan sangat penting untuk kesejahteraan bayi. Kolostrum yang mengandung imunologi aktif termasuk IgA, IgM, IgD, IgG, dan IgE dalam jumlah besar yang berfungsi sebagai antibodi terhadap agen infeksi seperti kuman, bakteri, dan virus, dapat mencegah dan menurunkan risiko kematian pada BBL, merupakan mayoritas ASI. Namun, produksi ASI yang teratur dapat mengganggu pemberian ASI eksklusif.

Pengeluaran ASI secara fisiologis selama kehamilan dan pengeluaran ASI dua hingga tiga hari setelah melahirkan, keduanya dapat dianggap normal. Jika susu diproduksi untuk jangka waktu yang lebih lama, itu termasuk dalam area patofisiologi dan membutuhkan perawatan lebih. Ibu yang menjalani operasi *Section Caesarean* (SC) atau tidak melahirkan secara alami sering kali mengalami penurunan produksi ASI secara teratur, sehingga mempersulit mereka untuk menyusui bayinya secara eksklusif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menemukan bahwa ibu yang melahirkan secara SC memiliki risiko kematian 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang melahirkan secara alami, lebih mungkin menghadapi tantangan dalam kelancaran produksi ASI karena pasca melahirkan. Ibu operasi kedua bayi lahir melalui operasi *caesar* dan prosedurnya masih membutuhkan waktu observasi.

B. Pemberian ASI

Pemberian ASI eksklusif merupakan standar emas pemberian makanan bayi pada enam bulan pertama. Di Indonesia, praktik menyusui telah menjadi norma sosial di kalangan perempuan. Namun, beberapa wanita mengalami produksi ASI yang tidak mencukupi, terutama pada hari pertama dan kedua setelah melahirkan. Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi alami terbaik bagi bayi karena mengandung kebutuhan energi dan zat yang dibutuhkan selama enam bulan pertama kehidupan bayi. Semua kebutuhan nutrisi yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral dipenuhi oleh ASI. ASI dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Pada hari-hari pertama kehidupan bayi, tidak sedikit ibu yang mengalami masalah dalam menyusui bayinya karena masalah produksi ASI. Hal ini dikarenakan masih adanya hormon kehamilan seperti estrogen yang menekan

produksi ASI, oleh karena itu untuk mencegah kegagalan menyusui dini diperlukan upaya percepatan pemberian ASI. Menyusui melindungi bayi dari banyak penyakit, dan manfaat kesehatan bagi perempuan telah didokumentasikan dengan baik. Masalah menyusui seperti saluran yang tersumbat, pembengkakan payudara dan mastitis adalah komplikasi utama yang menyebabkan penurunan tingkat menyusui. Pijat payudara dapat menghilangkan rasa sakit dan mengatasi gejala yang terkait dengan kondisi yang menyebabkan penghentian menyusui.

C. ASI

ASI adalah nutrisi terpenting bagi bayi terutama pada fase pertama kehidupan bayi (6). Pemberian ASI pada hari pertama setelah bayi lahir dapat menurunkan risiko kematian bayi lahir dini hingga 45%. Di Tanzania, Kilimanjaro, pemberian ASI eksklusif efektif terhadap kematian bayi 13% sampai 15%. Nutrisi yang cukup selama masa bayi akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang cepat selama periode emas. Pemberian asuhan kebidanan pada ibu menyusui juga merupakan asuhan yang diberikan oleh bidan secara berkesinambungan. Saling berhubungan sejak kehamilan sampai proses menyusui. Banyak faktor yang dapat memengaruhi pemberian ASI yaitu dari internal dan eksternal. Kegagalan proses menyusui sering kali disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor ibu yang utama adalah kurangnya produksi ASI sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis. Ibu yang bermasalah dengan kondisi psikologisnya dengan berbagai bentuk ketegangan emosi akan menurunkan volume atau bahkan menghentikan produksi ASI. Kurangnya produksi ASI pada hari-hari pertama setelah melahirkan dapat disebabkan oleh kurangnya stimulasi hormon prolaktin dan oksitosin yang berperan dalam kelancaran produksi ASI. Beberapa cara yang dapat meningkatkan produksi ASI ibu nifas antara lain terapi non farmakologi seperti penggunaan jamu, akupunktur, pijat dan penggunaan daun kubis. Terapi pijat dapat dilakukan secara sederhana sesuai kebutuhan ibu nifas. Beberapa jenis pijat mempunyai manfaat dan dapat memperlancar proses laktasi. Perawatan payudara untuk meningkatkan produksi ASI. Selain itu, pijat laktasi dan endhoprin merupakan solusi untuk mengatasi ketidakcukupan produksi ASI. pijat endhoprin adalah teknik yang memberikan rasa tenang dan kenyamanan yang dapat meningkatkan pelepasan hormon endhoprin. Hal ini termasuk sentuhan dan pijatan ringan di seluruh tubuh.

Terapi pijat dapat dilakukan secara sederhana sesuai dengan kebutuhan ibu nifas. Terapi pijat merupakan intervensi yang mudah dan aman untuk dilakukan pada ibu nifas. Intervensi ini juga dapat dilakukan oleh suami atau keluarga pasien setelah dilatih oleh bidan/tenaga kesehatan. Pijat laktasi yang dilakukan pada ibu menyusui akan merangsang otot-otot pembuluh darah di payudara untuk merangsang hormon prolaktin dalam memproduksi ASI. Selain itu, pijat laktasi akan membuat

payudara lebih bersih, lembut dan elastis sehingga akan memberikan kenyamanan pada bayi untuk menyusui (Jahriani, 2019). Dalam keadaan tertentu pijat laktasi dapat dilakukan untuk merangsang produksi ASI, misalnya membantu proses induksi menyusui untuk adopsi/ibu angkat/tidak pernah menyusui. Dengan pijat di beberapa titik, terutama di area payudara, pijat laktasi dapat meningkatkan produksi ASI dibandingkan dengan pijat oksitosin.

Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapitria yang menyatakan bahwa jaringan payudara banyak mengandung pembuluh limfa dan pembuluh darah, pembuluh yang tersumbat menjadi penyebab kurang lancarnya produksi dan aliran ASI. Dalam hal ini, sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan penulis bahwa pijat laktasi merupakan teknik pijat yang lebih efektif dalam meningkatkan produksi ASI (Hapitria, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri dkk. menyebutkan tulang belikat merupakan daerah ketegangan otot pada wanita, sehingga pemijatan dilakukan pada daerah tersebut untuk merelaksakan atau menghilangkan stres. Saat tulang belakang dipijat, refleks *neurogenik* itu mempercepat kerja saraf parasimpatis untuk menyampaikan perintah ke bagian belakang otak. Sebagai hasil dari sinyal stimulasi, respons oksitosin dilepaskan ke dalam darah sistemik dari hipofisis posterior. Aliran darah oksitosin dialirkan ke sel-sel mioepitel di sekitar alveolus, oksitosin merangsang sel-sel tersebut sehingga kantung alveolus tertekan, tekanan naik, duktus memendek dan melebar. Kemudian saat puting dihisap, ASI keluar lebih cepat dari kelompok kontrol (Safitri et al., 2015).

Metode pijat lainnya, selain metode pijat punggung yaitu pijat Endorphin. Selama ini Endorphin dikenal sebagai zat yang memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya adalah mengatur produksi hormon pertumbuhan dan seks, mengendalikan rasa sakit dan nyeri yang terus-menerus, mengendalikan perasaan stres, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Seorang dokter kandungan, Constance Palinsky bergerak menggunakan pijat Endorphin untuk menormalkan detak jantung, tekanan darah, dan meningkatkan kondisi rileks di tubuh ibu hamil dengan memicu rasa nyaman melalui permukaan kulit (Irawati, 2018).

Terdapat dua hormon yang bekerja untuk mempertahankan proses laktasi pada saat setelah melahirkan, yaitu hormon prolaktin untuk meningkatkan sekresi ASI dan hormon oksitosin yang menyebabkan keluarnya ASI (15). Hormon oksitosin berfungsi mengencangkan otot polos di sekitar alveoli untuk memeras ASI ke dalam saluran ASI dan berperan dalam proses pengeluaran ASI/refleks pengeluaran ASI. Salah satu terapi nonfarmakologi yang dapat merangsang pelepasan hormon oksitosin adalah pijat punggung atau pijat oksitosin pada ibu menyusui. Banyak upaya telah diusulkan untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu *postpartum* seperti teknik relaksasi, dukungan psikologis dan terapi *acupoint-tuina*. Berbagai

teknik pemijatan dikenal sebagai alat ampuh untuk meningkatkan produksi ASI Termasuk Pijat Payudara, Pijat Oksitocin Dan Pijat Endorphen.

Endorphen Massage merupakan pijatan ringan yang memberikan efek nyaman pada ibu. Sentuhan ringan yang diberikan pada leher, punggung, dan lengan saat *endorphen massage* akan merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan hormon *endorphen* yang akan membantu pelepasan hormon oksitosin untuk mempercepat ekskresi kolostrium. Selama ini penggunaan *endorphen massage* banyak digunakan untuk manajemen nyeri, kecemasan saat persalinan, dan untuk membantu involusi uterus. *Endorphen massage* merupakan teknik yang memberikan rasa tenang dan nyaman yang dapat meningkatkan pelepasan *hormon endorphen*, oleh karena itu dinamakan *endorphen massage*. Ini termasuk sentuhan dan pijatan ringan di seluruh tubuh. Pijat *Endorphen* awalnya dikembangkan oleh Constance Palinsky sebagai metode pengendalian nyeri. Ibu yang merasa nyaman dan rileks akan mempertahankan produksi dan sekresi ASI yang cukup.

Beberapa studi nyeri punggung telah muncul dalam literatur yang membandingkan terapi pijat dengan bentuk pengobatan komplementer lainnya. Studi yang sering tentang pijatan nyeri punggung mungkin berhubungan dengan tingginya insiden nyeri punggung bawah dibandingkan dengan bentuk nyeri lainnya. Dalam satu penelitian, wanita dengan nyeri punggung bawah kronis secara acak ditugaskan untuk terapi pijat atau kelompok terapi fisik. Latihan peregangan ditambahkan ke terapi pijat dan terapi fisik.

D. Analisis Data

Analisis data mengungkapkan bahwa peserta terapi pijat mengalami penurunan intensitas nyeri dan kecacatan yang lebih besar daripada kelompok terapi fisik. Hasil ini mungkin berhubungan dengan terapi fisik yang dikombinasikan dengan peregangan menjadi olahraga yang lebih berat. Memiliki rangsangan langsung pada kulit versus dipijat dengan pakaian lengkap juga mengacaukan perbandingan. Dalam perbandingan yang lebih cocok antara pijat struktural (goyang dan peregangan) versus pijat relaksasi (membelai), kelompok tidak berbeda pada gejala nyeri punggung yang dilaporkan sendiri. Namun, sekali lagi, rentang gerak tidak diukur. Dalam penelitian ini membandingkan pemijatan versus terapi relaksasi, kelompok pemijat menunjukkan peningkatan fleksi tubuh (menyentuh jari kaki hingga titik nyeri dan menyentuh jari kaki hingga titik tidak nyeri) serta nyeri, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur yang dilaporkan sendiri berkurang setelahnya. 5 minggu dua kali seminggu pijat 30 menit.

E. *Endorphin Massage*

Endorphin massage adalah rangsangan ringan pada leher, lengan dan punggung mulai dari tulang rusuk sampai 5-6 memanjang kedua sisi tulang belakang sampai ke tulang belikat yang akan mempercepat kerja saraf parasimpatis, yaitu saraf yang berasal dari medulla oblongata dan di daerah sacrum. sumsum tulang belakang, merangsang hipofisis posterior untuk melepaskan oksitosin, oksitosin merangsang kontraksi ion sel-sel otot polos yang mengelilingi kelenjar susu menyebabkan kontraksi mioepitel payudara sehingga meningkatkan produksi susu dari kelenjar susu. Pijat oksitosin dapat dilakukan 1-2 hari setelah melahirkan, sebelum ibu menyusui dan dapat diulangi beberapa kali setelah ibu menyusui. Pijat oksitosin dapat dilakukan beberapa kali sehari dengan pijatan selama 3-5 menit. Efek pijat oksitosin dapat dilihat pada reaksi dalam waktu 6-12 jam setelah pijat. Dengan pijatan di daerah tulang belakang ini juga akan meredakan ketegangan dan menghilangkan stres sehingga hormon oksitosin akan keluar dan akan membantu keluarnya ASI, dibantu dengan isapan bayi pada puting susu segera setelah bayi lahir dengan bayi normal. kolostrum yang menetes atau keluar merupakan tanda aktifnya refleks oksitosin.

Hidayati mengungkapkan *Endorphin Massage* dapat meningkatkan pelepasan oksitosin dan *Endorphin* serta menurunkan kadar hormon stres dalam darah. Ia juga mengungkapkan *endorphin massage* dapat meningkatkan kadar beta endorphin sebesar 688,5 ng/l ($p < 0,05$). Jadi, dengan peningkatan beta *Endorphin* ini, relaksasi akan terjadi, dimana terjadi vasodilatasi pembuluh darah yang dapat mempercepat suplai darah yang membawa oksitosin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin sering ibu melakukan pemijatan maka proses involusi uterus akan semakin cepat.

F. *Rapaport*

Rapaport mengungkapkan jika pemijatan dilakukan satu kali per minggu dapat menyebabkan perbedaan oksitosin. Namun jika dilakukan dua kali seminggu maka akan semakin meningkatkan oksitosin. Pengulangan pijat dikaitkan dengan perubahan kadar oksitosin. Kelompok pijat rata-rata memiliki kadar oksitosin yang stabil dan penurunan hormon adenokortikotropin Rata-rata kadar oksitosin pada kelompok 27,6 + SD 35,5 pg/ml, sedangkan pada kelompok dengan pijatan lembut rata-rata kadar oksitosin 80,1 + SD 42 pg/ml. Pijat oksitosin memiliki banyak manfaat dalam proses menyusui, antara lain mengurangi stress pada ibu nifas, mengurangi nyeri pada tulang belakang, merangsang kerja hormon oksitosin, meningkatkan kenyamanan, meningkatkan pergerakan ASI ke payudara, meningkatkan pengisian ASI ke payudara. payudara, meningkatkan menyusui.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh Ika Nur Saputri, dkk mengatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap produksi ASI sebelum dan sesudah pijat oksitosin pada ibu nifas. ibu. Pijat oksitosin adalah tindakan memijat tulang belakang dari saraf ke 5-6 hingga skapula yang dapat mempercepat kerja saraf parasimpatis untuk menyampaikan perintah ke bagian belakang otak sehingga hormon oksitosin dilepaskan.

G. Pijat Punggung

Pijat punggung menyebabkan stimulasi sumsum tulang belakang berfungsi sebagai penghubung saraf antara otak dan sistem saraf tepi. Semua komunikasi naik turun medula spinalis terletak di jalur (traktus) sensor menaik yang mentransmisikan sinyal dari input aferen ke otak. Substansi grisea yang terletak di tengah sumsum tulang belakang mengandung penghubung antara neuron yang terletak di antara input aferen dan output eferen dan badan sel neuron eferen. Serabut aferen dan eferen yang membawa sinyal ke dan dari sumsum tulang belakang, menyatu menjadi saraf spinalis. Saraf ini melekat pada tali yang dipasangkan di sepanjang sumsum tulang belakang. *Inhibitoric neurons* dan *cholimergetic neurons excitatory make synaptic contact with oxytocin neurons merupakan secretory neurons* di *nukleus paraventricular* dan *supraoptik*. Kemudian hipotalamus menghasilkan hormon oksitosin dan dialirkan menuju hipofisis posterior. Banyak faktor yang memengaruhi jumlah ASI yang diproduksi dan dikeluarkan dari kelenjar susu. Kecukupan atau bahkan persepsi produksi ASI yang tidak mencukupi adalah alasan paling umum untuk tidak menyusui yang dilaporkan oleh para ibu. Oksitosin dan prolaktin adalah dua hormon utama yang terlibat dalam sekresi dan pengeluaran ASI. Sedangkan *Endorphin* merupakan *hormon mood booster* yang dapat merangsang perasaan rileks pada ibu nifas sehingga memperlancar laktasi.

Pemberian pijatan pada punggung lebih efektif dibandingkan kompres hangat pada payudara untuk meningkatkan produksi ASI. Hal ini dikarenakan, pijatan pada syaraf punggung akan merangsang pelepasan hormon Endorphin dalam tubuh yang secara tidak langsung akan merangsang refleksi oksitosin. Saat diberikan pijatan punggung, saraf dorsal akan mengirimkan sinyal ke otak untuk melepaskan oksitosin, yang akan menyebabkan kontraksi sel-sel *myoepithelial* yang akan mendorong keluarnya ASI karena syaraf di payudara dipersarafi oleh saraf dorsal (saraf dorsal) yang menjalar sepanjang tulang belakang. Efek pijat juga dapat meningkatkan kadar Serotonin dan Dopamin, yang dapat menyebabkan penurunan ketidaknyamanan, kelelahan, stres, dan depresi.

Dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu juga terdapat dua kendala utama yang dihadapi keluarga dalam membantu ibu menyusui yaitu ASI yang kurang dan ibu yang malu dengan pijat endhoprin. *Endorphin massage* merupakan

teknik sentuhan dan pijatan ringan yang sangat penting bagi ibu nifas untuk membantu memberikan rasa tenang dan nyaman. Penelitian menunjukkan bahwa teknik ini meningkatkan pelepasan hormon Endorphin (memberikan rasa nyaman dan tenang) dan hormon. Pijat endorphin juga dapat mengurangi keparahan postpartum blues pada ibu postpartum.

Endorphine massage adalah teknik pijat dengan sentuhan lembut yang dapat menormalkan detak jantung dan tekanan darah, serta meningkatkan keadaan rileks pada tubuh ibu dengan memicu rasa nyaman pada permukaan kulit dan dapat memengaruhi produksi hormon prolaktin dan oksitosin serta memberikan relaksasi yang dapat memenuhi kebutuhan ibu nifas dalam mengatasi masalah menyusui pada hari-hari pertama setelah melahirkan serta pijat Endorphin dapat meningkatkan volume ASI.

Pijat Endorphin adalah pijatan ringan yang dapat dilakukan pada leher, punggung, dan lengan untuk membuat merasa nyaman dan tenang. Pemberian *endorphin massage* dengan tujuan meningkatkan produksi ASI merupakan hormon yang cukup efektif untuk keluar dari tubuh yang secara tidak langsung akan merangsang refleksi oksitosin dan prolaktin. Hormon oksitosin berperan sangat penting dalam merangsang keluarnya ASI, hormon ini sering juga disebut cinta karena keberadaannya sangat dipengaruhi oleh *mood* ibu. Sedangkan hormon prolaktin berfungsi untuk merangsang produksi ASI dan pertumbuhan payudara. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa setelah endorphin massage, ibu nifas memproduksi ASI lebih banyak dibandingkan ibu yang tidak mendapatkan endorphin, dan endorphin berdampak pada produksi ASI serta terdapat perbedaan kelancaran produksi ASI antara kelompok kontrol yaitu ibu yang mendapatkan intervensi endorphin massage berpeluang mengalami kelancaran produksi ASI 0,2 kali lebih banyak. dibandingkan dengan subjek yang tidak mendapatkan perlakuan dan volume ASI ibu nifas yang diberikan intervensi *endorphin massage* lebih besar dibandingkan ibu nifas pada kelompok kontrol.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Safitri, ibu nifas yang mendapatkan perawatan pijat punggung lebih cepat mengeluarkan ASI dibandingkan yang tidak mendapatkan pijatan sehingga dapat disimpulkan bahwa pijat terapi dapat secara efektif meningkatkan produksi ASI. Terapi pijat dapat dilakukan secara sederhana sesuai dengan kebutuhan ibu nifas. Terapi pijat merupakan intervensi yang mudah dan aman untuk dilakukan pada ibu nifas. Intervensi ini juga dapat dilakukan oleh suami atau keluarga pasien setelah dilatih oleh bidan/tenaga kesehatan. Hal ini juga dibuktikan dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Ningsih bahwa terdapat peningkatan keterampilan ibu setelah memperoleh demonstrasi cara melakukan pijat laktasi dan endhoprin.

Intervensi gabungan pijat oksitosin dan endhoprin lebih berpengaruh nyata terhadap proses involusi uteri ibu nifas karena pijat endhorin melatih *hipofisis*

anterior untuk mengeluarkan endorfin yang menimbulkan sensasi nyeri dan tubuh akan terasa rileks yang akan meningkatkan pelepasan hormon oksitosin yang berperan aktif dalam meningkatkan kontraksi uterus pada proses involusi uterus. Saat pijatan kedua digabungkan akan dapat meningkatkan kadar hormon oksitosin yang lebih signifikan sehingga dapat mempercepat proses involusi uterus. Area leher sepanjang tulang belakang dan punggung berkaitan erat dengan keberadaan hipofisis dan hipotalamus. Terletak dekat dengan kepala dan dada dengan aksi otot semispinal menyebabkan kontraksi simultan akan mempercepat suplai darah oksitosin yang terhambat. Hormon oksitosin dilepaskan dari pengobatan hipotalamus, akan menunda dan mempercepat kontraksi uterus, menekan pembuluh darah dan membantu proses *homeostatis*. Kontraksi dan retraksi otot rahim akan mengurangi suplai darah ke rahim. Proses ini akan membantu mengurangi bekas luka tempat plasenta berimplantasi dan mengurangi perdarahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson. L, Kynoch. K, Kildea S, Lee N. Effectiveness of breast massage for the treatment of women with breastfeeding problems: A systematic review. *JBIC Database Syst Rev Implement Reports*. 2019;17(8):1668–1694.
- Argaheni NB. The Effect Of Endorphin Massage On Milk Production In Postpartum Mothers. *J Kebidanan dan Kesehat Tradis*. 2021;6(2):115–26.
- Baiq Eka Putri Saudia NNAM. Pengaruh endorphin massage terhadap peningkatan produksi asi pada ibu yang terdeteksi postpartum blues dengan skrining EPDS (Edinburgh Post Depression Scale) di puskesmas wilayah kerja sekota mataram. *J Kesehat Prima* [Internet]. 2017;I(1):36–42. Available from: <http://poltekkes-mataram.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/5.-Eka-Saudia-1.pdf>
- Bowles B. Breast Massage: A “Handy” Multipurpose Tool to Promote Breastfeeding Success. *Clin Lact*. 2020;(4):21–4.
- Dewi A, Dasuki D, Kartini F. The Effect of Back Massage on Breast Milk Production in Post-Cesarean Section Mothers at Kebumen Hospital. 2018.
- Dewi Andariya Ningsih. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif. *J Penelit Kesehat Suara Forikes* [Internet]. 2018;9(2):2013–5. Available from: <http://forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/view/9204/pdf>
- Erniyati E, Pratimi B, Saudia E. Effect of Endorphin Massage on Increasing Milk Production in Postpartum Mothers in the working area of the Bagu Health Center. *J Midwifery Updat*. 2018;1(2):61–9.
- Fairus, Martini, Widiyanti, Septi. Hubungan Dukungan Suami Dengan Kejadian Depresi Postpartum Pada Ibu Nifas. *J Kesehat Metro Sai Wawai*. 2014;11–8.
- Field T. Massage therapy research review. *Physiol Behav*. 2018;176(1):139–48.
- Harismi, Sampara, N., Ohorella F. The Effect of Woolwich and Endorphine Massage on the Smoothness of Breastfeeding in Postpartum Mothers at Laburan Baji Hospital. 2020.
- Hartono. Massage endorphine terhadap volume ASI pada ibu post partum. *J kebidanan*. 2016;8(2):209–14.
- Hidayati H, Barlianto W, Baktiyani S. Effects of endorphin massage on B-endorphin level and Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) score in women with postpartum blues. *Cukurova Med J*. 2014;39(3):512–6.
- Kathryn G Dewey. The challenge of meeting nutrient needs of infants and young children during the period of complementary feeding: an evolutionary perspective. *Pubmed* [Internet]. 2013;143(12):2050–4. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24132575/>

- Lu P, Ye ZQ, Qiu J, Wang XY, Zheng JJ. Acupoint-tuina therapy promotes lactation in postpartum women with insufficient milk production who underwent caesarean sections. *Med (United States)* [Internet]. 2019;98(35). Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6736488/#:~:text=During the early postpartum days,for further investigation and validation.>
- Machmudah, Khayat, Nikmatul, Isworo, Teguh J. Peningkatan colostrum pada ibu postpartum Sectio Caesarea yang dilakukan pijat payudara dengan metode oketani. 2014; Available from: <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/1203>
- Maryunani A. Inisiasi Menyusui Dini, Asi Eksklusif dan Manajemen Laktasi. akarta: Trans info media; 2012.
- Mayangsari SID, Hidayati SN. Manfaat Rolling Massage Punggung Dan Endhorphin Massage Terhadap Produksi ASI. *J Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan.* 2020;11(2):162–167.
- Mgongo M, Mosha M V., Uriyo JG, Msuya SE, Stray-Pedersen B. Prevalence and predictors of exclusive breastfeeding among women in Kilimanjaro region, Northern Tanzania: A population based cross-sectional study. *Int Breastfeed J* [Internet]. 2013;8(1):1–8. Available from: <https://internationalbreastfeedingjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1746-4358-8-12>
- Ningsih DA, Maryani D, Rohmah M, Muhara Y, Romlah S. The study and constraints of breastfeeding mothers in performing endoprine massage and lactation in the working area of the Arjasa Health Center. 2022;10(2):780–9.
- Ningsih DA, Sari YM, Kholifah UN. Edukasi Pijat Laktasi dan Endhoprin pada Ibu Menyusui dalam Situasi Pandemi Covid-19. *Poltekita J Pengabd Masy.* 2022;3(September):405–11.
- Ningsih DA. Continuity of Care Kebidanan. *OKSITOSIN J Ilm Kebidanan.* 2017;4(2):67–77.
- Pertami SB, Budiono B, Rahmawati I. Optimizing the Endorphin and Oxytocin Massage to Increase Breast Milk Production among Postpartum Mother in Indonesia. *NurseLine J* [Internet]. 2020;5(1):214. Available from: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/NLJ/article/view/16825>
- Rapaport M, Schettler P, Bresee C. A preliminary study of the effects of repeated massage on hypothalamic–pituitary–adrenal and immune function in healthy individuals: a study of mechanisms of action and dosage. *J Altern Complement Med.* 2012;18(8):789–97.
- Rohmah M, Mufida RT, Ningsih DA, Hudawati N, Kebidanan P, Kebidanan P, et al. Endhorpin Massage with Lavender Oil By husband to Increase Breastmilk Production in Breastfeeding Mother in Malang Regency. 2022;14(01):108–14.

- Rukmawati S, Astutik P, Retnoningrum AD. Method (Stimulation Endorphin, Oxytosin and Sugestive) to Increase The Production of Breast Milk and Involution of Uters On Post Partum. *Str J Ilm Kesehat*. 2020;9(2):1207–11.
- RY Astutik. *Payudara dan Laktasi (Breast and Lactation)*. Jakarta: Salemba Medika; 2013.
- Safitri WN, Susilaningsih, Panggayuh A. Pijat Punggung dan Percepatan Pengeluaran ASI Pada Ibu Post Partum. *J Inf Kesehat Indones* [Internet]. 2015;1(2):148–53. Available from: <https://adoc.pub/pijat-punggung-dan-percepatan-pengeluaran-asi-pada-ibu-post-.html>
- Saldana PC, Venancio SI, Saldivab SRDM, Vieira DG, Mello DF de. Milk Consumption In Infants Under One Year Of Age And Variables Associated With Non Maternal Milk Consumption. *Pediatrics (Santiago)* [Internet]. 2017;35(4):407–414. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5737270/>
- Saputri I., Ginting D., Zendato. I. Pengaruh Pijat Oksitosin terhadap Produksi ASI pada Ibu Postpartum. *J Kebidanan Kestra*. 2019;2(1).
- Saudia BE., Murni NN. Pengaruh Endorphin Massage terhadap Peningkatan Produksi ASI pada Ibu yang terdeteksi Postpartum Blues dengan Skrining EPDS (Edinburg Postpartum Depression Scale) Di Puskesmas Wilayah Kerja Sekota Mataram. *J Kesehat Prima*. 2017;11(1):36–42.
- Sulistiana MP, Marfuah D, Mutiar A, Nurhayati N. The Effect of Oxytocin and Endorphin Massage to Uterine Involution in Post-Partum Mothers: A Literature Review. *KnE Life Sci*. 2021;2021:680–8.
- Susilawati E, Hindratni F, ... Breast massage to support the success of exclusive breastfeeding among postpartum mothers in Pekanbaru, Indonesia. *GHMJ (Global Heal ...* [Internet]. 2022;5(1):1–4. Available from: <https://publications.inschool.id/index.php/ghmj/article/view/597%0Ahttps://publications.inschool.id/index.php/ghmj/article/download/597/477>
- Sutrisminah D. Benefits Of Breast Massage On Postpartum Uterine Involution. *Jurnal Stikesmukla.ac.id* [Internet]. 2014; Available from: <https://docplayer.info/33702436-Benefits-of-breast-massage-on-postpartum-uterine-involution-emi-sutrisminah-1-nur-alfiyati-2.html>
- Umar. N. *Multitasking Breastfeeding Mama*. Jakarta: Pustaka Bunda Group; 2014.
- Vidayanti V, Wahyuningsih, MSH A. Smooth Milk Production After Csection with Back Massage Using Virgin Coconut Oil. *Wind Heal J Heal* [Internet]. 2020;3(4):362–73. Available from: <http://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/article/view/woh3410>
- WHO. *Exclusive Breastfeeding For Optimal Growth, Development And Health Of Infants*. 2018.
- William V, Carrey. M. Domperidone untuk meningkatkan Produksi Air Susu Ibu (ASI). *J Cermin Dunia Kedokt*. 2016;3(43):225–6.

BAB 4

PIJAT OKSITOSIN PADA IBU NIFAS

Bdn. Pande Putu Indah Purnamayanthi, S.ST., M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 4

PIJAT OKSITOSIN PADA IBU NIFAS

Oleh: Pande Putu Indah Purnamayanthi, S.ST., M.Kes

A. Pengertian Pijat Oksitosin

Pijat oksitosin adalah pemijatan pada daerah punggung mulai dari *costae* (tulang rusuk) ke 5-6 memanjang kedua sisi tulang belakang sampai ke *scapula* (tulang belikat) yang akan mempercepat kerja saraf *parasimpatis*, saraf yang berpangkal pada *medula oblongata* dan pada daerah *sacrum* dari *medula spinalis*, merangsang *hipofise posterior* untuk mengeluarkan oksitosin, oksitosin menstimulasi kontraksi sel-sel otot polos yang melingkari *duktus laktiferus* kelenjar mammae menyebabkan kontraktilitas *myoepitel* payudara sehingga dapat meningkatkan pemancaran ASI dari kelenjar mammae (Departemen Kesehatan R.I., 2017).

Pijat oksitosin merupakan rangsangan pemijatan payudara atau rangsangan pada punggung belakang. Pijat oksitosin dapat merileksasi ketegangan dan menghilangkan stres, dibantu dengan hisapan bayi pada puting susu segera setelah bayi lahir dengan keadaan bayi normal, *neurotransmitter* akan merangsang *medulla oblongata* kemudian mengirim pesan ke *hipotalamus* di *hypofise posterior* untuk mengeluarkan oksitosin sehingga menyebabkan payudara mengeluarkan air susunya (Desmawati, 2018).

Pijat oksitosin adalah suatu tindakan pemijatan pada daerah punggung mulai dari *nervus* ke 5-6 sampai *scapula* yang akan mempercepat kerja saraf *parasimpatis* untuk menyampaikan perintah ke otak bagian belakang sehingga oksitosin keluar (Fauziyah, 2017). Pijat oksitosin merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketidaklancaran produksi ASI. Pijat oksitosin adalah pemijatan pada sepanjang tulang belakang (*vertebrae*) sampai tulang *costae* kelima-keenam dan merupakan usaha untuk merangsang hormon prolaktin dan oksitosin setelah melahirkan (Fauziyah, 2012).

Pijat oksitosin adalah pemijatan pada sepanjang kedua sisi tulang belakang dan merupakan usaha untuk merangsang hormon oksitosin setelah melahirkan (Wulandari, 2020). Pijat oksitosin adalah pijat yang dilakukan disepanjang tulang belakang (bagian punggung) yang berguna untuk memperlancar keluarnya ASI (Rennata, 2020).

B. Manfaat Pijat Oksitosin

Pijat oksitosin dilakukan untuk merangsang reflek oksitosin atau *refleks letdown*. Selain untuk merangsang *refleks let down*, manfaat pijat oksitosin yaitu

memberikan kenyamanan pada ibu, mengurangi bengkak pada payudara (*engorgement*), mengurangi sumbatan ASI, merangsang pelepasan hormon oksitosin, dan mempertahankan produksi ASI ketika ibu dan bayi sakit (Fauziyah, 2012).

Produksi dan pengeluaran ASI dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan oksitosin dan reflek prolaktin dan *let-down reflex*. Hormon prolaktin dikeluarkan saat ada stimulasi pada saat bayi mengisap puting susu ibu, gerakan isapan bayi merangsang serat saraf dalam puting susu ibu. Serat saraf ini membawa permintaan agar air susu melewati kolumna spinalis ke kelenjar hipofisis dalam otak. Kelenjar hipofisis merespon pesan ini dengan melepas hormon prolaktin dan oksitosin. Hormon Prolaktin merangsang payudara untuk menghasilkan lebih banyak air susu. Oksitosin merangsang kontraksi otot-otot yang sangat kecil yang melindungi duktus dalam payudara. Kontraksi ini menekan duktus dan mengeluarkan air susu dalam tempat penampungan dibawah areola dan masuk ke sistem duktulus untuk selanjutnya mengalir masuk ke dalam dalam mulut bayi. Berdasarkan teori, hypogactia terjadi karena adanya hambatan dalam produksi hormon prolaktin pada tahapan laktogenesis yang disebabkan adanya *congenital dysplasia*, masalah diet (Doko, T.M., Aristiati, K., Hadisaputro, 2019).

Manfaat lain pijat oksitosin bagi ibu nifas dan ibu menyusui, diantaranya : a). Mempercepat penyembuhan luka bekas implantasi plasenta b). Mencegah terjadinya perdarahan post partum c). Dapat mempercepat terjadinya proses *involusi uterus* d). Meningkatkan produksi ASI e). Meningkatkan rasa nyaman pada ibu menyusui f). Meningkatkan hubungan psikologis antar ibu dan keluarga (Fauziyah, 2012). Perawatan pijatan berulang bisa meningkatkan produksi hormon oksitosin. Efek dari pijat oksitosin bisa dilihat reaksinya setelah 6-12 jam pijatan (Fauziyah, 2012).

Manfaat pijat oksitosin membantu ibu secara psikologis, menenangkan dan tidak stres, membangkitkan rasa percaya diri, membantu ibu agar mempunyai pikiran dan perasaan baik tentang bayinya, meningkatkan ASI, memperlancar ASI, melepas lelah (Rahayu, 2016). Manfaat pijat oksitosin yang lain yaitu memberikan kenyamanan pada ibu, mengurangi bengkak, mengurangi sumbatan ASI, merangsang pelepasan hormon oksitosin, mempertahankan produksi ASI ketika ibu dan bayi sakit (Wulandari, 2020).

C. Mekanisme Pijat Oksitosin

Hormon oksitosin yang dapat merangsang kontraksi sel mioepitel yang mengelilingi mammae, fungsi fisiologik ini meningkatkan gerakan ASI kedalam duktus alveolaris dan memungkinkan terjadinya ejeksi ASI . Hormon oksitosin berada di dalam hipotalamus pada otak. Hormon tersebut dikeluarkan oleh kelenjar

pituitari yang terletak di dasar otak. Menurut penelitian Morhenn, 2012 hubungan pemijatan otot tulang belakang dengan peningkatan kadar oksitosin dan menurunkan kadar *adrenocorticotropin hormon (ACTH)*, *Nitric Oxide (NO)* dan *Beta-Endorphin (BE)*. Perbandingan efek pemijatan pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol mempunyai perbedaan yang signifikan $p < 0,05$. Peran oksitosin dalam berbagai tingkah laku manusia, seperti orgasme, kedekatan sosial, dan sikap keibuan. Untuk alasan ini, hormon oksitosin terkadang dianggap sebagai hormon cinta (Astutik, 2014).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses melahirkan dengan seksio sesarea akan menghambat terbentuknya produksi ASI (Fisher, 2002). Apalagi ditambah faktor obat - obatan penghilang rasa sakit yang digunakan pada saat operasi maupun setelah operasi dapat menyebabkan bayi mengantuk dan tidak responsif untuk menyusu sehingga isapan bayi akan berkurang yang akan menyebabkan refleks *let down* terganggu (Maryunani, 2016).

Sebelum tindakan *sectio caesarea* ibu mendapatkan *anestesi* (pembiusan). *Anestesi* adalah tindakan pra operasi yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan selama proses *sectio* dengan cara menghambat sinyal indera perasa menuju otak yang membuat ibu dalam kondisi waspada/bangun. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Fauziyah, 2012) anestesi dapat mempengaruhi perilaku bayi seperti kurangnya kepekaan dan kemampuan melihat bayi sehingga hormon prolaktin dan oksitosin terhambat yang menyebabkan keterlambatan pengeluaran ASI.

Hormon dikeluarkan sebagai respons atas rangsangan saraf secara langsung kepada kelenjar yang cocok. Hormon oksitosin disimpan di *hipofisis posterior* dan dilepaskan ke dalam darah oleh rangsangan dalam serat saraf dari *hipotalamus*. Sebagian besar serat dari *nukleusparaventriculer* berhubungan dengan sekresi oksitosin (Zubaidah, Rusdiana, Norfitri, R., & Pusparina, 2021). Melalui pijatan atau rangsangan pada daerah punggung, *neurotransmitter* akan merangsang *medulla oblongata* langsung mengirim pesan ke *hypothalamus* di *hypofise posterior* untuk mengeluarkan oksitosin sehingga menyebabkan payudara mengeluarkan ASI. Pijatan di daerah punggung belakang juga berfungsi untuk merangsang kontraksi pada rahim saat proses persalinan dan membantu pengeluaran ASI dibantu dengan hisapan bayi pada puting susu pada saat segera setelah bayi lahir dengan keadaan bayi normal merileksasi ketegangan dan menghilangkan stres. *Kolostrum* yang menetes atau keluar merupakan tanda aktifnya *reflex oksitosin* (Rahayuningsih, 2020).

Pijat oksitosin pada ibu post *sectio caesarea* dilakukan setelah ibu dapat melakukan mobilisasi tanpa bantuan. Mobilisasi dapat mempercepat waktu pengeluaran ASI pada ibu *sectio caesarea*. Pengeluaran ASI lebih cepat pada ibu *sectio caesarea* yang melakukan *mobilisasi* aktif dibandingkan dengan ibu yang

melakukan *mobilisasi* pasif. *Mobilisasi* aktif mempercepat penyembuhan luka operasi dan nyeri dibagian tulang belakang Ibu *sectio caesarea* dapat melakukan *mobilisasi* aktif 48 jam pasca operasi (Fanny, 2017). Pijat oksitosin dilakukan dengan durasi 3-5 menit dan frekwensi pemberian pijatan 2 kali sehari. Pada operasi bagian perut untuk meningkatkan rasa nyaman dan mengurangi rasa nyeri, bantu ibu untuk menyokong daerah pembedahan dengan bantal sehingga meningkatkan kenyamanan (Fauziyah, 2012).

D. Proses Pembentukan atau Produksi ASI

Pada seorang ibu dikenal dua refleks yang masing-masing berperan sebagai pembentuk dan pengeluaran ASI yaitu refleks prolactin dan refleks oksitosin (*let down reflex*).

1. Refleks Prolaktin

Pada saat kehamilan hormon prolaktin dihambat oleh hormon estrogen dan progesteron, setelah partus dan lepasnya plasenta maka korpus luteum kurang berfungsi sehingga estrogen dan progesteron menurun. Ditambah dengan isapan bayi yang merangsang putting susu akan merangsang ujung-ujung saraf sensoris yang berfungsi sebagai reseptor mekanik. Rangsangan ini dilanjutkan ke hipotalamus melalui medula spinalis dan mesensephalon. Hipotalamus akan merangsang adenohipofise (hipofise anterior) sehingga keluar prolaktin. Hormon ini merangsang sel-sel alveoli yang berfungsi untuk membuat air susu (Kristiyanasari, 2019).

2. Refleks Oksitosin (*Let Down Reflex*)

Bersamaan dengan pembentukan prolaktin oleh adenohipofise, rangsangan yang berasal dari isapan bayi ada yang dilanjutkan ke neurohipofise (hipofise posterior) yang kemudian menghasilkan oksitosin. Melalui aliran darah hormon ini diangkut menuju uterus yang dapat menimbulkan kontraksi pada uterus sehingga terjadi involusi dari organ tersebut. Oksitosin yang sampai pada alveoli akan mempengaruhi sel mioepitelium. Kontraksi dari sel dapat memerah ASI yang telah terbuat keluar dari alveoli dan masuk kedalam sistem duktulus yang untuk selanjutnya mengalir melalui duktus laktiferus masuk ke mulut bayi (Kristiana, 2011).

Pijat oksitosin mempengaruhi system saraf perifer karena pada tulang belakang terdapat saraf-saraf tepi yang akan meningkatkan rangsangan pada hipotalamus. Hipotalamus akan merangsang hipofise posterior untuk memproduksi hormon oksitosin berperan dalam mendorong ASI dari kelenjar susu keluar melalui putting. Oksitsin juga membuat saluran ASI melebar sehingga ASI lebih mudah mengalir. Reflek pengeluaran ASI ini disebut *let down reflex* (Nurbaya, 2021).

E. Langkah-Langkah Melakukan Pijat Oksitosin

Langkah-langkah melakukan pijat oksitosin dengan metode oksitosin sebagai berikut (Purwati, 2018) :

1. Melepaskan baju ibu bagian atas.
2. Ibu miring ke kanan maupun kekiri, lalu memeluk bantal, namun ada dua posisi alternatif, yaitu: boleh telungkup di meja seperti gambar dibawah ini:



Gambar 4.1

Posisi telungkup di meja

Sumber : Naziroh (20sssc17)

3. Memasang handuk.
4. Melumuri kedua telapak tangan dengan minyak atau baby oil.
5. Memijat sepanjang kedua sisi tulang belakang ibu dengan menggunakan dua kepala tangan, dengan ibu jari menunjuk ke depan. Area tulang belakang leher, cari daerah dengan tulang yang paling menonjol, namanya *processus spinosus/cervical vertebrae 7*.



Gambar 4.2

Cara Memijat dengan Ibu Jari Menunjuk ke Depan

Sumber : (Naziroh, 2017)

6. Menekan kuat-kuat kedua sisi tulang belakang membentuk gerakan-gerakan melingkar kecil-kecil dengan kedua ibu jarinya.



Gambar 4.3

Memijat dengan Membentuk Gerakan Melingkar Kecil-Kecil dengan kedua Ibu Jari

Sumber : (Naziroh, 2017)

7. Pada saat bersamaan, memijat kedua sisi tulang belakang kearah bawah, dari leher kearah tulang belikat, selama 2-3 menit.
8. Mengulangi pemijatan hingga 3 kali.
9. Membersihkan punggung ibu dengan waslap air hangat dan dingin secara bergantian

F. Beberapa Penelitian Terkait Pijat Oksitosin Pada Ibu Nifas

1. Asih (2019), "Pengaruh Pijat Oksitosin Terhadap Produksi ASI Pada Ibu Nifas", populasi dalam penelitian ini adalah ibu nifas 3 jam *postpartum* di BPM Lia Maria Kecamatan Sukarame Bandar Lampung tahun 2017 berjumlah 80 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil melalui cara purposive sampling. Sampel berjumlah 32 orang yang terdiri dari 16 orang sebagai responden yang diintervensi dan 16 orang sebagai variabel kontrol. Metode penelitian yang digunakan adalah *eksperimental* dengan desain rancangan posttest dengan kelompok control. Hasil Uji statistik menggunakan *chi-square* (χ^2) diperoleh p-value= 0,037 (p-value $\leq 0,05$) yang berarti ada pengaruh signifikan antara pijat oksitosin terhadap produksi ASI pada ibu post partum di BPM Lia Maria Sukarame Bandar Lampung Tahun 2017 (Asih, 2019).
2. Faizatul Ummah (2018), "Pijat Oksitosin Untuk Mempercepat Pengeluaran Asi Pada Ibu Pasca Salin Normal Di Dusun Sono Desa Ketanen Kecamatan Paceng Gresik", Populasi sebanyak 28 ibu pasca salin normal. Sampel diambil secara exhaustive sampling berjumlah 28 ibu pasca salin normal yang dibagi menjadi 2 kelompok secara randomisasi yaitu 14 orang kelompok intervensi yang diberikan pijat oksitosin dan 14 orang kelompok control. Metode penelitian menggunakan rancangan *Randomised Kontrol Trial*, Hasil penelitian

menunjukkan pengeluaran ASI pada kelompok intervensi pijat oksitosin lebih cepat ((*Mean*= 6.2143) daripada kelompok kontrol (*Mean* = 8.9286). Hasil *uji independent sample test* didapatkan *p* value = 0,000 ($p < 0,005$), artinya ada pengaruh pijat oksitosin terhadap pengeluaran ASI pada ibu pasca salin normal di Dusun Sono Desa Ketanen Kecamatan Panceng Gresik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pijat oksitosin dapat mempercepat pengeluaran ASI (Ummah, 2018).

3. Tabita Mariana Doko, dkk (2019), dengan judul "Pengaruh Pijat Oksitosin oleh Suami terhadap Peningkatan Produksi Asi pada Ibu Nifas", Metode dalam penelitian ini menggunakan metode quasy eksperiment dengan pendekatan rancangan non equivalent control group design. Hasil penelitian, pemberian pijat oksitosin oleh suami berpengaruh terhadap peningkatan produksi Air Susu Ibu (ASI) dengan indicator berat badan bayi ($p < 0.05$), frekuensi menyusui ($p < 0.05$), lama tidur bayi ($p < 0.05$), frekuensi buang air besar bayi (BAB) ($p < 0.05$), frekuensi buang air kecil bayi (BAK) ($p < 0.05$), dan istirahat tidur ibu ($p < 0.05$). Simpulan, pemberian pijat oksitosin oleh suami dapat meningkatkan produksi Air Susu Ibu (ASI) pada ibu nifas yang dilihat dengan berat badan bayi hari, frekuensi menyusui, lama tidur bayi, frekuensi Buang Air Besar bayi (BAB), frekuensi Buang Air Kecil bayi (BAK), dan istirahat tidur ibu (Doko, T.M., Aristiati, K., Hadisaputro, 2019).
4. Lestari Nove (2017), dengan judul "PIJAT OKSITOSIN PADA IBU POSTPARTUM PRIMIPARA TERHADAP PRODUKSI ASI DAN KADAR HORMON OKSITOSIN". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pijat oksitosin terhadap produksi ASI dan kadar hormon oksitosin ibu post partum. Desain pada penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu post partum primipara masa laktasi 4–11 hari di wilayah kerja Puskesmas bendo. Sebanyak 16 responden dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok perlakuan dan kelompok pembanding. Teknik pengambilan sampel menggunakan Probability Sampling tipe Simple Random Sampling. Terdapat variabel independent (pijat oksitosin) dan variabel dependen (produksi ASI dan kadar hormon oksitosin). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan lembar observasi kemudian dianalisis dengan menggunakan uji Mann-Whitney test didapatkan nilai *U* sebesar 8.000 dengan p -value = 0.003 p -value tersebut dibandingkan $\alpha = 0.05$ maka p -value <, sehingga disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau ada perbedaan produksi ASI dan kadar hormon oksitosin antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. Pijat oksitosin tersebut direkomendasikan kepada perawat untuk mengaplikasikan selain perawatan payudara untuk meningkatkan produksi ASI ibu post partum yang memiliki produksi ASI kurang (Lestai, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, Y. (2019). Pengaruh Pijat Oksitosin Terhadap Produksi Asi Pada Ibu Nifas. *Jurnal Kebidanan Kestra (Jkk)*, 2(1), 68–73.
- Astutik, R. (2014). *Payudara dan Laktasi*. Salemba Medika.
- Departemen Kesehatan R.I. (2017). *Pelatihan Konseling Menyusui*. Kemenkes RI.
- Desmawati, C. (2018). Penentu Kecepatan Pengeluaran Air Susu Ibu Setelah Sectio Caesarea. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 7(8).
- Doko, T.M., Aristiati, K., Hadisaputro, S. (2019). Pengaruh Pijat Oksitosin oleh Suami terhadap Peningkatan Produksi Asi pada Ibu Nifas. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 2(2), 66–86.
- Fanny, F. (2017). Sectio Caesarea sebagai Faktor Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum. *Jurnal Majority*, 4(8), 57–62.
- Fauziyah. (2012). *Obstetri Patologi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*. Nuha Medica.
- Fauziyah. (2017). *Obstetri Patologi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*. Nuha Medica.
- Kristiana, S. (2011). *Asi, Menyusui & Sadari*. Nuha Medika.
- Kristiyanasari, W. (2019). *ASI, Menyusui & Sadari*. Nuha Medika.
- Lestai, N. (2017). PIJAT OKSITOSIN PADA IBU POSTPARTUM PRIMIPARA TERHADAP PRODUKSI ASI DAN KADAR HORMON OKSITOSIN. *Jurnal Ners Dan Kebidanan*, 4(2), 120–124.
- Maryunani. (2016). *Asuhan pada Ibu Dalama Masa Nifas*. TIM.
- Naziroh, Y. (2017). Pengaruh Pijat Oksitosin Terhadap Pengeluaran ASI pada Ibu Postpartum di BPM Pipin Heriyanti Yogyakarta. *Jurnal Media Ilmu Kesehatan*, 6(1).
- Nurbaya. (2021). *Konseling Menyusui* (H. Syarif (ed.); Pertama). Syiah Kuala University Press.
- Purwati. (2018). Perbedaan Pijat Oksitosin Dengan Kompres Hangat Terhadap Produksi ASI pada ibu Post Operasi Sectio Caesaria di Rawat inap A RS Wava Husada. *Jurnal Ilmu Kebidanan Dan Kesehatan*, 8(1).
- Rahayu, A. P. (2016). *Keperawatan Maternitas*. deepublish.
- Rahayuningsih, T. (2020). *Perawatan Payudara & Pijat Oksitosin* (D. Dermawan (ed.); Pertama). Gosyen.
- Rennata. (2020). *Motivasi ASI* (Pertama).
- Ummah, F. (2018). Pijat Oksitosin Untuk Mempercepat Pengeluaran ASI Pada Ibu Pasca

Salin Normal Di Dusun Sono Desa Klaten Kecamatan Panceng Gresik. *Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(1).

Wulandari, N. F. (2020). *Happy Exclusive Breastfeeding* (D. Nadhiva (ed.); Pertama). Laksana.

Zubaidah, Rusdiana, Norfitri, R., & Pusparina, I. (2021). *Asuhan Keperawatan Nifas (Pertama)*. deepublish publisher.

BAB 5

YOGA PADA IBU NIFAS

Bdn. Kusumastuti, S.Si.T., M. Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 5

YOGA PADA IBU NIFAS

Oleh: Bdn. Kusumastuti, S.Si.T., M. Kes

A. Deskripsi

Masa nifas atau yang biasa disebut dengan puerperium adalah permulaan setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika organ rahim kembali ke fungsi sebelum kehamilan. Masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Namun, hal itu akan pulih sepenuhnya dalam waktu 3 bulan dan akan mengalami perubahan fisik dan mental.

Salah satu bentuk dari mobilisasi pasca bersalin ialah yoga. Senam yoga merupakan teknik yang berfokus pada otot, mekanisme respirasi, postur serta bentuk tubuh dan kesadaran dari tubuh manusia. Yoga memiliki tujuan yaitu agar memperoleh kesehatan fisik dan mental dari tubuh ketika kita berolahraga, pernafasan yang sesuai, mempertahankan postur tubuh, maupun meditasi (Winarni, Ikhlasiah, et al., 2020).

B. Pengertian Yoga Nifas

Masa nifas akan berlangsung sekitar 6 minggu. Saat ini, ibu nifas perlu mendapat pelatihan untuk mempercepat proses infiltrasi rahim. Degradasi ini mencakup penyusunan kembali serta pengangkatan endometrium sekaligus pelepasan tempat menempelnya plasenta. Apabila proses ini sudah selesai maka ukuran, berat dan posisi uterus akan mengalami penurunan dan juga adanya perubahan pada warna dan volume lochea. Penyebab terjadinya proses involusi adalah adanya retensi fragmen plasenta, infeksi dan perdarahan lanjut (late postpartum haemorrhage). Involusi uteri prosesnya bisa di percepat dengan salah satunya yang dianjurkan adalah senam yoga. (Mansyur & Dahlan, 2016)

Mobilisasi diperlukan oleh ibu nifas agar ibu merasa lebih sehat. Ibu bisa segera mungkin menjaga serta merawat bayinya. Ini bertujuan untuk mencegah beberapa infeksi masa nifas seperti trombosis, trombo emboli dan melancarkan sirkulasi darah. Kontraksi uterus akan membaik sehingga tinggi fundus uteri akan menurun dan keras dan memungkinkan tidak terjadinya perdarahan. Otot-otot rahim juga berfungsi secara optimal dan rahim akan kembali ke bentuk semula (Icesmi, 2015).

Mobilisasi dengan olahraga ringan yang dianjurkan untuk dilakukan setelah melahirkan adalah yoga. Senam yoga merupakan salah satu olahraga yang aman untuk dilakukan oleh ibu nifas mengingat olah raga ini tidak terlalu berat. Yoga

seringkali disarankan untuk ibu postpartum yang seringkali mengalami perubahan mood atau sering merasa lelah.

Asal kata Yoga yaitu diambil dari Bahasa Sansekerta "Yuj" artinya menyatukan (to join). Atau bisa diartikan sebagai bersatunya pribadi dengan pencipta melalui keselarasan fisik, mental dan spiritual. Yoga apabila dikerjakan selama masa nifas memiliki manfaat diantaranya meningkatkan kualitas hidup, otot tubuh menjadi kuat, menenangkan, menstabilkan emosi dan membangun rasa percaya diri menjalani peran baru (Shi et al., 2016).

Manfaat yoga diantaranya adalah melatih konsentrasi, membuat hati tenang, menyeimbangkan emosi dan melatih untuk berfikir positif. Manfaat lainnya adalah melancarkan kebutuhan oksigen ke otak, merefresh suasana hati, menciptakan energi baru, kekebalan tubuh meningkat, peredaran darah menjadi lancar (Rakhshani et al., 2015).

Yoga terdiri dari latihan sikap tubuh atau asana, latihan pernafasan atau pranayama dan latihan teknik relaksasi kemudian mengkombinasikan ketiga latihan tersebut (Bouya et al., 2020). Ibu nifas berpotensi mengalami perubahan perasaan misalnya stress, cemas, dan kelelahan, oleh karena itu ibu nifas sangat dianjurkan untuk melakukan yoga (Rimigravida, 2019).

Yoga adalah disiplin kuno yang dirancang untuk membawa keseimbangan dan kesehatan pada dimensi fisik, mental, emosional dan spiritual individu. Yoga sering digambarkan sebagai pohon dan terdiri dari delapan aspek atau anggota tubuh : yama (universal etika), nyima (etika individu), asna (postur fisik), pranayama (kontrol nafas), pratayahara (kontrol dari indra), dharana (konsentrasi), dyana (meditasi), dan samdhi (kebahagian). Yoga merupakan penyatuan jiwa, tubuh dan pikiran terkait kesehatan dan kebugaran dimana orang memusatkan semua pikirannya untuk mengendalikan panca indra dan semua anggota badan. Yoga terbukti dapat mengurangi stres dan bisa meningkatkan mood (Kusumastuti, dkk, 2020)

C. Fisiologi Yoga Nifas

Yoga postpartum terbukti sebagai alat yang efektif untuk melakukan akseleratoruterin pada periode postpartum. Peregangan otot postpartum mempengaruhi pengurangan otot uterus setelah lahir. Penurunan elastisitas otot dapat memengaruhi kontraksi uterus, oleh karena itu, hal itu memengaruhi mengembalikan proses perangkat uterus seperti sebelum kehamilan. Kontraksi rahim dipengaruhi oleh pelepasan hormon oksitosin. Hormon ini akan terus diproduksi oleh hipofisis selama stimulasi masih berlangsung. Frekuensi kontraksi uterus dan durasi involusi uterus dari setiap ibu tidak terjadi secara spesifik setiap hari dan sangat bervariasi. Serviks dan rahim mengalami proses pengembalian seperti sebelum kehamilan.

Proses pengembalian organ reproduksi tidak normal. Salah satunya disebabkan oleh kualitas tidur ibu yang terganggu oleh kelelahan dan ketegangan otot. Ini bisa dicegah dengan latihan fisik berbasis yoga. Terbukti bahwa tingkat saliva α -amilase menurun secara signifikan dan segera setelah berlatih yoga selama semua periode evaluasi dalam kelompok yoga. Durasi tidur malam secara signifikan lebih lama pada kelompok yoga.

Postur yoga membantu peregangan dan pembentukan otot, dan memperkuat tulang dan merilekskan sendi. Yoga dan postur relaksasi merangsang sekresi hormon endorphin (hormon bahagia) yang menciptakan perasaan nyaman bagi tubuh. Selain itu, pernapasan dengan teknik pernapasan yoga dapat meningkatkan kapasitas paru-paru sehingga proses pernapasan menjadi lebih optimal (Zourdalani, 2015).

Penerapan program latihan fisik intensitas rendah tampaknya meningkatkan kebugaran fisik dan keseluruhan pada wanita postpartum, termasuk peningkatan fungsi kardio-pernapasan, kekuatan otot, dan daya tahan tungkai atas dan perut, meregangkan punggung dan paha muskuloskeletal, dan pengurangan total lemak tubuh. Secara fisiologis, resistensi otot diketahui menurun setelah melahirkan bersamaan dengan perubahan hormon yang terjadi. Dengan hadirnya latihan fisik, terutama yoga dapat meningkatkan kekuatan otot, peregangan, dan relaksasi sehingga kualitas hidup pascamelahirkan meningkat. Wanita postpartum yang menerima pelatihan fisik pascanatal segera setelah melahirkan adalah terbukti memiliki kesejahteraan fisik yang lebih baik dan peningkatan kualitas hidup. Latihan menyebabkan peningkatan kadar endorfin di otak yang bertindak sebagai agen psikoaktif internal untuk menghasilkan rasa euforia, perasaan menyenangkan yang terkait dengan citra diri yang positif, rasa vitalitas, kontrol, dan kepuasan, beta-endorfin yang diproduksi secara endogen dari dalam tubuh selama latihan.

Latihan fisik berbasis yoga sebagai perilaku holistik telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis, membantu membangun pemulihan kekuatan fisik setelah melahirkan, dan memberikan dukungan sosial kepada ibu nifas. Sesuai dengan penelitian ini, yoga postpartum dimulai dari hari pertama (> 6 jam) setelah ibu melahirkan dengan pose yang disesuaikan dengan kebutuhan ibu dapat meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan penguatan otot dasar panggul, dan memberikan relaksasi, tubuh dan pikiran untuk para wanita.

Gerakan yoga postpartum memfokuskan perhatian pada ritme pernapasan, penekanan pada pose miring panggul yang dimodifikasi, modifikasi buaya, pose jembatan, dan pose anak yang mengutamakan kenyamanan, karenanya, dapat mengurangi ketegangan otot, memperlancar sirkulasi darah, dan merangsang hormon saraf dan fisik. untuk pengurangan ketidaknyamanan fisik dan psikologis pada wanita. Kondisi nyaman wanita dapat merangsang pusat saraf di hipotalamus di otak dan menyebabkan sel neurohipofise (hipofisis posterior) untuk melepaskan sitocin disekresikan oleh sel-sel neuron dalam nukleus periventrikel dan supraoptik

dari hipotalamus. Oksitosin mengalir melalui serabut saraf ke hipofisis posterior dan melepaskan ke aliran darah ketika saraf distimulasi. Melalui aliran darah, hormon-hormon ini diangkut ke alveoli dan memengaruhi sel-sel myoepithelium untuk berkontraksi dan proses involusi uterus lebih cepat. Sehingga dapat disimpulkan, yoga postpartum efektif dalam mempercepat involusi uterus.

D. Indikasi dan Kontra Indikasi Yoga Nifas

Beberapa kondisi yang harus diperhatikan dalam melakukan yoga

1. Indikasi

Indikasi yoga menurut (Idhayanti et al., 2020) sebagai berikut :

- a. *Low back pain*
- b. Cemas
- c. Stres
- d. Nyeri haid
- e. Tekanan darah tinggi
- f. Gangguan kualitas tidur

2. Kontraindikasi

- a. Sakit dada persisten
- b. Gejala syok kardiogenik
- c. Suhu di atas 38 derajat celcius
- d. Gagal jantung yang belum stabil
- e. Kehamilan dengan penyakit jantung
- f. Riwayat persalinan kurang 2 bulan
- g. Plasenta previa
- h. Kecelakaan pada lutut, bahu dan leher.

E. Manfaat Yoga

Manfaat yang signifikan termasuk mengurangi depresi membuat diri menjadi lebih tenang, peningkatan menyusui mengurangi berat badan, meningkatkan kemampuan pengasuhan dan kapasitas untuk melaksanakan aktivitas fisik secara teratur runtuk dirinya sendiri serta bayinya, stres atau bahkan kelelahan karena mengurus bayi. Ibu bisa mengatasi masalah ini dengan melakukan yoga (Pernetta, 2010).

Berikut manfaat-manfaat yoga antara lain :

1. *Fleksibilitas*

Ketika beberapa orang berpikir tentang senam yoga, mereka membayangkan seperti fitness, sehingga merasa terlalu tua, dan tidak fit untuk melakukan yoga. Salah satu bagian dari yoga disebut *asanas* yang bekerja secara aman untuk *stretching* otot. Proses ini melepaskan asam *laktat* yang biasanya menyebabkan

kekakuan, ketegangan, sakit dan kelelahan. Selain itu, yoga juga meningkatkan berbagai gerakan dan *lubrikasi* di sendi. yoga tidak hanya untuk otot tapi juga seluruh sel-sel tubuh. Dalam suatu studi ditemukan bahwa terdapat peningkatan *fleksibilitas* sebesar 35% setelah 8 bulan melakukan yoga. Keuntungan yang paling besar adalah *fleksibilitas* di pundak dan badan, sehingga tubuh menjadi terasa lebih nyaman.

2. *Kekuatan*

Beberapa gaya dari yoga seperti *ashtanga* dan power yoga adalah yang paling kuat dibandingkan yang lain. Mempraktikkan salah satu dari gaya ini akan membantu meningkatkan otot. Gaya yoga sedikit gerakan dan pengaturan posisi yang lebih tepat, bisa meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh.

3. *Postur*

Dengan peningkatan *fleksibilitas* dan kekuatan akan menghasilkan postur tubuh yang lebih baik. Banyaknya gaya berdiri dan duduk akan mengembangkan kekuatan inti. Manfaat lain dari yoga adalah meningkatkan kesadaran diri kita. Kesadaran tinggi ini bisa memberikan peringatan jika mengalami bungkuk atau *slumping* sehingga bisa langsung menyesuaikan sikap.

4. *Konsentrasi* dan *mood* yang lebih baik

Penelitian baru-baru ini mengeksplorasi efek dari yoga pada depresi, manfaat yang didapat adalah adanya peningkatan aliran oksigen ke otak.

5. Mengurangi stres dan lebih tenang

Beberapa gaya yoga menggunakan teknik meditasi khusus untuk membuat pikiran yang sering stres menjadi lebih tenang. Gaya yoga lainnya juga tergantung pada teknik bernafas yang mendalam untuk memfokuskan pikiran sehingga membuat pikiran menjadi lebih tenang.

6. Membuat tidur lebih nyenyak

Senam yoga dapat membuat ibu yang sulit tidur karena senam yoga bisa membuat ibu menjadi lebih rileks dan mengatasi rasa lelah setelah seharian beraktifitas merawat bayinya.

7. Mengatasi Gejala Depresi

Seorang ibu yang baru saja melahirkan biasanya akan mengalami *baby blues* atau depresi setelah melahirkan. Hal ini biasanya terjadi ketika ibu terlalu khawatir terhadap masa depan buah hatinya. Namun yoga memiliki teknik pernapasan yang bisa membantu ibu untuk mengatasi dan menghilangkan stres serta depresi sehingga ibu akan merasa lebih tenang dalam merawat dan menjaga buah hati ibu.

8. Meningkatkan Rasa Percaya Diri

Ibu *postpartum* seringkali merasa tidak percaya diri karena bentuk tubuhnya yang melar. Ada beberapa gerakan dalam yoga yang bisa membantu untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jadi tidak ada salahnya jika ibu nifas melakukan yoga sebagai olahraga setelah melahirkan. Yoga tidak hanya akan memberikan

kesehatan fisik atau juga kesehatan mental. Dengan demikian, ibu nifas bisa menikmati hari-hari bahagia sebagai ibu.

9. Membantu penyembuhan rahim, perut, dan otot pinggul yang mengalami trauma serta mempercepat kembalinya bagian-bagian tersebut kedalam bentuk normal.

Manfaat lain dari melakukan yoga secara teratur menurut (Idhayanti et al., 2020) adalah:

1. Kualitas tidur menjadi lebih baik.
2. Fungsi organ dalam tubuh meningkat.
3. Peredaran darah ke otak menjadi lancar.
4. Memperkuat otot tubuh
5. Memperbaiki kerja paru-paru.
6. Sebagai proses detoksifikasi
7. Memperbaiki sel sel dalam tubuh
8. Memperbaiki kerja saraf
9. Memberikan ketenangan dan menghilangkan stress berlebih
10. Menjadi lebih percaya diri dan berpikir positif.

Menurut Happy & Sari (2017) mengatakan manfaat yoga adalah memperkuat otot dasar panggul, otot perut menjadi kencang dan mencegah terjadinya berbagai keluhan di masa nifas. Penelitian ini juga mengatakan bahwa yoga mampu mencegah terjadinya perdarahan post partum karena yoga menyebabkan otot-otot perut berkontraksi sehingga ion kalsium akan meningkat.

Kontraksi otot perut dan retraksi bekerja menjepit pembuluh darah dan mengakibatkan zat dalam jaringan otot berkurang dan akan berubah menjadi kecil dan secara perlahan akan kembali ke ukuran semula. Proses involusi berlangsung secara berangsur. Terjadi pengurangan 1 sampai 2 cm TFU setiap harinya. TFU tidak teraba pada hari ke 9 masa nifas.

F. Gerakan Yoga Ibu Nifas

1. *Utitha*

Berdiri posisi *tandasana*, Melompat atau buka perlahan kaki (jika menderita problem punggung) melebar ke samping 1,2 – 1,4 meter. Jari kaki harus tegak lurus menghadap kedepan. Bentangkan tangan setinggi bahu, pastikan arahnya berada dalam satu garis dan aktifkan seluruh jari tangan, Putar telapak kaki kiri 90 derajat kearah kiri dan dorong tumit kanan keluar sedikit kearah kanan. Perhatikan putaran pada lutut dan telapak kaki kiri, buat kedua elemen ini berada pada satu arah yang sama. Kemudian Buang napas, turunkan tubuh sambilmeregangkan sisi kanan tubuh sepanjang mungkin.

Letakkan telapak tangan kiri di lantai atau pergelangan kaki. Angkat tangan kanan setinggi mungkin kearah langit – langit. Perhatikan posisi tangan yang

harus lurus dan tidak jatuh ke depan atau ke belakang tubuh. Selanjutnya tekan kaki kiri dan tangan kiri untuk memberikan putaran maksimal sehingga dada serta pinggul kanan melebar dan memungkinkan tubuh atas terentang secara maksimal. Arahkan wajah ke tangan kanan, relaksan leher, jatuhkan titik pandangan pada ibu jari tangan kanan



Gambar 5.1
Posisi *Utitha*

2. *Virabhadrasana*

Letakkan kedua tangan ke atas hingga paru-paru terasa terbuka dan penuh dengan udara.



Gambar 5.2
Virabhadrasana

3. *Adho Mukha Svanasana (Downward Facing Dog Pose)*

Atur posisi kaki menjadi sejajar. Saat menghembuskan nafas, pastikan menarik perut ke arah tulang belakang guna untuk mengunci bagian otot di bagian *pelvic floor*. Lakukan selama 10x nafas.



Gambar 5.3
Adho Mukha Svanasana

4. *Plank Pose*

Ambil nafas sebelum melakukan gerakan ini. Letakkan pundak diatas punggung tangan. Tahan kebagian belakang melewati tumit. Posisi rahang rileks

dan tahan sampai 20x nafas. Selanjutnya posisi dari Down Dog ke Plank sebanyak 10x, ambil nafas saat Plank kemudian buang nafas saat posisi *Down Dog*.



Gambar 5.4

Plank Pose

5. *Jathara Parivartanasana (Revolved Abdomen Pose)*

Lutut ditarik ke arah dada. Pastikan perut kedalam dengan mempertahankan pelvic floor. Telapak tangan diletakkan pada lantai. Lutut diletakkan melewati pinggang sehingga kaki membentuk sudut siku siku. Buang nafas dan pundak ditempelkan ke lantai kemudian kaki diletakkan hampir kelantai tanpa menyentuhnya. Lakukan sebanyak 4x pada masing-masing sisi.

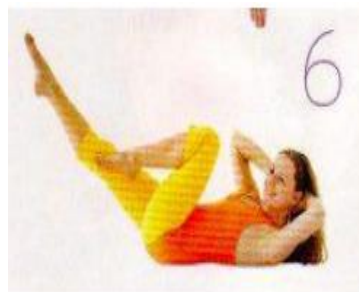


Gambar 5.5

Jathara Parivartanasana

6. *Elbow to Knee Pose*

Jari tangan dikunci dibelakang kepala dan lutut ditekuk. Buang nafas dan luruskan kaki, selanjutnya tekuk lutut kiri ke arah dada dan menempel ke siku kanan. Tarik nafas kendorkan dan buang nafas tiap pergantian posisi. Saat buang nafas tarik otot perut kedalam dan rasakan pelvic floor. Posisi ini dilakukan sebanyak 4x untuk masing masing sisi.



Gambar 5.6

Elbow to Knee Pose

7. *Supta Garudasana (Reclining Eagle Pose) – variation*

Lutut bagian kanan ditekan ke lantai (lihat gambar) dan nikmati stretching ini di bagian pinggang. Tutup mata anda dan tahan posisi ini selama 10x nafas kemudian ganti kaki kiri diatas kaki kanan.



Gambar 5.7

Supta Garudasana

G. Evidence Based Kebidanan

1. Hubungan *Senam Yoga* dengan Proses Involusi Uterus Ibu Nifas

Pada penelitian dengan judul "*Yoga Gymnology of Process Involution Uterus Mom Post-Partum*" yang dilakukan oleh Sunarsih (2021) di wilayah kerja Puskesmas Rawat Inap Lama Bandar Lampung yang meneliti sekitar 60 sampel dimana dibagi menjadi 30 kelompok perlakuan yang diberikan senam yoga dan 32 kelompok kontrol menunjukkan bahwa terdapat perbedaan involusi uterus kelompok intervensi dan kontrol dengan nilai $p = 0,000$, hasil penelitian ini adalah pengaruh senam yoga terhadap involusi uterus ibu nifas di Puskesmas Panjang p -value 0,000 kurang dari 0,005 artinya ada pengaruh senam yoga terhadap proses involusi uteri *postpartum*. Jadi, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh senam yoga terhadap proses involusi uterus.

2. Hubungan Senam Yoga Guna Mengurangi Kejadian Postpartum Blues Pada Ibu Nifas

Pada penelitian dengan judul "*The Effectivities of Yoga Gymnastic To Decrease The Level Of Postpartum Blues Incidence*" yang dilakukan oleh Kusumastuti (2021) menunjukkan bahwa secara klinis pada kelompok perlakuan setelah diberikan *treatment* senam yoga hasilnya menjadi normal, sehingga didapatkan hasil yang signifikan ($p = <0.002$) setelah diberikan *treatment* antara kelompok *pre test* dan *post tes* pada kelompok perlakuan. Kesimpulan senam yoga berpengaruh dalam mengurangi kejadian *postpartum blues*.

DAFTAR PUSTAKA

- Happy, M., & Sari, N. (2017). *Efektifitas Latihan Senam Yogaterhadap Proses Involusi Uterus Ibu Nifas Di Praktek Mandiri Bidan Wilayah*.
- Icesmi, S. (2015). Kehamilan, Persalinan, dan Nifas. In *Nuha Medika*.
- Idhayanti, R. I., Warastuti, A., & Yuniyanti, B. (2020). Mobilisasi Dini Menurunkan Nyeri Akibat Jahitan Perineum Tingkat II Pada Ibu Postpartum. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*.
- Intan Sari, I. S. (2019). Pengaruh Senam Nifas Terhadap Penurunan Tinggi Fundus Uteri (Tfu) Pada Ibu Postpartum Normal Di Wilayah Kerja Puskesmas Prabumulih Barat. *Jurnal Kebidanan: Jurnal Medical Science Ilmu Kesehatan Akademi Kebidanan Budi Mulia Palembang*. <https://doi.org/10.35325/kebidanan.v8i1.121>
- Kusumastuti, Ika, H., Lutfia, I., & Na, U. (2021). The Effectivities of Yoga Gymnastic to Decrease the Level of Postpartum Blues Incidence. *The Effectivities of Yoga Gymnastic to Decrease the Level of Postpartum Blues Incidence, 33(I*CoSIHSN 2020), 431–435.
- Mansyur, N., & Dahlan, K. A. (2016). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Masa Nifas Dilengkapi Penuntun Belajar. *Makara Printing Plus*.
- Muthoharoh, H. (2016). Studi Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Tanda Bahaya Selama Masa Nifas (Di Desa Pomahan Janggan, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan 2015). *JURNAL KEBIDANAN*. <https://doi.org/10.30736/midpro.v8i1.6>
- Rakhshani, A., Nagarathna, R., Mhaskar, R., Mhaskar, A., Thomas, A., & Gunasheela, S. (2015). Effects of Yoga on Utero-Fetal-Placental Circulation in High-Risk Pregnancy: A Randomized Controlled Trial. *Advances in Preventive Medicine, 2015*, 1–10. <https://doi.org/10.1155/2015/373041>
- Rimigravida, P. (2019). *HUbungan aNtara SENam YOga Engan Tingkat. 10(2)*, 291–296.
- Roichana, S., & Pratiwi, Y. A. (2019). Hubungan Senam Nifas, Mobilisasi Dini, dan Tradisi Masa Nifas terhadap Proses Involusi pada Ibu Post Partum. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*. <https://doi.org/10.33221/jiki.v7i04.444>
- Rullyni, N., & Ernawati, E. (2014). Perubahan Fisiologis Masa Nifas. *Jurnal Kesehatan Andalas*.
- Shi, Z.-M., Lin, G.-H., & Xie, Q. (2016). Effects of music therapy on mood, language, behavior, and social skills in children with autism: A meta-analysis. *Chinese Nursing Research*. <https://doi.org/10.1016/j.cnre.2016.06.018>
- Sunarsih (2021). *Yoga Gymnology of Process Involution Uterus Mom Post-Partum. Jurnal Aisyah. Vol 6 No.2 Tahun 2021*
- Wahyuni, R., & Syukur, N. A. (2020). Senam Nifas Dan Mobilisasi Dini Terhadap Penurunan Fundus Uteri Pada Ibu Post Partum Di Puskesmas Temindung.

Mahakam Midwifery Journal (MMJ). <https://doi.org/10.35963/midwifery.v5i1.143>

Winarni, L. M., Ikhlasiah, M., Sartika, R., & Tangerang, U. M. (2020). *Dampak latihan yoga terhadap kualitas hidup dan psikologi ibu nifas*. 6(1), 8–16.

Yoganeka. 2021. 10 gerakan YOGA setelah melahirkan. <https://yoganeka.com/>

BAB 6

PILATES UNTUK MASA NIFAS

Niken Bayu Argaheni,S.ST.,M.Keb.

BAB 6

PILATES UNTUK MASA NIFAS

Oleh: Niken Bayu Argaheni,S.ST.,M.Keb

A. Pendahuluan

Masa nifas merupakan fase transisi yang memiliki efek menentukan pada kesehatan fisik dan mental ibu. Perubahan yang terlibat selama periode ini, termasuk pergeseran hormonal dan awal tugas mengasuh anak yang baru dan asing, dapat menyebabkan ibu primipara mengalami stress dan kelelahan. Kelelahan pascapersalinan, yang merupakan akibat dari pengalaman yang menegangkan dan berlebihan dalam merawat bayi baru lahir, berdampak negatif pada kesehatan ibu, neonatus, dan keluarga. Fenomena ini sering dimulai segera setelah melahirkan dan mencapai tingkat keparahan maksimumnya. dalam waktu 36 jam. Berbeda dengan kepercayaan bahwa ini adalah pengalaman sementara, kelelahan *postpartum* dapat berlangsung lama setelah melahirkan. Tinjauan literatur oleh Groër et al melaporkan bahwa lebih dari 80% ibu mengeluhkan kelelahan *postpartum*. Corwin et al melaporkan kejadian kelelahan *postpartum* sekitar 70% di antara ibu yang telah melahirkan 1-2 bulan sebelumnya. Wanita primipara ditemukan lebih mungkin untuk mengeluh kelelahan postpartum. (Ashrafinia et al., 2015)

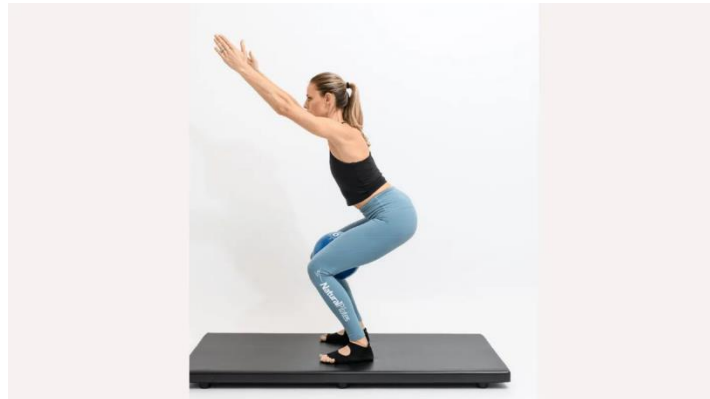


Gambar 6.1

Pilates pada Ibu Nifas (Sumber: whitneyport.com)

Meskipun kelelahan pascapersalinan adalah fenomena umum dan alami, telah mendapat perhatian karena sifatnya yang menyiksa. Bahkan setelah lebih dari dua dekade penelitian, kelelahan pascapersalinan tetap menjadi salah satu dari lima masalah utama pascapersalinan dan perawatannya seringkali menjadi topik yang kontroversial. Penurunan stamina yang dihasilkan menurunkan kemampuan ibu untuk melakukan tugas fisik dan mental; itu juga menurunkan kemampuannya untuk mengelola kebutuhan bayinya, tanggung jawabnya terhadap anggota keluarga lain dan tugas profesionalnya. Selain itu, berkurangnya energi ibu merusak sistem

kekebalan, syaraf, dan mental ibu dan bayi. Ada beberapa bukti yang mendukung efek positif latihan fisik pada kesehatan ibu dan bayi. Teori di balik penggunaan latihan fisik adalah bahwa, dengan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri ibu, latihan pascapersalinan meningkatkan praktik pengasuhan anak dan membantu ibu memainkan peran keibuan mereka dengan lebih efisien. (Ashrafinia et al., 2015; Bump Physio, 2019).



Gambar 6.2
Contoh Gerakan Pilates

Mempertimbangkan keadaan wanita pascapersalinan, olahraga di rumah dianggap yang paling cocok dan juga merupakan jenis olahraga yang paling umum direkomendasikan oleh profesional kesehatan, karena ini menghadirkan lebih sedikit hambatan terkait pengasuhan anak, sehingga ibu berolahraga dengan lebih rela dan dengan motivasi yang lebih besar. Senam Pilates, yang diperkenalkan oleh Joseph Pilates pada awal abad ke-20, dianggap sebagai metode yang baik untuk mempercepat pemulihan setelah hamil. Olahraga ringan pada periode pascapersalinan dapat membantu mempercepat proses penyembuhan dengan memperbaiki dan memperkuat otot yang digunakan dalam persalinan dan kelahiran namun penting untuk memastikan ibu melakukan latihan yang benar. Pilates, yang mencakup latihan inti yang dalam, latihan pernapasan yang terfokus, dan gerakan yang lembut, dapat sangat membantu untuk meningkatkan sirkulasi dan meningkatkan penyembuhan, apa pun jenis persalinan yang dijalani ibu. Ibu dapat melakukan Pilates dengan tikar lengkap di rumah, terkonsentrasi menjadi satu sesi 20 menit, atau dibagi menjadi sesi yang lebih kecil sepanjang hari, antara jadwal makan dan tidur siang bayi. (Ashrafinia et al., 2015; Waller, 2022).

Postnatal Pilates, atau *Postpartum Pilates*, dapat membantu pemulihan dari kehamilan dan persalinan. *Pilates* memperbaiki dan membangun kembali otot yang telah melemah atau rusak, yang dapat meredakan nyeri sendi dan otot serta memungkinkan ibu mendapatkan kembali kekuatan dan stamina. *Postnatal Pilates* juga lembut dan berdampak rendah, menjadikannya cara yang aman untuk kembali berolahraga. *Pilates* adalah bentuk latihan berdampak rendah yang membangun

kekuatan, meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas, serta meningkatkan stamina. *Pilates* memiliki banyak manfaat kesehatan fisik dan mental, termasuk perannya dalam menciptakan postur dan teknik pernapasan yang baik, membantu penurunan berat badan yang sehat, dan mengelola stres. Prinsip *Pilates* adalah melatih dan menantang otot inti. Ini mengacu pada otot di bagian tengah, termasuk otot dalam di perut (otot perut), pinggang (*obliques*), punggung (*erector spinae* dan *multifidi*), otot dasar panggul, dan bokong (otot bokong). Akibatnya, *Pilates* sering dianjurkan selama kehamilan, waktu yang menimbulkan tantangan signifikan bagi stabilitas dan kekuatan inti ibu. (Davis, 2022).

B. Manfaat Pilates Pasca Melahirkan

Postnatal Pilates, juga dikenal sebagai *Postpartum Pilates*, bertujuan untuk membantu pemulihan dari kehamilan dan persalinan dengan meningkatkan aliran darah dan oksigenasi ke otot yang rusak. Latihan *Pilates* pasca melahirkan berdampak rendah dan lembut, memungkinkan ibu baru untuk menyembuhkan dan membangun kembali kekuatan mereka dengan cara yang aman. Berikut beberapa keuntungan *pilates*. (Bump Physio, 2019; Davis, 2022):

1. Memberikan latihan berdampak rendah
Pilates pasca melahirkan memberikan tekanan minimal pada persendian ibu yang penting setelah tekanan ekstra saat mengandung bayi baik selama dan setelah kehamilan.
2. Membangun kekuatan dan stabilitas inti
Hal ini merupakan prinsip utama *Pilates* pascakelahiran dan sangat berguna setelah kehamilan ketika otot inti Ibu meregang dan melemah.
3. Mencegah dan mengurangi sakit punggung
Pilates membangun otot yang menopang tulang belakang Ibu (yang mengalami tekanan selama kehamilan) dan juga mendistribusikan kembali tekanan pada tulang belakang Ibu dan di sekitar panggul dan pinggul Ibu.
4. Melibatkan otot-otot dasar panggul
Pilates memperkuat otot-otot ini (setelah menjadi lebih lemah selama kehamilan dan persalinan) yang dapat melindungi dari *inkontinensia* urin, membantu memperbaiki area antara anus dan vagina setelah kelahiran vagina, dan mencegah *prolaps* (ketika otot-otot ini meregang di bawah tekanan dan dorong ke dinding vagina Ibu).
5. Memperbaiki postur
Pilates memperkuat otot-otot yang mendukung tulang belakang Ibu yang memerangi kebiasaan postur tubuh yang buruk yang dapat didorong oleh kehamilan, menyusui, dan mengangkat bayi Ibu.
6. Mengencangkan otot perut

Pilates menargetkan dan mengencangkan otot perut dan otot miring sekaligus membantu membakar lemak perut dengan cara yang sehat.

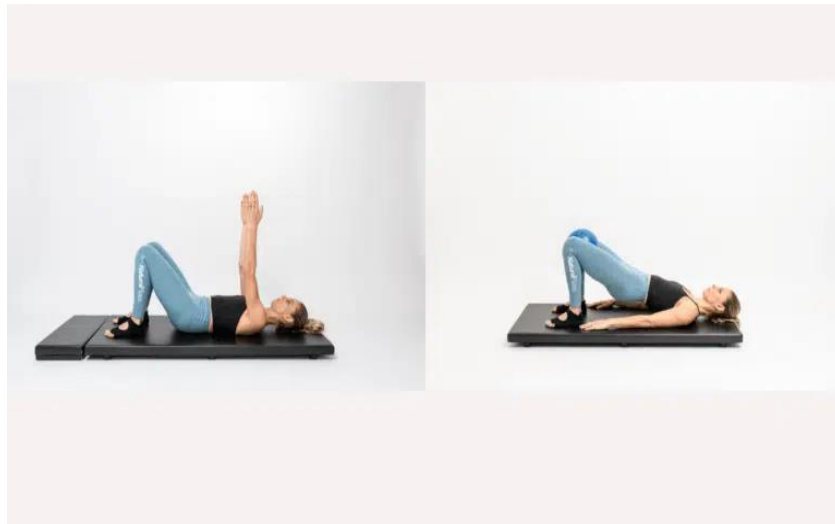
7. Mendukung kesejahteraan mental

Pilates sebagai latihan pikiran-tubuh lengkap yang menggabungkan teknik pernapasan, *Pilates* pasca melahirkan dapat membantu Ibu mengelola stres merawat bayi, mengurangi kelelahan (kelelahan) pasca melahirkan, dan meningkatkan kualitas tidur

C. Latihan Pilates pasca Melahirkan Menggunakan Bola dan Matras

Mini Bola stabilitas (alias Bola Pilates) adalah opsional tetapi melatih otot lebih dalam dan menambah dukungan pada tekukan samping (Waller, 2022)

1. *Bridge with the Ball*

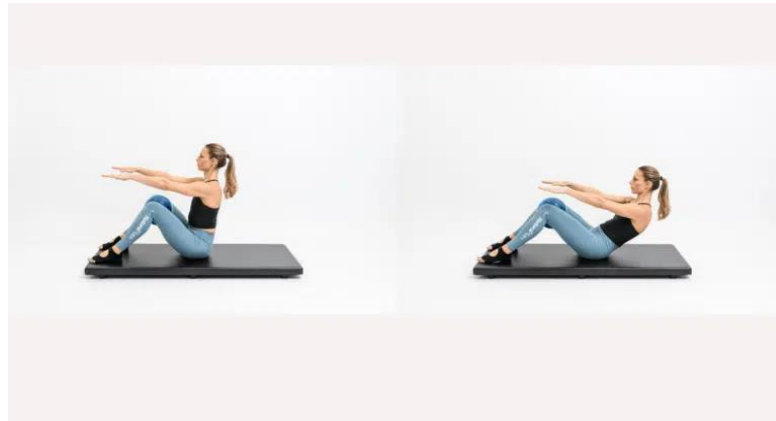


Gambar 6.3
Bridge with the Ball

Teknik:

- Berbaring telentang dengan kaki dekat pinggul dan bola di antara lutut.
- Buang napas: Ratakan punggung, lalu gulingkan tulang belakang dari matras ke posisi jembatan
- Tarik napas: Tahan di bagian atas
- Buang napas: Peras bola 5-10x
- Tarik napas: Tahan remasan
- Buang napas: Perlahan artikulasikan tulang belakang Anda kembali ke matras, satu tulang belakang pada satu waktu. Ulangi 5x.
- Pastikan untuk tidak melengkungkan tulang belakang Anda di bagian atas jembatan.
- Anda harus merasakan glutes Anda terlibat, bukan punggung bawah Anda.

2. *Half Roll Back with Ball*



Gambar 6.4
Half Roll Back with Ball

Teknik:

- Mulailah duduk tegak di atas tulang duduk Anda, bola di antara kedua lutut Anda.
- Jika punggung bawah Anda membulat, duduklah di atas bantal.
- Jangkau lengan Anda ke depan atau letakkan di atas lutut atau punggung paha Anda.
- Buang napas: Jaga agar kaki Anda tetap rata, selipkan panggul Anda ke bawah dan gulingkan setengah jalan ke matras.
- Peras bola saat Anda mencapai rentang akhir
- Tarik napas: Kembali ke posisi awal
- Ulangi 10 hingga 20x dengan satu tekanan atau tambahkan tekanan progresif setiap kali Anda memutar ke belakang untuk meningkatkan tantangan pada perut, paha bagian dalam, dan dasar panggul.

3. *Leg Taps*



Gambar 6.5
Leg Taps

Teknik:

- Mulai telentang, tulang belakang rata dengan kaki di posisi meja (membungkuk 90 derajat di pinggul dan lutut).
- Tarik napas: Pertahankan lutut ditekuk pada sudut 90 derajat, turunkan satu kaki ke arah matras
- Buang napas: Menggunakan perut Anda, tarik kaki kembali ke atas meja. Ingatlah untuk menjaga punggung tetap rata. Lakukan gerakan serendah mungkin saat tulang belakang Anda tetap rata.
- Ulangi 10x setiap sisi.
- Kemudian lakukan 10 set lagi, turunkan kedua kaki bersamaan.
- Untuk menambah tantangan, lakukan urutan yang sama dengan kaki lurus.

*Catatan: Latihan ini juga bisa dilakukan dengan bola di bawah tulang ekor Anda. Ini menambah tantangan keseimbangan tetapi juga dapat membantu meregangkan punggung bagian bawah.

4. *Side Bends on the Ball*



Gambar 6.6

Leg Taps

Teknik:

- Berbaring miring dengan bola di bawah tulang rusuk Anda.
- Gerakkan kaki Anda sejauh jarak matras dengan kaki bagian atas lurus dan kaki bagian bawah ditekuk. Tangan bisa berada di belakang Anda di depan atau di dada Anda.
- Buang napas: Tekuk samping, tekan tulang rusuk atas ke arah pinggul
- Tarik napas: Perpanjang kembali ke posisi awal
- Ulangi 10-20x.

- f. Latihan ini memiliki rentang gerak yang kecil.
- g. Pertahankan tulang rusuk bawah Anda tetap berat di atas bola saat Anda melakukan crunch samping kecil.

5. *Squats with the Ball*



Gambar 6.6
Squats with the Ball

Teknik:

- a. Mulailah dengan kaki sejajar dengan jarak pinggul atau bahu, bola di antara paha bagian dalam Anda.
- b. Buang napas: Tekuk lutut Anda, hanya serendah punggung Anda tetap lurus
- c. Tarik napas: Kembali vertikal, peras bola saat Anda memanjang
- d. Ulangi 10-20x.
- e. Pikirkan untuk mengirim tulang ekor Anda ke belakang dan dada ke depan. Bawa berat badan Anda kembali ke tumit saat Anda berjongkok, lalu ke bagian tengah kaki saat Anda berdiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashrafinia, F., Mirmohammadali, M., Rajabi, H., Kazemnejad, A., Sadeghniaat Haghighi, K., & Amelvalizadeh, M. (2015). Effect of Pilates exercises on postpartum maternal fatigue. *Singapore Medical Journal*, 56(3), 169. <https://doi.org/10.11622/SMEDJ.2015042>
- Bump Physio. (2019). The benefits of Post-natal pilates — Bump Physio - Prenatal and postnatal Physiotherapy. Retrieved 22 December 2022, from <https://www.bumpphysio.com.au/blog/benefits-of-postnatal-pilates>
- Davis, A. (2022). What are the benefits of postnatal pilates? | Patient. Retrieved 25 December 2022, from <https://patient.info/news-and-features/what-are-the-benefits-of-postnatal-pilates>
- Waller, J. D. (2022). 5 Pilates Exercises That Are Safe for Postpartum - Motherly. Retrieved 25 December 2022, from <https://www.mother.ly/health-wellness/fitness/postpartum-pilates-exercises/>

BAB 7

PIJAT PADA IBU NIFAS

Rini Deska, S.ST., M.KM



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 7

PIJAT PADA IBU NIFAS

Oleh: Rini Deska,S.ST.,M.KM

A. Pendahuluan

Pada Masa nifas, banyak ibu yang mengalami nyeri setelah bersalin. Terjadinya nyeri karena proses kontraksi dan relaksasi rahim (*afterpains*), jahitan pada perineum dan pembesaran payudara. Akibat nyeri, ibu akan mengalami ketidaknyamanan, gangguan fisik berupa mudah lelah, gangguan tidur, ASI tidak keluar, telat melakukan mobilisasi dini, dan psikologis berupa kecemasan, kecewa, merasa tidak mampu menjadi ibu, sampai dapat mengalami *postpartum blues* Putri, E., Altika, S., & Hastuji, P. (2022).

Ketidaknyamanan sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik yang dialami ibu misalnya rasa mules akibat dari kontraksi rahim, payudara bengkak, akibat luka jahitan, dan sebagainya. Yulianik, Y. (2019). Penyebab depresi terjadi karena reaksi terhadap rasa sakit yang muncul saat melahirkan dan karena sebab-sebab yang kompleks lainnya. Azizah, N., & Rosyidah, R. (2019)

Intervensi dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri sampai pada tingkat yang dapat diterima ibu. Intervensi dalam mengurangi nyeri dapat dilakukan secara farmakologi atau nonfarmakologi. Namun diupayakan tindakan secara nonfarmakologis, karena lebih aman dan tidak memengaruhi ASI. Salah satunya tindakan nonfarmakologi yaitu dengan pijat. Sitorus, F., & Harianja, E. (2020). masih banyak ibu nifas yang belum pernah mendapatkan *postnatal treatment* pemijatan dimana hal tersebut merupakan tindakan yang dapat membantu agar ASI ibu dapat keluar dengan lancar dan ibu nifas juga merasa segar dan nyaman selama menghadapi masa nifasnya.

Sitorus (2020), menyatakan bahwa teknik pijat *effleurage* dapat digunakan sebagai terapi non farmakologis yang dapat mengatasi *afterpains* pada ibu nifas sehingga mengurangi nyeri yang dirasakan ibu dan akan membuat ibu merasa nyaman.

Masa nifas yang dapat dilalui ibu dengan nyaman, sangat membantu dalam involusi uterus, membantu ASI keluar dengan lancar, sehingga ibu dapat melalui masa nifasnya dengan tenang.

B. Pijat

Pijat pada masa nifas sebagai terapi untuk kesehatan dengan cara melakukan tekanan pada bagian tubuh tertentu, baik secara terstruktur/tidak terstruktur, menetap atau berpindah dengan teknik yang aman bagi ibu dan dilakukan oleh orang yang telah mendapatkan pelatihan (Digity, 2022)

Manfaat pijatan yang dilakukan pada ibu nifas akan merelaksasi tubuh sehingga denyut jantung dan tekanan darah akan bekerja secara normal. Hal ini juga akan memengaruhi hormon stres menjadi menurun dan sebaliknya hormon endorphin yang dapat memberikan rasa tenang dan rasa nyaman akan timbul dan meningkat. Selain itu hormon oksitosin akan meningkat produksinya yang menimbulkan kontraksi pada rahim sehingga bermanfaat untuk proses pemulihan ibu paska melahirkan dan membantu proses menyusui.

Tujuan pijat nifas, memberikan relaksasi dan kenyamanan sehingga terhindar dari *baby blues*, meningkatkan hormon oksitosin untuk melancarkan air susu ibu, meredakan rasa nyeri karena hormone endorphin meningkat, meregangkan otot-otot tubuh yang leleh setelah persalinan, meningkatkan kinerja daya tahan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, menjaga kondisi sendi. Efek relaksasi bertujuan untuk memperlancar aliran darah, mengurangi ketegangan otot, meregangkan dan mengendurkan setiap kelompok otot sekaligus menghasilkan relaksasi seluruh tubuh, selain itu juga dapat menenangkan pikiran dengan cara meregangkan setiap otot. kelompok selama lima detik dan memusatkan perhatian

Untuk Persiapan alat yang digunakan pada saat pemijatan menggunakan minyak zaitun, air hangat, handuk, kain. Adapun persiapan untuk terapis di awal dengan melakukan penjelasan tujuan dan prosedur pelaksanaan dari pemijatan, melakukan *inform consent*, memeriksa kelengkapan alat yang akan digunakan. Melakukan pencegahan infeksi dengan melakukan mencuci tangan.

Langkah pemijatan pada ibu nifas diawali dengan mengganti pakaian ibu dengan kain yang memudahkan untuk pemijatan. Membuat ibu lebih rileks, salah satunya dengan merendam kaki dan melakukan pemijatan lembut lalu keringkan. Lakukan komunikasi pada ibu selama proses pemijatan (Digity, 2022)

C. Tahapan Dalam Pemijatan

1. Tahap pemijatan pada posisi tengkurap

a. Pemijatan pada betis:

- 1) Gosok kedua telapak tangan terapis agar hangat
- 2) Letakan tangan terapis di kedua telapak kaki ibu (3 kali)
- 3) Lakukan pemijatan ringan di telapak kaki sampai tumit ibu (3 kali)
- 4) Usapkan minyak ke betis ibu dari bawah ke atas (pergelangan kaki sampai lutut, sebanyak 4 kali)

- 5) Pijat dengan gerakan membuka menggunakan kedua jari jempol terapis sebanyak 4 kali
 - 6) Pijat dengan cara memutar dengan kedua jempol terapis sebanyak 4 kali
 - 7) Pijat dengan buku buku tangan terapis dari bawah ke atas sebanyak 4 kali
 - 8) Pijat dengan cara meremas secara perlahan-lahan sebanyak 4 kali
 - 9) Pijat dengan mengusap dari atas ke arah bawah sebanyak 4 kali
 - 10) Usap dengan handuk kering untuk membersihkan minyak dan tutup kembali dengan kain
 - 11) Lakukan gerakan 4-11 usapan di betis yang lain.
- b. Pemijatan pada paha
1. Usapkan minyak pada paha dari bawah ke atas sebanyak 4 kali
 2. Pijat dengan gerakan membuka menggunakan kedua ibu jari terapis sebanyak 4 kali
 3. Pijat dengan cara memutar dengan kedua ibu jari terapis sebanyak 4 kali
 4. Pijat dengan buku buku tangan terapis dari bawah ke atas sebanyak 4 kali
 5. Pijat dengan cara meremas secara perlahan-lahan sebanyak 4 kali
 6. Pijat dengan mengusap dari atas ke arah bawah sebanyak 4 kali
 7. Usap dengan handuk kering untuk membersihkan minyak dan tutup kembali dengan kain
 8. Lakukan gerakan 1-7 usapan di paha yang lain
- c. Pemijatan pada pinggul dan bokong
- Lakukan pijatan ringan pada daerah bokong dan panggul sebanyak 4 kali
- d. Pemijatan pada punggung
1. Bebaskan bagian punggung dengan kain penutup
 2. Ambil minyak secukupnya
 3. Usapkan minyak dari bawah ke atas (pinggang sampai bahu)
 4. Pijat dengan menggunakan buku-buku tangan terapis dari bawah ke atas (pinggang sampai bahu sebanyak 4 kali)
 5. Pijat dengan menggunakan buku buku tangan terapis dari pinggang ke arah lipatan ketiak sebanyak 4 kali
 6. Pijat menggunakan buku buku kedua tangan terapis ke arah kanan dan kiri sebanyak 4 kali
 7. Pijat dengan gerakan love
 8. Lakukan langkah 2-6 pada punggung sebelahnya.
- e. Pemijatan pada posisi bahu
1. Pijat menggunakan ibu jari tangan terapis pada area tulang belikat sebanyak 4 kali
 2. Pijat seperti cubitan besar di bagian bahu sebanyak 4 kali
2. Tahap pemijatan pada posisi telentang
- a. Pemijatan pada pergelangan kaki

- 1) Lakukan peregangan kaki ibu dengan menggerakkan kedua telapak kaki ibu ke depan, belakang, ke samping kanan dan ke samping kiri diulang 3 kali gerakan
- 2) Tekuk ke dua kaki ibu dan luruskan kembali, diulang 3 kali
- b. Pemijatan pada kaki depan
 - 1) Bebaskan kain dari kaki ibu, ambil minyak, usapkan minyak ke kaki ibu dari bawah ke atas (pergelangan kaki sampai lutut sebanyak 4 kali)
 - 2) Pijat dengan cara memutar dengan kedua ibu jari terapis sebanyak 4 kali
 - 3) Pijat dengan buku-buku tangan terapis dari bawah ke atas sebanyak 4 kali
 - 4) Pijat dengan cara meremas secara perlahan-lahan sebanyak 4 kali
 - 5) Pijat dengan mengusap dari atas ke arah bawah sebanyak 4 kali
 - 6) Usap dengan handuk kering untuk membersihkan minyak dan tutup kembali dengan kain
 - 7) Lakukan gerakan 1-7 usapan di kaki yang lain
- c. Pemijatan pada paha depan
 - 1) Usapkan minyak pada paha dari bawah ke atas sebanyak 4 kali
 - 2) Pijat dengan gerakan membuka menggunakan kedua ibu jari terapis sebanyak 4 kali
 - 3) Pijat dengan cara memutar dengan kedua ibu jari terapis sebanyak 4 kali
 - 4) Pijat dengan buku buku tangan terapis dari bawah ke atas sebanyak 4 kali
 - 5) Pijat dengan cara meremas secara perlahan-lahan sebanyak 4 kali
 - 6) Pijat dengan mengusap dari atas ke arah bawah sebanyak 4 kali
 - 7) Usap dengan handuk kering untuk membersihkan minyak dan tutup kembali dengan kain
 - 8) Lakukan gerakan 1-7 usapan di paha yang lain
- d. Pemijatan pada tangan
 - 1) Ambil minyak secukupnya, usapkan minyak dari arah bawah ke atas secara perlahan-lahan
 - 2) Pijat bagian punggung tangan menggunakan ibu jari terapis
 - 3) Pijat bagian telapak tangan dengan menggunakan ibu jari terapis
 - 4) Satukan jari jari tangan terapis dengan klien kemudian berikan tarikan lembut pada pergelangan jari jari sebanyak 4 kali
 - 5) Pijat bagian pergelangan tangan ibu
 - 6) Pijat secara memutar dari pangkal lengan ke arah pergelangan
 - 7) Rileksasi bahu (tangan yang satu memegang pangkal lengan ibu dan yang satunya satukan jari jari klien) kemudian putar perlahan lahan
- e. Pemijatan pada wajah
 - 1) Minta ijin kepada ibu untuk melakukan pemijatan di muka dan kepala
 - 2) Lakukan usapan menggunakan 4 jari dari tengah dada menuju ketiak

- 3) Lakukan peregangan lembut ke arah atas pada bagian bawah kepala sebanyak 4 kali
- 4) Miringkan kepala ke kiri, usap bagian kanan kepala ke arah bawah dan tekan bahu secara perlahan, lakukan gerakan yang sama pada sisi sebelah kiri.
- 5) Pijat bagian dagu ke arah kanan dan kiri sebanyak 4 kali
- 6) Pijat bagian bawah hidung ke arah kanan dan kiri sebanyak 4 kali
- 7) Pijat dahi dengan menggunakan 3 jari tangan dari tengah pelipis ke arah samping
- 8) Tekan dahi dengan kedua telapak tangan terapis, saling menepuk.
- 9) Remas rambut pada puncak kepala, tarik lembut dan lepaskan
- 10) Akhiri dengan menghangatkan telapak tangan dan tempelkan telapak tangan terapis ke dagu, mata dan telinga ibu.

Pemijatan telah selesai, berikan respon. Minta ibu untuk menggunakan pakaian kembali, dan ucapkan terimakasih. (Dignity, 2022).

Pemberian pijat pada ibu nifas memberikan efek secara langsung yaitu rasa nyaman. Hal ini terjadi karena pijat punggung akan membuat pembuluh darah dilatasi, otot akan relaksasi, serta kondisi psikologi akan lebih baik karena peningkatan endorphen dan serotonin di otak. (Nugraha, B. A., Fatimah, S., & Kurniawan, T, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N., & Rosyidah, R. (2019). Buku Ajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. *Umsida Press*.
- Digity, T. L. (2022). Modul Pelatihan Mom's Treatmen. Indonesia Dignity.
- Irianti, N. E., Wahyuningsih, M., & Suwarsi, S. (2019). Pengaruh Terapi Pijat Punggung Terhadap Skor Stres Pada Ibu Postpartum Di RSIA Sakina Idaman. *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta*.
- Nugraha, B. A., Fatimah, S., & Kurniawan, T. (2017). Pengaruh Pijat Punggung terhadap Skor Kelelahan Pasien Gagal Jantung. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*.
- Nurfadhilah, R. M. (2021). Aplikasi Tindakan Terapi Effleurage Message Terhadap Nyeri Akut Kontraksi Uterus pada Ibu Postpartum di Wilayah Kerja Puskesmas Cariu Kabupaten Bogor (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi).
- Putri, E., Altika, S., & Hastuji, P. (2022). Pengaruh Pemberian Teknik Massage Effleurage Terhadap Nyeri Persalinan. *Jurnal Bina Cipta Husada*.
- Sitorus, F., & Harianja, E. (2020). Pengaruh Teknik Effleurage Massage Terhadap Nyeri Afterpains Pada Ibu Nifas Multipara di BPM Wanti dan BPM Sartika di Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Health Reproductive*.
- Yuliyani, Y. (2019). Karakteristik Ibu dan Post Natal Treatment (PNT) Berhubungan dengan Terjadinya Postpartum Blues Ibu Nifas. *Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*.

BAB 8

AROMATERAPI PADA MASA POST PARTUM

Lia Fitria, SST., M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 8

AROMATERAPI PADA MASA POST PARTUM

Oleh: Lia Fitria, SST., M.Keb

A. Pendahuluan

Adaptasi pada masa *postpartum* dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikologis. Mulai dari periode kehamilan, persalinan hingga *postpartum* seorang ibu cenderung mengalami kualitas tidur yang tidak seimbang, stres, kecemasan dan kelelahan (Keikhaie, et al., 2019). Perubahan psikologis yang dapat terjadi pada ibu *postpartum* salah satunya stres dapat disebut dengan istilah *baby blues syndrome* yaitu perasaan sedih dan gelisah yang dialami oleh ibu *postpartum* dan terjadi pada hari ketiga atau keempat setelah persalinan. Akan tetapi, dalam beberapa penelitian tidak menggunakan istilah *baby blues syndrome* karena melakukan pembatasan hanya pada gejala-gejala yang mengarah pada tingkat stres dan bukan gejala-gejala *baby blues syndrome* yang gejalanya cenderung ke arah *postpartum depression* (Ningrum, 2017).

Aromaterapi merupakan salah satu terapi komplementer untuk menurunkan stres dan cemas serta perubahan psikologis lainnya yang terjadi pada masa *postpartum*. Selama ribuan tahun, aromaterapi telah digunakan sebagai bentuk obat herbal di negara-negara seperti Iran, Mesir, dan India (Ebrahimi, Mardani, Basirinezhad, Hamidzadeh, & Eskandari, 2021).

Minyak atsiri pada aromaterapi dapat digunakan tidak hanya untuk pengobatan dan pencegahan penyakit, tetapi juga efeknya terhadap *mood*, emosi dan rasa sehat. Aroma yang ditangkap oleh reseptor di hidung dan kemudian memberikan informasi ke area di dalam otak yang mengontrol emosi dan memori maupun memberikan informasi juga ke hipotalamus yang merupakan pengatur sistem internal tubuh, termasuk sistem seksualitas, suhu tubuh, dan reaksi terhadap stress (Zuddin, Abadi, & Khairani, 2019).

B. Aromaterapi

Terapi komplementer dan tradisional banyak digunakan di seluruh dunia. Dunia Organisasi Kesehatan menyatakan bahwa 80% terapi komplementer dan tradisional digunakan sebagai bagian dari layanan perawatan primer di Afrika dan Asia. Obat herbal yang digunakan dalam pengobatan tradisional merupakan 30 - 50% dari obat yang digunakan di China. Negara Turki juga sedang mengembangkan penggunaan terapi komplementer dan tradisional. Dalam literatur, tingkat penggunaan terapi komplementer dan tradisional di Turki adalah 35 - 48% pada individu dengan penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan gagal ginjal dan 65,8% pada individu yang sehat.

Terapi komplementer dan tradisional yang semakin banyak digunakan di bidang kesehatan, juga dapat di gunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi pada wanita seperti nyeri menstruasi, ketidaknyamanan selama kehamilan, persalinan, postpartum, dan menopause (Hamzeh, Faramani, & Khatony, 2020).

Aromaterapi merupakan suatu metode pengobatan alternatif dan terapi komplementer yang berasal dari bahan tanaman dan dalam bentuk minyak esensial. Minyak atsiri yang diuapkan juga dianggap sebagai komponen utama dalam aromaterapi dimana menimbulkan berbagai efek seperti, anti-inflamasi, antiseptik, merangsang nafsu makan, dan merangsang sirkulasi darah. Aromaterapi meyakini bahwa minyak atsiri dapat digunakan tidak hanya untuk pengobatan dan pencegahan penyakit, tetapi juga efeknya terhadap mood, emosi dan rasa sehat. Aroma ditangkap oleh reseptor di hidung yang kemudian memberikan informasi lebih jauh ke area di otak yang mengontrol emosi dan memori maupun memberikan informasi juga ke hipotalamus yang merupakan pengatur sistem internal tubuh, termasuk sistem seksualitas, suhu tubuh, dan reaksi terhadap stress (Shin, Hung, & Hao, 2020).

Terapi dengan aromaterapi akan efektif khasiatnya jika dalam penggunaannya tepat. Penggunaan aromaterapi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu secara oral, topical dan inhalasi (Uzunçakmak & Alkaya, 2022).

Penggunaan aromaterapi secara oral dapat dikonsumsi langsung maupun meneteskan minyak esensial ke dalam minuman atau masakan. Untuk konsumsi secara langsung butuh hati-hati karena tidak semua jenis minyak esensial dapat di konsumsi secara langsung. Penggunaan aromaterapi yang kedua yaitu secara topikal, minyak esensial dapat dioleskan pada bagian tubuh tertentu dengan teknik pijatan yang dapat membuat tubuh menjadi rileks dan segar (Uzunçakmak & Alkaya, 2022). Selanjutnya, penggunaan aromaterapi secara inhalasi atau di hirup Aroma minyak esensial ini akan memicu terjadinya reaksi dalam indera penciuman yang kemudian mengirimkan pesan-pesan tersebut kepada otak sehingga menimbulkan efek relaksasi yang positif yang dapat menurunkan nyeri. Cara kerja bahan aromaterapi adalah melalui sistem sirkulasi tubuh dan sistem penciuman, dimana bau merupakan suatu molekul yang mudah menguap apabila masuk ke rongga hidung melalui pernafasan kemudian akan diterjemahkan oleh otak sebagai proses penciuman. Melalui penghirupan sebagian molekul akan masuk ke paru, kemudian molekul aromatik akan diserap oleh lapisan mukosa pada saluran pernapasan, baik pada bronkus atau pada cabang halus (*bronchiole*) dan terjadi pertukaran gas di dalam alveoli. Molekul tersebut akan diangkut oleh sistem sirkulasi darah di dalam paru. Pernapasan yang dalam akan meningkatkan jumlah bahan aromatik yang ada ke dalam tubuh (Fitria, Febrianti, Arifin, Hasanah, & Firdausiyeh, 2021).

Pada masa *postpartum* merupakan masa pemulihan, mulai dari proses persalinan sampai alat – alat kandungan kembali seperti saat sebelum hamil dan lama masa *postpartum* yaitu 6 -8 minggu. Hal paling penting yang perlu diperhatikan

dalam masa *postpartum* dengan menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik secara fisik dan psikologis. Perubahan adaptasi secara fisiologis yang dapat terjadi misalnya nyeri yang disebabkan robekan jalan lahir dan kontraksi yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada ibu. Sedangkan, perubahan adaptasi secara psikologis pada masa *postpartum* yaitu salah satunya mengalami kecemasan pada ibu *postpartum* (Gampur, Anwar, & Kurniawati, 2022).

Pemanfaatan aromaterapi sebagai salah satu terapi komplementer untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi baik secara fisik maupun psikologis khususnya pada ibu *postpartum*. Jenis essential oil yang umum digunakan pada masa *postpartum* adalah Lavender, Chamomile, Jeruk Lemon, Rosemary, Chamomile Roman, Jasmine/Melati dan Ylang – Ylang/Kenanga.

C. Lavender Oil

Minyak Lavender memiliki nama ilmiah *Lavandula Angustifolia*, jenis keluarga *Lamiaceae* merupakan salah satu minyak atsiri yang paling aman dan tanpa toksisitas. Komponen utama lavender mengandung *linalool* dan *linalyl asetat*, ini dua komponen yang memiliki efek sedatif, *Antinociceptive*, dan *Antispasmodic* menjadi penyebab merangsang sistem parasimpatis. *Linalyl Asetat* juga memiliki efek narkotika dan obat penenang (Hamzeh, Faramani, & Khatony, Effects of Aromatherapy with Lavender and Peppermint Essential Oils on the Sleep Quality of Cancer Patients: A Randomized Controlled Trial, 2020).

Bunga Lavender memiliki 25 – 30 spesies yaitu beberapa diantaranya *Lavandula Lattifolia*, *Lavandula Angustifolia*, dan *Lavandula Stoechas*. Bunga Lavender berbentuk kecil, berwarna ungu kebiruan dan tinggi tanaman mencapai 72 cm. Tumbuhan ini berasal dari wilayah selatan laut tengah sampai Afrika Tropis dan ke arah timur sampai india. Bunga lavender tumbuh pada dataran tinggi, dengan ketinggian berkisar antara 600 – 1.350 meter di atas permukaan laut.



Gambar 8.1

Bunga Lavender (<https://www.google.com/>)

Pada masa postpartum, seorang wanita mengalami perubahan psikologis seperti kehilangan kontrol diri, merasa tidak berdaya, depresi dan kecemasan. Penelitian Modares dkk melaporkan angka kejadian untuk gangguan stres sebesar 20%, trauma persalinan (37,7%), kecemasan postpartum (5 – 20%) dan depresi postpartum (5 - 40%). Kecemasan pada ibu postpartum dapat menyebabkan berkurangnya sekresi oksitosin dan produksi susu. Perawatan pencegahan kecemasan pada masa postpartum meliputi psikoterapi suportif, interpersonal psikoterapi, dan obat-obatan. Obat profilaksis direkomendasikan untuk ibu berisiko tinggi segera setelah persalinan. Sejak penggunaan obat-obatan psikotropika melalui payudara ibu menyusui menyebabkan masalah seperti kantuk yang parah dan berkurangnya respon ibu terhadap tangisan bayi saat tidur, perubahan fungsi seksual, kelelahan, perubahan dalam peran, kebingungan, hipotensi, takikardia, dan lain – lain (Kianpour, Mansouri, Mehrabi, & Asghari, 2016).

Hasil penelitian (Rahayu, Herawati, & Masdad, 2018) menunjukkan bahwa terapi aroma Lavender terbukti dapat memengaruhi tingkat kecemasan ibu *postpartum* dengan seksio sesaria ($P < 0,05$). Penggunaan terapi Lavender dengan waktu yang telah ditentukan dapat menurunkan kecemasan, karena memberikan efek meningkatkan relaksasi. Minyak Lavender umumnya digunakan dengan cara dipanaskan pada tungku sehingga aroma essential oil menyebar di udara dan bisa dihirup secara inhalasi melalui saluran pernapasan atas secara mudah dan diserap oleh alveoli paru-paru untuk kemudian dialirkan melalui pembuluh darah sehingga mencapai susunan syaraf pusat dan menstimulasi sel-sel syaraf pusat tertentu dan menimbulkan efek sesuai dengan sistem syaraf yang distimulasi. Aroma yang tercium akan memberikan efek terhadap fisik dan psikologis.

Terapi aroma biasanya dilakukan melalui inhalasi langsung dan inhalasi tidak langsung. Inhalasi langsung diperlakukan secara individual menggunakan alat kesehatan seperti sungkup atau oksigen mask, sedangkan inhalasi tidak langsung dilakukan secara Bersama-sama dalam satu ruangan seperti terapi aroma Lavender ini. Minyak Lavender yang mengandung *Linalool* menjadi salah satu aromaterapi yang banyak digunakan secara inhalasi. Minyak Lavender yang diteteskan sebanyak lima tetes dengan air 30 ml yang diuapkan selama 15 menit untuk dihirup secara inhalasi oleh ibu (Rahayu, Herawati, & Masdad, 2018).

Aromaterapi Lavender merupakan suatu metode non farmakologi untuk mengurangi nyeri yang menggunakan minyak essential. Ketika aromaterapi dihisap akan mengeluarkan hormon endorphin dan menimbulkan ketenangan serta kebahagiaan. Minyak lavender juga dapat menurunkan intensitas nyeri perineum pada ibu nifas yang mengalami laserasi spontan dan episotomi (Shin, Hung, & Hao, 2020).

D. Chamomile Oil

Chamomile merupakan salah satu ramuan pengobatan sejak zaman kuno. *Chamomile* anggota dari keluarga tanaman *Asteraceae*, terdiri dari dua varietas yaitu *Chamomile* Jerman (*Chamomilla recutita*) dan *Roman Chamomile* (*Chamaemelum Nobile*). Bunga kering dari *Chamomile* mengandung banyak *Terpenoid* dan *Flavonoid* yang berkhasiat sebagai obat. *Chamomile* digunakan untuk beberapa jenis penyakit seperti demam, radang, kejang otot, gangguan haid, susah tidur, maag, luka, gangguan pencernaan, nyeri rematik, dan wasir. Minyak atsiri pada chamomile dapat digunakan sebagai bahan kosmetik dan aromaterapi (Firat, Demirci, & Demirci, 2018).



Gambar 8. 2

Chamomile (<https://id.wikipedia.org/>)

Secara tradisional, *Chamomile* telah digunakan selama berabad-abad sebagai anti-inflamasi, antioksidan, obat astringen dan penyembuhan ringan. *Chamomile* mengandung *Triptofan* yang dapat membantu menyenangkan dan mengurangi kecemasan. Mekanisme dari terapi *Chamomile* dalam menurunkan nyeri yaitu berkenaan dengan mekanisme efek anti inflamasi dan adanya aromaterapi dimana serabut saraf di hidung membawa masukan sensori di otak yang merupakan pusat insting, memori, dan berbagai fungsi vital dibentuk. *Chamomile* paling sering digunakan untuk mengobati gangguan tidur, masalah pencernaan, pereda rasa sakit, dan masih banyak lainnya. Bahan bioaktif utama dari *Chamomile* adalah α -bisabolol, *Farnesene*, *Spiro-Ether Quiterpene Lactones*, *Glikosida*, *Hidroksikumarin*, *Flavonoid* (*Apigenin*, *Luteolin*, *Patuletin*, dan *Kuersetin*), *Coumarin* (*Herniarin* Dan *Umbelliferone*), *Terpenoid*, dan Musin. Bahan lainnya dari bunga *Camomile* termasuk beberapa senyawa *Fenolik*, terutama dalam jumlah yang sangat kecil sebagai *Apigenin* bebas, tetapi sebagian besar *Flavonoid Apigenin*, *Quercetin*, *Patuletin* sebagai Glukosida dan berbagai turunan asetilasi (Srivastava, Shankar, & Gupta, 2010).

Hasil penelitian (Mayangsari & Sari, 2021) menunjukkan bahwa penurunan rasa nyeri perineum setelah diberikan *Aromatherapy Chamomile* pada ibu nifas pada kelompok (kontrol) memiliki nilai tengah 1,53 dan masuk kategori nyeri ringan. Rata-

rata ibu nifas mengalami penurunan rasa nyeri skala 3 (5 responden), skala 2 (7 responden), skala 1 (4 responden) dan yang tidak mengalami penurunan sebanyak 1 responden. Penyebab penurunan kecemasan selain diberikan intervensi *Chamomile* yaitu karena faktor lingkungan, pola makan, dan mobilisasi. *Chamomile* Jerman digunakan sebagai obat karena mengandung *Flavonoid* dan minyak atsiri, dengan konstituen utamanya bisabolol dan oksidannya. Minyaknya juga mengandung *Proazulenes* (seperti *Matricin*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan pemberian aromaterapi *Chamomile*, intensitas nyeri responden mengalami penurunan. Menurut peneliti, hal ini dikarenakan efek dari lilin aromaterapi *Chamomile* yang membuat responden menjadi rileks dan tenang, namun ada beberapa responden yang tidak mengalami penurunan intensitas nyeri, ini dikarenakan responden sulit untuk berkonsentrasi dan rileks.

E. Lemon Oil (Citrus Limonia)

Selama masa *postpartum*, ibu sangat sensitif karena harus menjalani proses penyembuhan diri dan kebutuhan bayi mereka yang baru lahir di saat yang bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan masalah bagi ibu, yang akan memengaruhi kesejahteraan ibu dan bayi tidak akan mendapatkan perawatan maksimal dari ibu. Oleh karena itu, pemulihan yang baik dan efektif selama persalinan akan mempengaruhi kondisi ibu dalam menghadapi masa *postpartum* (Rianti, Rukmaini, & Rifiana, 2020).

Pasca persalinan, seorang ibu akan merasakan nyeri dan trauma pada perineum. Nyeri perineum disebabkan oleh robekan yang terjadi pada perineum, vagina, leher rahim, atau rahim secara spontan atau sebagai akibat dari tindakan manipulatif pada pertolongan persalinan. Efek samping pada nyeri perineum yaitu menyebabkan ibu *postpartum* sangat tidak nyaman (51%), takut melakukan mobilisasi dini (40%) sehingga dapat menimbulkan masalah dan komplikasi selama persalinan.

Metode penatalaksanaan nyeri terbagi menjadi dua yaitu farmakologis dan non farmakologis. Penggunaan metode farmakologi dapat menimbulkan efek samping bagi tubuh. Sedangkan secara nonfarmakologis tidak memiliki efek samping dan aman. Salah satu teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri adalah dengan menggunakan aromaterapi. Aromaterapi lemon merupakan salah satu jenis aromaterapi yang dapat digunakan untuk mengobati rasa nyeri perineum dan mengatasi kecemasan pada ibu *postpartum*. *Linalil asetat* yang terkandung dalam aromaterapi lemon merupakan senyawa ester yang sangat bermanfaat untuk menormalkan keadaan emosi dan kondisi tubuh yang tidak seimbang serta berkhasiat sebagai obat penenang dan memiliki efek analgesik bagi siapa saja yang menghirupnya.

Ketika aromaterapi lemon dihirup, zat yang terkandung di dalamnya akan disalurkan ke pusat penciuman dan sistem limbik. Aroma yang dihasilkan oleh aromaterapi lemon akan merangsang thalamus untuk mengaktifkan pelepasan *neurotransmitter* seperti *encephaline* yang bekerja untuk menghambat rasa sakit, serotonin dan endorphins yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami, menimbulkan rasa tenang, rileks dan bahagia bermanfaat untuk menormalkan keadaan emosi dan kondisi tubuh yang tidak seimbang serta berkhasiat sebagai obat penenang dan memiliki efek analgesik bagi siapa saja yang menghirupnya. Ketika aromaterapi lemon dihirup, zat yang terkandung di dalamnya akan disalurkan ke pusat penciuman dan sistem limbik. Aroma yang dihasilkan oleh lemon akan merangsang thalamus untuk mengaktifkan pelepasan neurotransmitter seperti *encephaline* yang bekerja untuk menghambat rasa sakit, serotonin dan endorphins yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami, menimbulkan rasa tenang, rileks dan bahagia (Rianti, Rukmaini, & Rifiana, 2020).

F. Mawar oil

Terapi komplementer untuk mengurangi kecemasan yaitu aromaterapi. Aromaterapi dapat diberikan melalui beberapa cara yaitu melalui inhalasi, topikal bahkan dikonsumsi, tergantung kondisi dan efek yang diinginkan. Salah satu tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai aromaterapi adalah bunga mawar. Bunga mawar mengandung vitamin C, A, B1, B2, B3, dan K, Asam Sitrat, Asam Malat, Tannis, Pektin, Flavonoid, Dan Karotenoid.

Beberapa penelitian telah melaporkan efek paliatif, merangsang tidur, antikonvulsan, dan relaksasi menggunakan aromaterapi. Cara kerja dari aromaterapi itu sendiri yaitu ketika wewangian diberikan melalui reseptor penciuman, kemudian akan membentuk pesan neurologis yang akan disampaikan ke otak melalui sistem limbik dan menyebabkan otak itu untuk menghasilkan neurotransmitter seperti endorfin, dimana manfaat dari endorfin ini adalah mengurangi rasa sakit dan menimbulkan rasa nyaman (Maliya & Fatimah, 2019).



Gambar 8.3

Bunga Mawar (<https://id.wikipedia.org/>)

Bunga mawar merupakan tanaman bunga hias dengan batang berduri, banyak ditanam di taman dan paling banyak dijual di toko bunga sebagai bunga potong ataupun bunga tabur. Bunga ini berharga karena keindahan dan aromanya, serta bermanfaat dan memiliki banyak khasiat. Minyak maupun ekstraknya sudah sejak dulu digunakan dalam produk sabun mandi, parfum, lotion kulit dan obat-obatan.

Mawar hampir ditemukan di semua Negara di seluruh dunia, sehingga ia dijuluki sebagai "Ratu Segala Bunga (*Queen of Flower*). Bunga mawar mengandung *Geraniol* dan *Citronellol* dengan konsentrasi keduanya mencapai 75% dari minyak. Selain itu, juga terdapat *Linalool*, *Citral* dan *Phenyl Ethyl Alcohol*, *Geraniol Nerol*, *Farnesol*, *Eugenol*, serta *Nonylic Aldehyde* dalam jumlah sedikit. Senyawa *Geraniol* dan *Limonene* yang terkandung dalam ekstrak bunga mawar dapat berfungsi sebagai antiseptik. Penelitian Emerson membuktikan bahwa ekstrak mawar memiliki kandungan *Fenol*, *Carvacrol*, *Thymol*, Dan *Terpene* tinggi dapat membunuh hampir semua mikroba (Mileva, et al., 2021). Pada penelitian Windi (2014) juga membuktikan minyak atsiri bunga mawar memiliki kemampuan dalam menghambat metabolisme energi dan merusak dinding sel serta membran sel bakteri. Selain itu, minyak atsiri juga mengandung gugus fungsi hidroksil (-OH) dan karboksil sehingga kadar tinggi fenol akan menyebabkan koagulasi protein dan membran sel bakteri. Serta bunga mawar membuktikan juga dapat menjadi antijamur pada penelitian Diah (2016) yaitu terhadap *Candida albicans* dikarenakan zat aktif yang terkandung dalam ekstrak mawar merah berfungsi sebagai antiseptik dan anti jamur diantaranya zat *tanin* dan *sitronellol*, di mana zat tanin ini merupakan senyawa kompleks yang memiliki bentuk campuran *polifenol*, senyawa *fenol* yang ada pada tanin inilah yang mempunyai aksi antiseptik dan anti jamur (Fascella, et al., 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Ebrahimi, H., Mardani, A., Basirinezhad, M. H., Hamidzadeh, A., & Eskandari, F. (2021). The effects of Lavender and Chamomile essential oil inhalation aromatherapy on depression, anxiety and stress in older community - dwelling people: A randomized controlled trial. *ELSEVIER*, 1-7.
- Fascella, G., Angiolillo, F., Mammano, M. M., Amenta, M., Romeo, F. V., Rapisarda, P., & Ballistreri, G. (2019). Bioactive compounds and antioxidant activity of four rose hip species from spontaneous Sicilian flora. *Food Chemistry*, 56-64.
- Firat, Z., Demirci, F., & Demirci, B. (2018). Antioxidant Activity of Chamomile Essential Oil and Main Components. *Nat. Volatiles & Essent. Oils*, 11-16.
- Fitria, L., Febrianti, A., Arifin, A., Hasanah, A., & Firdausiyeh, D. (2021). Efektivitas Aromaterapi Lavender dan Peppermint Terhadap Skala Nyeri Haid Pada Remaja Putri. *Jurnal Ilmiah Pannmed (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwifery, Environment, Dental Hygiene)*, 614-619.
- Gampur, I. R., Anwar, M., & Kurniawati, H. F. (2022). The Effect of Lavender Aromatherapy on Postpartum Blues of Primipara Mothers : A Scoping Review. *AIPKIND : Women, Midwives and Midwifery*, 64 - 76.
- Hamzeh, S., Faramani, R. S., & Khatony, A. (2020). Effects of Aromatherapy with Lavender and Peppermint Essential Oils on the Sleep Quality of Cancer Patients: A Randomized Controlled Trial. *Hindawi*, 1-7.
- Hamzeh, S., Faramani, R. S., & Khatony, A. (2020). Effects of Aromatherapy with Lavender and Peppermint Essential Oils on the Sleep Quality of Cancer Patients: A Randomized Controlled Trial. *Hindawi*, 1 -7.
- Keikhaie, K. R., Tolsma, M. H., Bouya, S., Shad, F. S., Sari, M., Shoorvazi, M., . . . Balouchi, A. (2019). Effect of aromatherapy on post-partum complications: A systematic review. *Elsevier : Complementary Therapies in Clinical Practice*, 290-295.
- Kianpour, M., Mansouri, A., Mehrabi, T., & Asghari, G. (2016). Effect of lavender scent inhalation on prevention of stress, anxiety and depression in the postpartum period. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 197-201.
- Maliya, A., & Fatimah, S. N. (2019). Pengaruh Inhalasi Aromaterapi Mawar Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Fraktur Ekstremitas. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 379-386.
- Mayangsari, D., & Sari, D. G. (2021). Manfaat Aromatherapy Lavender dan Chamomile Mengatasi Nyeri Perineum. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1-7.
- Mileva, M., Ilieva, Y., Jovtchev, G., Gateva, S., Zaharieva, M. M., Georgieva, A., . . . Dobрева, A. (2021). Rose Flowers—A Delicate Perfume or a Natural Healer. *MDPI*, 1-32.
- Ningrum, S. P. (2017). Faktor-Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Postpartum Blues. *PSYMPATHIC : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 205-218.

- Rahayu, K. D., Herawati, Y., & Masdad, C. (2018). Pengaruh Terapi Aroma Lavender Terhadap Kecemasan Ibu Dengan Post Sectio Secaria. *JMCRH*, 174-181.
- Rianti, R., Rukmaini, & Rifiana, A. J. (2020). The Effect of Lemon Aromatherapy on Decreasing Perineum Pain among Postpartum Women at Noah Arofah Medika Clinic Bekasi District in 2020. *Journal of Global Research in Public Health* , 164-170.
- Shin, S., Hung, H., & Hao, F. (2020). The Effects of Aromatherapy on Postpartum Women: A Systematic Review. *The Journal of Nursing Research*, 1-11.
- Srivastava, J. K., Shankar, E., & Gupta, S. (2010). Chamomile: A herbal medicine of the past with bright future. *Mol Med Report*, 895-901.
- Uzunçakmak, T., & Alkaya, S. A. (2022). The Use of Aromatherapy in Women's Health. *J Educ Res Nurs*, 240-243.
- Zuddin, R. R., Abadi, H., & Khairani, T. N. (2019). Pembuatan Dan Uji Hedonik Lilin Aromaterapi Dari Minyak Daun Mint (*Mentha piperita* L.) Dan Minyak Rosemary (*Rosmarinus officinalis*) . *Jurnal Dunia Farmasi*, 79-90.

BAB 9

SENAM NIFAS

Wahidah Rohmawati, S.Tr.Keb.,M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 9

SENAM NIFAS

Oleh: Wahidah Rohmawati, S.Tr.Keb.,M.Kes

A. Pengertian

Senam nifas adalah salah satu dari perawatan nifas yang dilakukan untuk mengembalikan perubahan yang terjadi selama kehamilan dan persalinan, yaitu. untuk mempercepat jatuhnya fundus uteri, untuk memfasilitasi keluarnya lokus, untuk mengurangi infeksi postpartum, untuk memperbaiki saluran pencernaan dan saluran pencernaan, fungsi organ reproduksi, meningkatkan sirkulasi darah membantu menghilangkan sisa metabolisme dan produksi susu serta mencegah komplikasi darah baru (Victoria & Selvi, 2021)

Senam nifas adalah aktifitas fisik atau aktifitas meregangkan otot dilakukan setelah melahirkan, diawali dengan senam sederhana, dilanjutkan dengan senam gerakan yang sulit. Senam nifas adalah aktifitas fisik yang dilakukan setelah kelahiran bayi (Saputri et al., 2020)

Senam nifas adalah senam atau gerakan fisik yang dilakukan sesegera mungkin setelah melahirkan, yang berfungsi untuk memulihkan kesehatan, mempercepat pemulihan, mencegah komplikasi, memulihkan dan memperbaiki ketegangan otot pasca kehamilan, terutama pada otot punggung dan dasar panggul. dan perut (Mindarsih & Pattypeilohy, 2020)

Senam dini pasca melahirkan efektif mempercepat turunnya fundus dan keluarnya lokus serta membantu aliran darah ke rahim, yang menyebabkan rahim berkontraksi dengan baik. Kontraksi yang baik membantu menyempitkan pembuluh darah yang terbuka sehingga tidak terjadi perdarahan, fundus uteri turun dan terjadi keausan lebih cepat (Mindarsih & Pattypeilohy, 2020)

B. Tujuan Manfaat

Senam nifas bertujuan untuk;

1. Merangsang otot-otot rahim agar berfungsi secara optimal, sehingga perdarahan nifas tidak terjadi dan rahim dapat kembali ke posisi semula (Mindarsih & Pattypeilohy, 2020).
2. Meningkatkan dan memelihara sirkulasi darah ibu selama masa pospartum
3. Berkontribusi pada proses involusi uterus (Saputri et al., 2020)

C. Manfaat

Senam nifas memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut

1. Membantu pemulihan otot-otot dasar panggul.
2. Mengencangkan kembali otot dinding perut dan bagian perineum.
3. Membantu membutuk posisi tubuh menjadi lebih baik dan sebagai pencegahan terhadap komplikasi. Senam nifas diperuntukan untuk mencegah terjadinya perdarahan pascapartum. Pelaksanaan senam nifas memicu adanya kontraksi pada otot dinding perut. Kontraksi yang terjadi dapat membantu proses involusi uterus (Hestisupriyanti et al., 2016)
4. Mengencangkan kembali sendi-sendi yang longgar selama masa kehamilan.
5. Mencegah terjadinya penurunan organ-organ pinggul.
6. Menurunkan resiko sakit punggung dan pinggang.
7. Mencegah terjadinya varises pada vena.
8. Membantu meredakan kram pada kaki.
9. Membantu kelancaran peredaran darah (Kuswanti & Retno, 2021)

D. Kontra Indikasi Senam Nifas

Beberapa alasan tidak terlaksananya senam nifas pada ibu pasca salin yaitu sebagai berikut

1. Terjadi komplikasi saat persalinan
2. Ibu yang mengalami hipertensi
3. Ibu dengan Riwayat kejang dan demam
4. Ibu dengan Riwayat anemia
5. Ibu dengan Riwayat penyakit jantung dan penyakit paru (Zubaida et al., 2021)
6. Ibu yang mengalami cedar punggung
7. Ibu dengan sciatica
8. Ibu dengan kondisi tegang pada kaki maupun otot
9. Ibu yang mengalami trauma pada perineum parah
10. Ibu dengan nyeri luka operasi Caesar (Kuswanti & Retno, 2021)

E. Waktu Pelaksanaan

1. Senam nifas mulai dilaksanakan sejak 24 jam pasca salin, dan ibu dalam kondisi baik.
2. Senam nifas dijadwalkan setiap harinya, secara berkesinambungan sampai akhir masa nifas dimulai dengan gerakan paling mudah hingga gerakan yang lebih kompleks.
3. Dilaksanakan diantara waktu makan ibu. Tidak dilakukan pada kondisi lapar dan setelah makan.
4. Dilakukan pada waktu pagi ataupun sore hari.

F. Kerugian Bila Tidak Melakukan Senam Nifas

Hulianan, 2003 dalam Retno menyatakan bahwa ada beberapa kerugian jika tidak melaksanakan senam pada masa postpartum, diantaranya adalah;

1. Infeksi akibat involusi uterus yang buruk dimana sisa darah tidak dapat dikeluarkan
2. Perdarahan abnormal, kontraksi uterus yang baik untuk menghindari risiko perdarahan abnormal
3. Trombosis vena (penyumbatan pembuluh darah oleh bekuan darah)
4. Bisa terjadi varises (Retno, 2012)

G. Pelaksanaan Senam Nifas

1. Berbaring telentang dengan tubuh dan kaki lurus. Kontraksikan otot perut dan tekan punggung bawah ke lantai. Tahan posisi ini lalu rileks. Ulangi 5 kali, tujuan langkah ini adalah menangani masalah seksualitas.
2. Berbaring telentang, kedua kaki ditekuk, kedua tangan di atas perut, bernapas melalui mulut, kencangkan perut dan otot rektus untuk mengendurkan perut Kembali, ulangi 8 kali.
3. Berbaring telentang, kedua lengan di samping tubuh, silangkan kaki kanan di atas kaki kiri, tarik napas dan hembuskan napas melalui ruang di antara bibir. Ratakan perut dan kencangkan anus, kosongkan lagi, ulangi 8 kali dan ganti kaki kiri 8 kali.
4. Berbaring telentang, kedua lengan di samping badan lalu putar kedua kaki ke kiri kali, ke kanan kali, dorong kaki kanan dan kiri ke depan dan gerakkan ke belakang, ulangi 8 kali.
5. Berbaring telentang, silangkan tangan di depan dada. Angkat tubuh bagian atas ke posisi duduk. Jika Anda merasa nyaman, letakkan tangan Anda di belakang kepala dan angkat tubuh anda ke posisi duduk.
6. Berbaring di lantai, angkat lutut dan kaki ke lantai. Angkat tubuh dari bahu dan buat kontraksi otot gluteal
7. Berbaringlah di lantai dengan kedua tangan terentang, lalu angkat kedua tangan hingga saling bersentuhan, dan perlahan turunkan kembali ke lantai.
8. Berbaring telentang, tekuk satu kaki dan angkat lutut setinggi mungkin hingga telapak kaki menyentuh selangkangan.
9. Berbaring telentang, angkat kepala dan coba agar dagu menyentuh dada. Tubuh dan kaki tetap di tempatnya.
10. Berbaring telentang dengan tangan di samping tubuh. Angkat kaki lainnya dan jaga agar tetap lurus hingga mencapai sudut 90 derajat. Ulangi dengan kaki lainnya. Jika anda merasa lebih kuat, cobalah bersama.
11. Berbaring telentang dengan kedua kaki ditekuk, letakkan tangan di samping badan, perlahan tarik lutut kiri ke dada, rentangkan tungkai dan kaki kiri, tekuk

- kaki kiri ke belakang, perlahan turun ke belakang. posisi awal, ulang 4 kali, beralih ke kaki kanan, ulangi 4 kali.
12. Berlutut, letakkan dada Anda di lantai sedekat mungkin dengan lutut Anda. Jaga tubuh Anda tetap diam dan kaki Anda sedikit terpisah.
 13. Dalam posisi duduk, kepala ditundukkan dan rileks, putar kepala 4 kali ke kiri lalu 4 kali ke kanan.
 14. Dalam posisi duduk, kedua tangan saling memegang pergelangan tangan, angkat setinggi bahu, geser lengan ke atas siku sekuat mungkin, lalu perlahan geser kembali ke posisi awal, ulangi sebanyak 8 kali.

Hari pertama

Berbaring dengan lutut ditekuk. Letakkan tangan Anda di atas perut di bawah tulang rusuk Anda. Tarik napas perlahan dan dalam melalui hidung, tahan selama 5 atau 8, lalu buang napas melalui mulut. Lakukan sebanyak kali sebanyak 5-10 kali pada pagi dan sore hari.

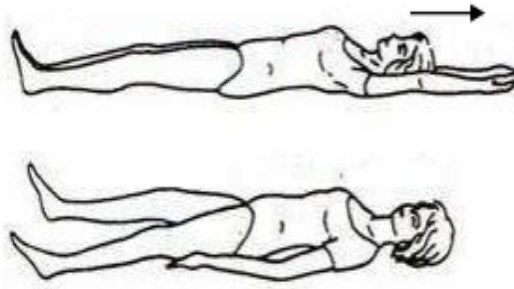


Gambar 9.1
Gerakan Hari Pertama

Rasional: Latihan pernapasan ini dirancang untuk meningkatkan sirkulasi dan pernapasan. Semua organ tubuh disuplai oksigen dengan baik, sehingga juga membantu pemulihan tubuh.

Hari kedua

Di punggung, tangan di atas kepala, telapak tangan terbuka ke atas. Relaksan sedikit lengan kiri Anda dan rentangkan lengan kanan Anda. Pada saat yang sama kali Relaksan kaki kiri dan regangkan kaki kanan sehingga seluruh tubuh melakukan peregangan penuh di sisi kanan. Lakukan gerakan sebanyak 15 kali dengan pada pagi dan sore hari



Gambar 9.2
Gerakan Hari Kedua

Alasan: Latihan ini dirancang untuk memulihkan dan memperkuat otot lengan.

Hari Ketiga

Berbaring telentang. Kedua kaki direntangkan. Tarik dari dasar panggul, tahan selama 3 detik lalu rileks. Lakukan sebanyak 5-6 kali pada pagi dan sore hari.

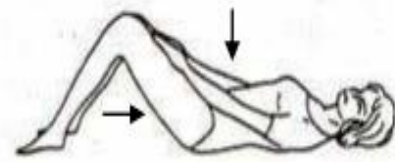


Gambar 9.3
Gerakan Hari Ketiga

Alasan: Tujuan senam ini adalah untuk memperkuat otot-otot dasar panggul yang dulunya bekerja keras saat hamil dan melahirkan.

Hari keempat

Berbaring dengan lutut ditekuk. Tarik/kencangkan otot perut hingga punggung rata dan kencangkan glutes selama 3 detik dan relaks. Lakukan ini 10-15 kali pada pagi dan sore hari.

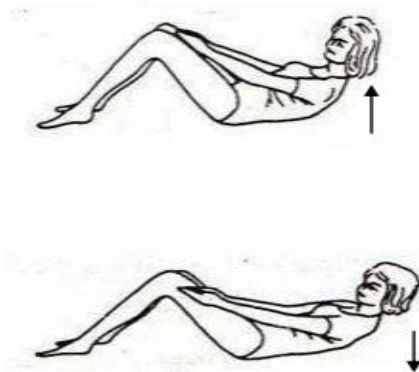


Gambar 9.4
Gerakan Hari Keempat

Alasan: Latihan ini dirancang untuk memulihkan dan memperkuat otot punggung.

Hari kelima

Berbaring telentang dengan lutut ditekuk dan tangan di atas lutut. Angkat kepala dan bahu sekitar 45° , tahan selama 3 detik dan rileks perlahan. Lakukan ini 10-15 kali pada pagi dan sore hari



Gambar 9.5
Gerakan Hari Kelima

Alasan: Tujuan dari latihan ini adalah untuk melatih otot-otot tubuh secara bersamaan, termasuk otot punggung, otot perut dan paha belakang.

Hari keenam

Berbaring dengan posisi terlentang, kaki lurus dan tangan di samping badan, kemudian lutut ditekuk ke perut 90° bergantian kiri dan kaki kanan. Jangan menendang saat menurunkan kaki, lakukan perlahan, tapi dengan kekuatan . Ulangi gerakan tersebut sebanyak 8 kali pada pagi dan sore hari.

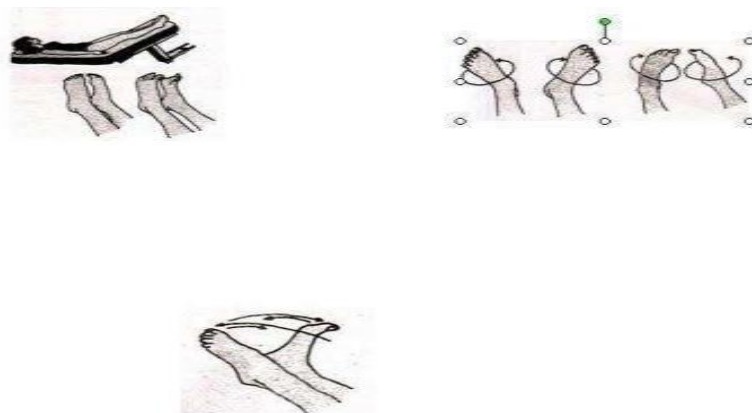


Gambar 9.6
Gerakan Hari Keenam

Dasar Rasional: Latihan ini dirancang untuk memperkuat otot kaki selama kehamilan untuk menopang beban berat. Selain itu, meningkatkan sirkulasi di area kaki, mengurangi risiko pembengkakan kaki.

Hari ketujuh

Tidur telentang, kaki di atas, badan agak ditekuk kaki bagian bawah lebih tinggi. Lakukan gerakan pada jari kaki seperti mencakar dan meregang, lalu gerakkan jari kaki secara teratur dari luar ke dalam, lalu gerakkan kaki kiri dan kanan ke atas dan ke bawah sambil menggergaji telapak kaki. pergerakan Lakukan gerakan ini setiap setengah menit selama 10-15 gerakan pada pagi dan sore hari.



Gambar 9.7
Gerakan Hari Ketujuh

Ingatlah bahwa kekuatan terletak pada perut, jangan gunakan kedua tangan untuk mendorong badan yang ditekuk ke belakang kepala ke posisi duduk, karena dapat menyebabkan sakit leher. Lakukan perlahan, jangan menekan atau memaksanya.

Rasional : Memperkuat otot kaki dan meningkatkan sirkulasi darah, sehingga mengurangi resiko pembengkakan kaki (Ginting, 2015)

H. Persiapan Senam Nifas

1. Pakaian yang nyaman untuk senam punggung.
2. Sediakan untuk diminum, sebaiknya hanya air putih.
3. Dapat dilakukan di atas karpet atau tempat tidur.
4. Ibu yang melakukan senam nifas di rumah sebaiknya memeriksa denyut jantung dengan memegang pergelangan tangan dan merasakan denyut jantung kemudian menghitung selama satu menit penuh. Detak jantung normal adalah 60-90 detak per menit.
5. Jika ibu mau, Anda dapat bergabung dengan musik yang menyenangkan.
6. Pedoman Bidan/Tenaga Kesehatan Merawat Ibu Pada Senam Nifas: Perhatikan kondisi umum dan ketidaknyamanan ibu, pastikan tidak ada kontraindikasi, dan periksa alat vital secara menyeluruh untuk memastikan kondisi ibu sudah pulih, yaitu tekanan darah, suhu pernapasan dan denyut jantung. Selama pelatihan, perhatikan kondisi ibu. Tidak perlu memaksa ibu jika terlihat berat dan lelah. Anjurkan untuk minum air jika perlu (Ginting, 2015)

I. Pengaruh Senam Nifas Terhadap Penurunan Tinggi Fundus Uteri

Salah satu dari gangguan pasca persalinan adalah proses pemulihan fisik ibu setelah melahirkan, yaitu proses involusi uterus. Proses involusi terganggu dimana merupakan subinvolusi yang dapat menyebabkan perdarahan dan kematian ibu. Sebagian besar dari ibu nifas tidak mau melakukan gerakan karena takut melakukan gerakan dapat menimbulkan akibat yang nyata seperti nyeri dan perdarahan, sehingga masih banyak ibu nifas yang takut bergerak dan meninggal sebagian waktu mereka. waktu tidur terus menerus (Saputri et al., 2020)

Senam nifas berpengaruh terhadap penurunan tinggi fundus uteri pasca persalinan pada ibu. Penurunan tinggi fundus uteri lebih cepat pada kelompok postpartum senam dibandingkan dengan kelompok non-olahraga, yang signifikan secara statistik (Rullynil et al., 2014)

Senam nifas berpengaruh signifikan terhadap proses involusi uterus $p=0,000$. Nilai OR sebesar 13.000 berarti bahwa jika senam nifas melakukan senam nifas, ibu nifas 13.000 kali lebih mungkin untuk memproses involusi yang tepat dibandingkan ibu nifas yang tidak melakukan senam nifas (Mindarsih & Pattypeilohy, 2020)

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, M. (2015). *SENAM NIFAS DALAM PELAKSANAAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA IBU NIFAS DI RUANG TANJUNG II RSUD DR. PIRNGADI MEDAN*. Universitas Sumatra Utara.
- Hestisupriyanti, I. S., Ani, M., & Sumarni, S. (2016). PENGARUH SENAM NIFAS TERHADAP TINGGI FUNDUS UTERI DAN JENIS LoCHEA PADA PRIMIPARA. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 1(3), 45–54.
- Kuswanti, I., & Retno, S. W. (2021). *MODUL PRAKTIKUM ASUHAN KEBIDANAN NIFAS DAN MENYUSUI*. Zahir Publishing.
- Mindarsih, T., & Pattypeilohy, A. (2020). PENGARUH SENAM NIFAS PADA IBU POSTPARTUM TERHADAP INVOLUSI UTERUS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ALAK. *Jurnal Kesehatan Madani Medika*, 11(02), 235–246. <http://jurnalmadanimedika.ac.id/index.php/JMM/article/view/129/87>
- Retno, E. D. (2012). *PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DAN MINAT BELAJAR TERHADAP KETERAMPILAN PSIKOMOTORIK DALAM PEMBELAJARAN SENAM NIFAS PADA MAHASISWA KEBIDANAN*. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Rullynil, N. T., Ermawati, E., & Evareny, L. (2014). Pengaruh Senam Nifas terhadap Penurunan Tinggi Fundus Uteri pada Ibu Post Partum di RSUP DR. M. Djamil Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 3(3), 318–326. <https://doi.org/10.25077/jka.v3i3.111>
- Saputri, I. N., Gurusinga, R., & Friska, N. (2020). Pengaruh Senam Nifas Terhadap Proses Involusi Uteri Pada Ibu Postpartum. *Jurnal Kebidanan Kestra (Jkk)*, 2(2), 159–163. <https://doi.org/10.35451/jkk.v2i2.347>
- Victoria, S. I., & Selvi, J. Y. (2021). Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Dengan Pelaksanaan Senam Nifas. *Jurnal Kebidanan Terkini (Current Midwifery Journal)*, 1(1), 45–55. <https://doi.org/10.25311/jkt/vol1.iss1.313>
- Zubaida, Rusdiana, Norfitri, R., & Pusparani, I. (2021). *Asuhan Keperawatan Nifas*. Deepublish.

BAB 10

MANFAAT MADU

PADA MASA NIFAS & LAKTASI

Siti Rusyanti, S.ST.,M.Keb



BAB X

MANFAAT MADU PADA MASA NIFAS & LAKTASI

Oleh: Siti Rusyanti, S.ST.,M.Keb

A. Madu dan Kesehatan

Madu merupakan makanan dengan konsistensi kental, memiliki rasa manis dan pahit (madu hitam). Madu diproduksi oleh lebah madu dan juga serangga lainnya. Hewan tersebut memproduksi madu yang berasal dari gula yang terkandung di dalam pepohonan, sering disebut sebagai nektar bunga maupun berasal dari sekresi serangga lainnya.

Madu telah banyak digunakan oleh manusia di seluruh dunia sejak dahulu kala dalam hal menjaga kesehatan fisik dan sebagai bahan pengobatan alamiah. Telah banyak penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa manfaat madu bagi kesehatan, baik dalam penggunaan konsumsi secara oral maupun sebagai terapi topikal.

Berbagai manfaat madu bagi kesehatan secara umum yakni:

1. Efek *Nutraceutical*

Efek *Nutraceutical* yaitu nutrisi dan farmasi.

Madu mempunyai manfaat fisiologis antara lain:

- a. Memberikan perlindungan terhadap penyakit kronis
- b. Memperlambat proses penuaan
- c. Meningkatkan harapan hidup

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *nutraceutical* dapat mencegah dan mengatasi berbagai penyakit seperti *Diabetes Mellitus*, *aterosclerosis*, *osteoporosis*, penyakit kardiovaskuler, kanker dan penyakit neurologis. Senyawa *nutraceutical* sebagian besar mengandung zat antioksidan seperti halnya madu.(YANTI, n.d.)

2. Sebagai antiseptik dan antibakteri

- a. Madu dapat membunuh bakteri, baik gram positif maupun negatif.
- b. Madu memiliki sifat asam dengan pH antara 3,2 sampai dengan 4,5, hal ini menyebabkan madu dapat mencegah berkembangnya bakteri.
- c. Selain itu, madu merupakan campuran monosakarida dan aktivitas air yang sangat rendah.
- d. Molekul air berhubungan dengan gula dan mikroorganisme.

Hal ini menjadikan madu sebagai media yang tidak baik bagi berkembangbiaknya mikroorganisme. Kandungan air dalam madu

sangat rendah (larutan lewat jenuh), sehingga air yang terkandung dalam suatu sel mikroorganisme yang terpapar oleh madu akan dikeluarkan, hal ini merupakan efek osmotik yang dimiliki oleh sifat madu, kemudian sel menjadi mengkerut dan mati.

- e. Penggunaan madu secara topikal seperti pada luka (dioleskan) maka akan menjadikan madu mencair saat terpapar cairan tubuh dan saat itu akan keluar zat Hidrogen Peroksida secara perlahan-lahan yang berfungsi sebagai antiseptik.
- f. Madu dapat diaplikasikan sebagai dressing pada luka *ulkus* kaki, *decubitus*, *ulkus* kaki *diabetes*, infeksi luka dan pasca operasi serta luka bakar.
- g. Madu sebagai obat topikal yang mudah diabsorpsi oleh kulit sehingga menjaga kelembaban kulit dan memberikan nutrisi pada kulit.

B. Manfaat Madu pada Masa Nifas dan Laktasi

Asuhan kebidanan yang dilakukan pada ibu masa nifas dan menyusui terdiri dari asuhan untuk pemenuhan kebutuhan biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan status kesehatan ibu pada masa pasca persalinan baik persalinan secara normal maupun persalinan dengan tindakan seperti *Vaccum Ekstraksi*, tindakan *Sectio Caesarea (SC)*, dan lain-lain.

Masa nifas merupakan suatu periode pada siklus reproduksi wanita yang ditandai dengan terjadinya berbagai perubahan fisiologis maupun psikologis. Hal ini tidak jarang menimbulkan suatu komplikasi jika klien tidak mendapatkan asuhan yang optimal seperti adanya komplikasi infeksi luka perineum, gangguan proses laktasi, infeksi luka SC, anemia dan rentan terhadap berbagai penyakit.

Asuhan dengan terapi komplementer merupakan salah satu metode yang dapat mendukung asuhan kebidanan pada masa nifas sehingga diharapkan ibu masa nifas dapat melalui proses involusi, pemulihan kesehatan dan proses laktasi dengan baik dan dihasilkan output ibu sehat dan bayi tumbuh dan berkembang secara optimal.

Salah satu bahan alami yang dapat digunakan dalam perawatan ibu masa nifas dan menyusui adalah madu. Telah banyak penelitian yang menunjukkan pemberian madu pada ibu masa nifas dan menyusui yang bermanfaat dalam meningkatkan produksi ASI, menunjang proses laktasi dengan mengatasi puting susu lecet, mempercepat penyembuhan luka perineum dan luka insisi SC, menjaga imunitas dan dapat pula digunakan

sebagai pereda rasa nyeri pasca persalinan yang diakibatkan oleh adanya luka perineum dan luka SC.

Berikut ini *evidence based* terkait penggunaan madu pada masa nifas dan menyusui yaitu:

1. Meningkatkan Produksi ASI

Salah satu penyebab kurangnya volume ASI adalah kurang terpenuhinya nutrisi ibu. Ibu menyusui memerlukan tambahan nutrisi agar produksi ASI dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya. Madu merupakan salah satu bahan makanan alami yang dapat meningkatkan produksi ASI. Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Rizqi, dkk dengan menggunakan madu yang secara langsung dikonsumsi oleh ibu menyusui menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yaitu ibu nifas yang diberikan konsumsi madu menghasilkan ASI matur hari ke-10 sebanyak 703,5 ml/24 jam dibandingkan ibu nifas yang tidak diberikan madu dengan produksi ASI 658,5 ml/24 jam. Hal ini karena madu mengandung nutrisi lengkap terdiri dari karbohidrat dan protein yang bermanfaat bagi energi *hipofise posterior* dalam memproduksi hormon oksitosin dan prolaktin yang masing-masing berperan dalam produksi ASI. (Kamalah, 2021)

Selain madu, nutrisi lainnya yang dapat meningkatkan produksi ASI yaitu jintan hitam. Jintan hitam banyak dikonsumsi terutama oleh wanita di negara India yang mengalami ketidaklancaran produksi ASI. Jintan hitam mengandung polifenol yang tinggi yang dapat meningkatkan kadar hormon prolaktin sehingga produksi ASI menjadi lancar. Dalam praktik pemberian kedua bahan alamiah ini (madu dan jintan hitam) dapat dibuat sebagai minuman berbahan campuran madu dan jintan hitam yang mudah disiapkan oleh ibu di rumah. (Tompunuh et al., 2022).

2. Mengatasi Puting Susu Lecet

Proses laktasi merupakan suatu proses yang sangat penting pada siklus kehidupan manusia dengan harapan kasih sayang ibu dapat dicurahkan kepada bayinya saat ibu menyusui bayinya secara langsung dan bayi memperoleh nutrisi yang paling sempurna sehingga pertumbuhan dan perkembangan bayi berjalan dengan baik. Pada kenyataannya proses laktasi tidak selalu berjalan mulus, seorang ibu menyusui kadangkala mendapat hambatan dalam proses laktasi ini seperti payudara

bengkak/bendungan ASI, mastitis bahkan abses payudara. Hal ini harus diantisipasi sejak awal masa laktasi bahkan sejak masa kehamilan karena masa laktasi ini merupakan masa yang rentan.

Puting susu lecet pada masa menyusui seringkali menjadi penyebab tidak berhasilnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi, hal ini karena ibu mengalami ketidaknyamanan yang sangat mengganggu (rasa sakit karena adanya luka/lecet pada puting susu) yang menghambat proses pemberian ASI bagi bayi. Secara medis, puting susu lecet diberikan terapi antibiotik topikal dan sistemik jika diperlukan. ASI dapat membantu mengatasi puting susu lecet dengan cara dioleskan pada area puting susu yang luka/lecet. Terapi komplementer yang dapat digunakan pada kasus ibu masa nifas dengan puting susu lecet adalah bahan topikal alami madu.

Puting susu lecet dapat diatasi dengan mengoleskan ASI atau madu pada puting susu yang mengalami lecet. Penelitian yang dilakukan pada ibu menyusui dengan puting susu lecet dengan terapi pemberian madu menunjukkan bahwa derajat puting susu lecet menurun dengan pemberian madu secara topikal pada area puting susu lecet. Sehingga petugas kesehatan disarankan untuk memberikan asuhan dan edukasi pada ibu menyusui secara komprehensif termasuk terapi komplementer ini sehingga status kesehatan ibu menyusui meningkat. (Tutik Subagya, Siti Rofiah, 2019)

3. Mempercepat Penyembuhan Luka Jahitan Perineum

Madu merupakan salah satu terapi non farmakologis yang dapat digunakan dalam perawatan luka perineum pada ibu masa nifas. Penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif analitik, pendekatan studi kasus, menunjukkan bahwa perawatan luka perineum dengan terapi topikal madu dapat mempercepat proses penyembuhan luka perineum. Madu mengandung bermacam-macam enzim dan antiviral sehingga dapat menekan risiko kejadian infeksi. Madu banyak mengandung nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh khususnya saat terjadi luka, zat nutrisi yang terkandung dalam madu dapat memenuhi kecukupan nutrisi jaringan luka, selain itu madu mempunyai ciri khas osmolaritas tinggi sehingga dapat menyerap air dan meningkatkan sirkulasi dan bertukarnya udara pada daerah luka perineum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawatan luka perineum menggunakan madu lebih efektif dalam percepatan penyembuhan luka dibandingkan dengan **povidone iodine** 10% dan NaCl 0,9%. Madu mempunyai kemampuan meningkatkan waktu kontraksi luka. Madu efektif sebagai terapi topikal karena kandungan zat yang terkandung dalam madu. Dengan penggunaan terapi topikal madu pada luka perineum, dapat meningkatkan granulasi pada jaringan dan kolagen serta signifikansi pada periode epitelisasi. Pemberian terapi topikal dengan madu diaplikasikan sebanyak 2 kali sehari dengan interval 12 jam, yaitu dengan cara madu sebanyak 5 ml dioleskan pada kassa steril kemudian dilakukan pengompresan pada area luka perineum selama 2 jam. (Zukhruf et al., 2018)

Selain digunakan sebagai terapi topikal secara langsung pada luka, madu dapat mempercepat proses penyembuhan luka perineum dengan cara dikonsumsi secara langsung maupun dengan campuran bahan makanan dan minuman lain.

Madu mempunyai sifat antibakteri, antiseptik, menjaga luka sehingga dapat menurunkan kejadian infeksi pada ibu masa nifas terutama bagi ibu dengan luka jahitan perineum. Madu dapat dikonsumsi setiap hari secara langsung tanpa tambahan makanan/minuman lain maupun ditambahkan dalam air minum, susu, jus buah-buahan, makanan dan minuman lain. (Sebayang & Ritonga, 2021)

Penelitian yang dilakukan pada ibu masa nifas dengan luka jahitan perineum menunjukkan bahwa ibu nifas yang diberikan Jus Nanas dicampur dengan madu 87,5% responden sembuh lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak diberikan Jus Nanas dan Madu yaitu hanya 25%. (Sebayang & Ritonga, 2021)(Setiawati, Iin, Evy Damayanti, 2019)

4. Sebagai analgetik alami

Masa setelah persalinan seringkali menimbulkan keluhan ketidaknyamanan pada ibu masa nifas diantaranya karena rasa nyeri akibat adanya luka perineum atau luka operasi SC. Sebagai seorang tenaga kesehatan memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan termasuk membantu mengatasi keluhan ketidaknyamanan tersebut. Secara medis, keluhan ketidaknyamanan tersebut dapat diatasi dengan pemberian obat

analgetik. Alternatif yang dapat dipilih secara komplementer adalah dengan pemberian madu.

Madu mengandung zat anti inflamasi yang dapat mengurangi keluhan rasa sakit pada luka (luka jahitan perineum maupun luka SC serta meningkatkan sirkulasi yang berpengaruh terhadap proses percepatan penyembuhan luka, mengurangi jaringan parut (bekas luka) pada kulit. (Sebayang & Ritonga, 2021)

Tindakan SC menimbulkan rasa sakit rata-rata setelah 2 jam pembedahan setelah efek anestesi yang diberikan mulai menurun dan menghilang. Rasa nyeri dapat menimbulkan reaksi ketidaknyamanan baik secara fisik maupun psikologis, hal ini harus mendapat perhatian pemberi layanan karena dalam memberikan pelayanan, seorang bidan harus mengedepankan asuhan sayang ibu, jika tidak maka klien akan merasakan berbagai dampak lainnya akibat nyeri seperti terganggunya mobilisasi yang seharusnya dilakukan sejak dini pasca persalinan, hanya ingin berdiam diri karena aktifitas tidak nyaman, tidak bisa tidur dan istirahat dengan optimal, nafsu makan menurun serta tidak dapat merawat bayinya secara mandiri, hal ini perlu diatasi dengan suatu manajemen nyeri sehingga klien dapat beradaptasi dengan rasa nyeri dan proses masa nifas berjalan dengan optimal. (Evrianasari & Eliza, 2019)

Manajemen nyeri terdiri dari berbagai metode yang dapat dilakukan baik oleh pemberi layanan kesehatan maupun dilakukan secara mandiri oleh klien atau dengan bantuan anggota keluarga lainnya. Manajemen nyeri terdiri dari dua cara yaitu cara farmakologis dan non farmakologis, Secara farmakologis, penurunan nyeri dapat diatasi dengan pemberian analgesik baik secara oral, parenteral maupun rectal, dengan tujuan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri. Rasa nyeri dapat juga diatasi dengan cara non farmakologis diantaranya melalui relaksasi, teknik pernafasan, pengaturan posisi klien, *massage*, *acupressure*, kompres panas/dingin, *hypnobirthing*, terapi musik, *Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)* dan dengan pemberian madu. (Evrianasari & Eliza, 2019)

Kandungan yang terdapat di dalam madu yang berfungsi sebagai analgesik alami yaitu *Flavonoid* yang terdiri dari *Apigenin*, *Pinocembrin*, *Kaempferol*, *Quercetin*, *Galangin*, *Chrysin* Dan *Hesperetin*. Mekanisme kerja *Flavonoid* dalam menghambat rasa nyeri yaitu dengan penghambatan

terbentuknya Prostaglandin melalui cara menghambat enzim *Cyclooxygenase* yang merupakan enzim yang dapat mengkatalisis sintesis Prostaglandin dari *Asam Arakhidonat*. *Flavonoid* memblokir aksi dari enzim *Cyclooxygenase*, yang menurunkan produksi mediator prostaglandin, sehingga dapat menghambat rasa nyeri. Selain itu, madu dapat menurunkan Prostaglandin E2, Prostaglandin Alpha 2, dan Thromboxane B2 di dalam darah, sehingga dapat menurunkan rasa nyeri. Mekanisme ini memiliki persamaan dengan mekanisme saat pemberian obat Analgetik/Antipiretik lainnya. (Evrianasari & Eliza, 2019)

Penelitian *quasi eksperimen* dengan pendekatan *one group pretest-posttest design* dengan sampel total populasi sebanyak 33 orang yang dilakukan pada tahun 2018 tentang pemberian madu terhadap nyeri post SC menunjukkan bahwa pemberian madu pada ibu masa nifas pasca tindakan SC berpengaruh terhadap penurunan rasa nyeri dengan hasil penelitian rata-rata nyeri sebelum diberikan konsumsi madu sebesar 6,39 dan setelah diberikan konsumsi madu rata-rata nyeri menurun menjadi 1,0. Pemberian madu sebanyak 5 sendok makan/hari diberikan sejak 2 jam *post SC* selama 14 hari. Hal ini dapat dilakukan sebagai edukasi yang dapat dilanjutkan oleh klien di rumah selama melalui masa nifas (Evrianasari & Eliza, 2019)

5. Mempercepat Penyembuhan Luka SC

Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan dan oleh klien untuk mencegah terjadinya infeksi luka SC. Berbagai penelitian di seluruh dunia telah banyak membuktikan bahwa madu merupakan makanan sehat dan sebagai bahan alami terapi berbagai macam penyakit dan penyembuhan luka. Madu memberikan efek alamiah penghambat pertumbuhan bakteri.

Ibu masa nifas dengan tindakan operasi SC harus mendapatkan perawatan khusus dalam proses penyembuhan luka, diantaranya dengan pemberian antibiotik dan antiseptik. Madu merupakan salah satu bahan alamiah alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan topikal luka SC, hal ini karena madu mempunyai kemampuan untuk memicu laju pembentukan jaringan granulasi serta kolagen yang dapat mempercepat menutupnya luka. Madu mengandung zat antioksidan yang sangat tinggi yang dapat melindungi sel dari radikal bebas. Pada prinsip perawatan luka

modern, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kelembaban luka harus tetap terjaga. Hal ini dapat diperoleh dengan perawatan luka menggunakan madu yang memiliki sifat asam dan sedikit kandungan air di dalamnya sehingga mampu mencegah penetrasi bakteri serta melembabkan area luka. (Fabiana Meijon Fadul, 2019)

Penelitian yang dilakukan dengan *desain quasi eksperimen* menunjukkan bahwa ibu nifas dengan luka SC yang diberikan topikal madu lebih cepat terjadi penyembuhan luka dibandingkan dengan ibu nifas kelompok kontrol yaitu perawatan luka dengan menggunakan NaCl 0,9%. Dengan demikian madu dapat dijadikan sebagai bahan alternatif topikal pada luka SC. (Fabiana Meijon Fadul, 2019)

Madu mempunyai sifat antibakteri, antiseptik, menjaga luka sehingga dapat menurunkan kejadian infeksi pada ibu masa nifas terutama bagi ibu dengan luka SC. Madu dapat dikonsumsi setiap hari secara langsung tanpa tambahan makanan/minuman lain maupun ditambahkan dalam air minum, susu, jus buah-buahan, makanan dan minuman lain. (Sebayang & Ritonga, 2021)

6. Meningkatkan kadar *Haemoglobin* (Hb)

Anemia pada masa nifas (kadar Hb kurang dari 11 gram/dL) seringkali terjadi akibat kondisi anemia saat kehamilan yang tidak tertangani dengan baik maupun akibat komplikasi saat persalinan seperti perdarahan *intrapartum* maupun perdarahan *postpartum*. Kondisi ini harus mendapat perhatian khusus karena kondisi anemia pada masa nifas dapat berdampak terhadap berjalannya proses involusi, berkurangnya produksi ASI, rentan terjangkit infeksi dan penyakit lainnya. Pemberian tablet zat besi (Fe) merupakan asuhan yang telah terstandar dalam mengatasi anemia pada masa nifas. Untuk mendukung peningkatan kadar Hb tersebut, juga terdapat suatu cara alamiah dengan mengkonsumsi madu.

Anemia pada masa nifas dapat diantisipasi sejak masa kehamilan. Pemberian madu pada masa kehamilan trimester III efektif dalam meningkatkan kadar Hb sehingga dapat menekan risiko kejadian perdarahan intrapartum maupun *postpartum* sehingga ibu masa nifas dapat menjalani masa nifas tanpa anemia. Madu mengandung mineral penting bagi tubuh yaitu *Kalsium, Fosfor, Potassium, Sodium, Zat Besi, Magnesium* dan Tembaga. Madu mengandung Glukosa 75%, Asam

Organic 8%, Protein, Enzim, Garam Mineral 18%, Vitamin, Biji Renik, Minyak. Kandungan zat besi tinggi yang terdapat dalam madu dapat meningkatkan kadar Hb ibu hamil dan ibu masa nifas yang mengalami anemia.(Rianti et al., 2021)

7. Menjaga Daya Tahan Tubuh

Madu merupakan bahan makanan berupa cairan gula supernatan. Zat gula yang terkandung di dalam madu adalah fruktosa dan glukosa yaitu jenis gula *monosakarida* yang dapat diabsorpsi oleh usus. Madu mengandung vitamin dan mineral, asam amino esensial dan non esensial dan bahan aromatik, air, karbohidrat, protein, hormon, antibiotik. (Anak, 2019)

Masa nifas merupakan salah satu periode rentan pada siklus reproduksi seorang wanita, terlebih jika wanita memiliki luka jalan lahir maupun luka SC. Nutrisi yang baik sangat diperlukan pada masa nifas ini. Madu merupakan salah satu bahan makanan alami yang berfungsi membantu menjaga daya tahan tubuh ibu masa nifas. Madu mengandung senyawa antioksidan yang tinggi serta antibakteri alami sehingga berperan sangat baik dalam menjaga daya tahan tubuh ibu nifas. Kandungan vitamin yang terdapat dalam madu diantaranya adalah Vitamin C, Vitamin A, Zat besi (Fe) dan vitamin B12 sebagai zat yang berperan dalam pembentukan sel darah merah sehingga dengan mengonsumsi madu dapat sebagai upaya pencegahan anemia dan membantu meningkatkan kadar Haemoglobin darah pada penderita anemia defisiensi zat besi. Petugas kesehatan khususnya bidan dapat memberikan pelayanan kebidanan dan edukasi tentang nutrisi efektif yang baik bagi ibu masa nifas diantaranya jus nanas dan madu. (Sebayang & Ritonga, 2021)

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, I. B. U. (2019). *Asuhan ibu anak*. 6.
- Evrianasari, N., & Eliza, Y. (2019). Pemberian Madu Terhadap Nyeri Post Sectio Caesarea. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 5(3), 229–235. <https://doi.org/10.33024/jkm.v5i3.1461>
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). 済無No Title No Title No Title. 4.
- Kamalah, R. (2021). Perbedaan Pemberian Madu Dan Tidak Diberi Madu Terhadap Volume Asi Matur Ibu Nifas Hari Ke Sepuluh. *Jurnal Kebidanan Sorong*, 1(1), 36–43. <https://doi.org/10.36741/jks.v1i1.139>
- Rianti, R., Choirunissa, R., & Rukmaini, R. (2021). Pengaruh Pemberian Madu Terhadap Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Trimester III di BPM Ny "T" Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 13(2), 148–155. <https://doi.org/10.37012/jik.v13i2.236>
- Sebayang, W. B., & Ritonga, F. (2021). Nutrisi Efektif Mempercepat Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu Post Partum (Systematic Review). *Jurnal Kesehatan*, 12(2), 330. <https://doi.org/10.26630/jk.v12i2.1790>
- Setiawati, Iin, Evy Damayanti, D. N. (2019). PENGARUH PEMBERIAN JUS NANAS DAN MADU TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA PERINEUM PADA IBU NIFAS. *Jurnal Ilmiah Obsgin: Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan & Kandungan*, 11(2). <https://stikes-nhm.e-journal.id/JOB/article/view/208>
- Tompunuh, M. M., Abdul, Y. A., Adam, N. I., & Mustafa, Y. (2022). *Dutohe Barat Provinsi Gorontalo*. 6(3), 2204–2211.
- Tutik Subagya, Siti Rofiah, S. W. (2019). *Efektifitas Pemberian Madu terhadap Derajat Puting Susu Lecet pada Ibu Menyusui*.
- YANTI, A. R. (n.d.). *Nutrasetikal: Era Baru Dalam Kesehatan*. <https://www.esaunggul.ac.id/nutrasetikal-era-baru-dalam-kesehatan/>
- Zukhruf, N., Kiromah, W., Lestari, S., & Astuti, D. P. (2018). *The 8 th University Research Colloquium 2018 Universitas Muhammadiyah Purwokerto PENERAPAN PEMBERIAN MADU UNTUK MEMPERCEPAT PENYEMBUHAN LUKA PERINEUM PADA IBU POST PARTUM APPLICATION OF GIVING HONEY TO ACCELERATE THE PERINEAL WOUND The 8 th University Res*. 561–565.

BAB 11

**HERBAL STEAM BATH UNTUK
MENINGKATKAN PRODUKSI ASI
PADA IBU NIFAS**

Shinta Wurdiana Rhomadona, S.ST.,M.Tr.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 11

***HERBAL STEAM BATH* UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI ASI PADA IBU NIFAS**

Oleh: Shinta Wurdiana Rhomadona, S.ST.,M.Tr.Keb

A. Pengertian

Masa nifas adalah masa selama 6-8 minggu setelah melahirkan yang dimulai setelah selesai proses persalinan dan berakhir setelah alat-alat kandungan kembali ke keadaan sebelum hamil/tidak hamil (Ningsih, D. A., Yunadi, F. D., & Retnowati, M, 2021). Jika timbul masalah pada seorang ibu dapat berdampak juga kepada kesejahteraan bayi karena ibu tidak dapat merawat secara maksimal, akibatnya angka kesakitan dan kematian bayi pun akan semakin bertambah. Oleh karena itu, perawatan pasca persalinan sangat dibutuhkan seorang ibu agar dapat pulih sempurna sehingga dapat kembali sehat serta beraktifitas seperti sebelum hamil dengan cepat dan merawat bayinya dengan sehat. Perawatan pasca salin non-farmakologi dapat dilakukan salah satunya dengan *Herbal steam bath* memanfaatkan energi panas. Panas yang ada akan membuat tubuh berespon dengan mengeluarkan keringat sehingga tubuh menjadi lebih dingin. Mineral, asam lemak, air dan racun-racun di dalam tubuh akan ikut keluar dengan keringat (Sinuhaji, L. N. B, 2015).

Herbal steam bath merupakan suatu budaya kearifan lokal yang sampai saat ini masih dipercaya dan dilestarikan di berbagai wilayah Indonesia sebagai terapi pada ibu pasca melahirkan. *Herbal steam bath* adalah terapi sauna tradisional dengan rempah alami untuk meningkatkan kenyamanan ibu, menurunkan depresi, meningkatkan fungsi jantung ibu sehingga peredaran darah lancar dan bisa membantu mengeluarkan bahan bersifat racun dari sel dan jaringan, sehingga tubuh menjadi sehat dan jiwa pun tenang dan nyaman (Maharani et al., 2019). Tradisi ini, di Maluku terkenal dengan nama *ba'ukup* (Pattinasarany et al., 2020). Beberapa daerah seperti Suku Muna, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengenal tradisi ini dengan nama Terapi Tomboro (Indriastuti & Tahiruddin, 2021), di Suku Karo, Berastagi mengenal tradisi ini dengan nama *Oukup* (Sinuhaji, 2015), sedangkan di Minahasa dikenal dengan istilah *Bakera* (Zumsteg & Weckerle, 2007).

Herbal Steam bath hampir sama dengan mandi sauna namun masih ada kelembaban udara di sekitarnya (Duda, 1987), prinsipnya sama dengan perilaku kesehatan modern yaitu proses mandi uap dan aromaterapi dari rempah daun yang digunakan. Herbal yang biasa digunakan pada proses ini yaitu serai dan daun jeruk purut, bahan tersebut mengandung bahan senyawa bioaktif terutama minyak atsiri, alkoid yang berfungsi sebagai aromaterapi dengan efek meningkatkan relaksasi fisik

dan menyegarkan untuk kesehatan (Zumsteg & Weckerle, 2007).

Banyak kebudayaan yang menganggap bahwa wanita yang baru melahirkan berada dalam kondisi dingin, berbeda halnya dengan saat ketika ia sedang hamil, yang dianggap berada dalam kondisi panas (Foster & Anderson, 2005). Maka dalam kondisi dingin setelah melahirkan, sang ibu dan juga bayinya dianggap memerlukan pemanasan. Wanita yang baru melahirkan di masyarakat Karo diharuskan tidur bersama bayinya di dekat tungku dapur selama sekitar 10 hari sambil didiangi kayu keras yang dibakar secara terus menerus untuk menghangatkan badan mereka (Sinuhaji, L. N. B, 2015).

B. Manfaat Herbal *Steam Bath*

Kehamilan dan persalinan merupakan peristiwa alamiah yang dapat terjadi secara normal atau dengan komplikasi. Secara fisiologi akan banyak perubahan fisik dan psikologi yang terjadi pada proses tersebut. Pada proses tersebut terutama pasca persalinan dapat menyebabkan kelelahan bagi ibu. Kelelahan fisik akibat menyangga beban bayi dalam perut ditambah proses persalinan telah menguras tenaga ibu. Untuk memulihkan kondisi tubuhnya, ibu yang baru melahirkan sebaiknya beristirahat atau tidur. Perawatan tubuh yang baik akan memulihkan kesehatan dan kecantikan ibu (Sinuhaji, L. N. B, 2015).

Manfaat *Herbal Steam Bath* pada prinsipnya adalah memanfaatkan energi panas dari uap yang dihasilkan kemudian ditransfer ke dalam tubuh berpengaruh terhadap sistem peredaran darah, nadi serta sistem endokrin dan respirasi sehingga baik untuk kesehatan tubuh (Rosnani et al., 2019). Banyak manfaat kesehatan yang diperoleh antara lain: (Pattinasarany et al., 2020),(Rosnani et al., 2019),(Polii et al., 2016),(Purnawan et al., 2015)

1. Membuat tubuh ibu nifas menjadi lebih kuat, tidak lemas, dan bahkan 3-4 hari setelah melahirkan ibu sudah dapat beraktifitas sehari-hari sendiri.
2. Menurunkan stres.
3. Mempercantik kulit.
4. Membersihkan racun dari tubuh.

Pada proses mandi uap akan membantu mengeluarkan kembali darah-darah kotor karena biasa berupa bercak atau gumpalan darah yang berwarna merah pekat, sedangkan untuk racun itu sendiri dikeluarkan melalui keringat.

5. Relaksasi otot.
6. Mempelancar peredaran darah.
7. Menurunkan tekanan darah.
8. Peningkatan aliran darah ke seluruh tubuh ibu berdampak pada *Let Down Refleks* (LDR) dalam proses pengeluaran ASI sehingga dapat memperlancar produksi ASI.
9. Menghangatkan ibu.

Pasca melahirkan, ibu biasanya mengalami kedinginan hal ini akibat proses melahirkan yang mengeluarkan banyak darah dan peredaran darah yang belum normal sehingga badan terasa dingin, karena salah satu fungsi darah adalah menghangatkan tubuh. Sehingga melalui proses penguapan yang menghasilkan panas dapat melancarkan peredaran darah kembali dan memancing nafsu makan, sehingga melalui proses itu tubuh dapat hangat kembali.

10. Menghilangkan sakit pinggang
11. Menetralkan kadar gula dalam tubuh
12. Menghilangkan masuk angin atau yang dikenal dengan perut kembung
13. Menurunkan kadar kolestrol secara perlahan-lahan
14. Menurunkan kadar lemak
15. Menyehatkan paru-paru dan jantung
16. Meringankan kepala yang pusing dan flu atau pilek (Sinuhaji, L. N. B, 2015).

C. Tanaman Herbal Yang Digunakan

Masyarakat Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi kesehatan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ramuan hermal pada *steam bath* bisa saja berbeda tiap daerah namun hal ini tidak memengaruhi manfaat dari penggunaan *steam bath*. Bahan *herbal steam bath* antara lain dapat menggunakan tanaman sebagai berikut: (Pattinasarany et al., 2020)

1. Daun Pala (*Myristica Fragrans*),
2. Daun Sereh Merah (*Cymbopogon nardus* (L),
3. Daun Cengkeh (*Syzygium Aromaticum*),
4. Daun Kayu Putih (*Melaleuca Leucadendra*)

Ramuan *herbal steam bath* sebenarnya mudah didapat dan berasal dari tanaman rempah-rempah di mana Indonesia dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbaik. Cara membuat ramuan untuk bahan penguapan yaitu dengan cara:

1. Merebus semua rempah tersebut hingga mendidih, kemudian diangkat.
2. Masih dalam keadaan panas dan beruap, segera seorang ibu duduk di sebuah kursi, kemudian ramuan tersebut di letakkan tepat di bawah atau di sekitar ibu.
3. Kemudian dapat ditutup dengan tikar atau kain di sekelilingnya, di mana tikar atau kain tersebut hanya beruang pas badan.
4. Kemudian bagian atas dari tikar tersebut ditutup dengan kain selimut.

Hal ini bertujuan agar uap panas dari ramuan tersebut tidak keluar, dan dapat diserap oleh tubuh ibu.

5. Selama ibu tersebut melakukan mandi uap ini tidak boleh menggunakan baju.
6. Sese kali ibu dapat mengaduk ramuan panas tersebut agar uap panas dapat keluar dengan sempurna serta ibu dapat menarik napas yang panjang secara perlahan

dan berulang-ulang untuk memperoleh kesegaran dari aroma rempah-rempah dalam ramuan tersebut.

7. Bagi ibu yang baru melahirkan disarankan agar ketika berada di dalam, melebarkan kedua kakinya agar ramuan tersebut tepat berada di bawah kemaluan ibu.

Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan sisa-sisa darah kotor setelah melahirkan.

8. Biasanya pengobatan ukup ini berlangsung selama 15 sampai 20 menit perhari dan berturut-turut dilakukan selama satu minggu dan ramuannya boleh dipanaskan hingga mendidih setiap harinya, atau juga boleh diganti (Pattinasarany et al., 2020).

Cara lain *herbal steam bath* dapat dilakukan dengan Rahu atau diasapkan/dihangat dengan uap panas bara api. Rahu dilakukan dua kali sehari yaitu pagi dan sore setelah mandi selama masa nifas. Bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut: Tempurung kelapa (Cocos nu- cifera) dan kayu bakar.

Cara melakukan Rahu atau diasapkan/dihangat yaitu:

1. Tempurung kelapa dibakar campur menggunakan kayu yang nyala apinya besar kemudian ditunggu 10 sampai 15 menit sampai ada bara api.
2. Biasanya dilakukan di dapur di atas tungku (tempat memasak) atau tidak di dapur dibuatkan perapian baru.
3. Kemudian didekatkan ke ibu dan bayi dihangatkan dengan uap panas bara api bisa menggunakan tangan atau kain.

Hal ini bertujuan untuk menghangatkan ibu dan bayi, merapatkan dinding vagina, dan mengencangkan payudara setelah menyusui.

Menurut Widyaningrum, Herlina, 2011 ada 16 jenis rempah-rempah dasar untuk ramuan penguapan (oukup) dan memiliki khasiatnya masing- masing antara lain sebagai berikut:

Tabel 10.1
Jenis-jenis Tanaman Herbal beserta Manfaatnya

No	Nama Tanaman	Senyawa Bioaktif	Manfaat
1	Daun Kapulaga	Saponin, Flavonoid dan Minyak atsiri	Kram Perut, demam, gangguan haid, influenza
2	Lada Hitam	Saponin, Flavonoid dan Minyak Atsiri	Meningkatkan saluran pencernaan yang tidak lancar
3	Temu Gajah	Saponin, Flavonoid dan Minyak Atsiri	Obat batu ginjal, menetralkan dan membersihkan darah, menambah nafsu makan
4	Temu kunci	Saponin, Flavonoid dan Minyak Atsiri	Kecantikan pada kulit

No	Nama Tanaman	Senyawa Bioaktif	Manfaat
5	Cekala	Saponin, Flavonoid, Polifenol dan Minyak Atsiri	Menghaluskan kerutan-kerutan pada kulit dan memberikan wangi pada kulit
6	Daun Sirih	Fenol	Antiseptik
7	Temu Giring	Saponin, Flavonoid, Polifenol dan Minyak Atsiri	Mengurangi kadar lemak dalam tubuh
8	Lengkuas	Saponin, Flavonoid, Polifenol dan Minyak Atsiri	Rematik
9	Jahe Putih	Polifenol, Flavonoid, dan Minyak Atsir	Penghangat badan
10	Bawang Merah	Saponin, Flavonoid dan Polifenol	Menghangatkan badan dan mengatasi perut kembung
11	Jeruk purut	Saponin, Tannin, Steroid dan Minyak Atsir	Menghangatkan badan
12	Jeruk Pagar	Saponin, Tannin, Steroid dan Minyak Atsiri	Penurun panas
13	Jeruk Puraga	Saponin, Tannin, Steroid dan Minyak Atsir	Pereda batuk Menyembuhkan infeksi pernapasan
14	Jahe Merah	Saponin, Tannin, Steroid dan Minyak Atsiri	Sakit lambung, ginjal, mengatasi masalah pencernaan, sakit kepala
15	Sere Wangi	Eugenol, Flavonoid, Galangol dan Minyak Atsiri	Releksasi, Mengatasi bau badan
16	Cengkeh	Eugenol, Sineol dan Minyak Atsir	Menyembuhkan infeksi pernapasan

Sumber: Widyaningrum, Herlina, 2011



Gambar 11.1
Bahan-bahan yang digunakan dalam *Herbal Steam Bath*



Gambar 10.2

Ramuan *Herbal Steam Bath* yang direbus dengan Alat *Steamer*.

Beberapa budaya selain menggunakan rempah-rempah untuk mandi uap, rempah-rempah tersebut digunakan untuk membuat ramuan herbal yang dapat diminum. Bahan tersebut antara lain (Pattinasarany et al., 2020):

1. Halia/Jahe merah (*Zingiber Officinale*),
2. Temu lawak (*Curcuma Xanthorrhiza*),
3. Lempuyang (*Zingiber Zerumbet*),
4. Kuning/Kunyit (*Curcuma Longa*),
5. Mangale, Gula Merah/Gula Aren (*Arenga Nucifera*),
6. Asam Jawa (*Tamarindus Indica*),
7. Biji Lada (*Piper Nigrum*),
8. Kulit kayu pohon pule/Kulit kayu pohon pulai (*Alstonia Scholaris*).

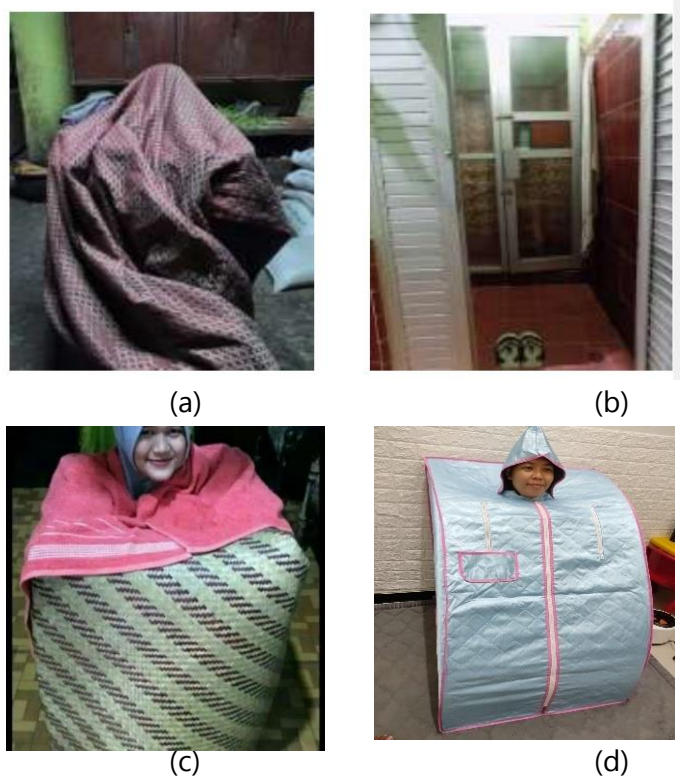
Proses pembuatan ramuan untuk *herbal steam bath* dimulai dengan memarut semua bahan, kemudian direbus hingga mendidih menunggu waktu 15-30 menit. Rempah yang sudah mendidih, kemudian didinginkan dan disaring menggunakan kain bersih atau saringan untuk diminum. Ramuan ini biasanya dimasak oleh dukun kampung atau mama biang sebutan masyarakat Desa Neniari. Ramuan di minum 2 kali yaitu pagi dan sore hari. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit di perut, dan mengembalikan stamina.

D. Pelaksanaan *Herbal Steam Bath*

Herbal steam bath dapat dilakukan secara modern atau tradisional. Cara tradisional dengan menggunakan tikar dan selimut untuk menahan uap atau panas yang keluar dari rebusan ramuan. Pada cara modern dilakukan pada ruangan berlubang yang terbuat dari kaca, kayu atau terpal dengan ukuran tertentu semisal 1x1,5 meter atau 2x3 meter. Ibu nifas duduk pada kursi hingga seluruh badan merasa panas dan bermandikan keringat. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: (Duda, 1987), (Batubara et al., 2017)

1. Suhu tubuh harus dalam keadaan normal.
2. Suhu *steam bath* yaitu 60-80°C.
3. Lama paparan berkisar 15-30 menit tergantung dari ketahanan tubuh seseorang.

4. Jika merasa pusing, mual, panas dan menggigil segera akhiri.
5. Jangan makan makanan atau minum minuman beralkohol sebelum atau selama *steam bath*.
6. Minumlah air yang banyak sebelum masuk dan setelah mandi uap untuk mencegah dehidrasi.
7. Hindari menggunakan *lotion, cream* kosmetik karena dapat menghambat proses berkeringat.
8. Jangan memakai perhiasan, dan jangan memakai pakaian berlebih.
9. Pengidap penyakit jantung, sesak napas, wanita hamil, mabuk atau mempunyai penyakit berat disarankan berkonsultasi ke tenaga kesehatan terlebih dahulu.
10. Setelah selesai keringkan badan dari keringat dan melakukan pendinginan dengan duduk atau beristirahat.
11. Peralatan yang dibutuhkan: Wadah/Panci, Kompor, Sendok Kayu Besar, Kursi, Tikar, Selimut, Handuk Dan Beberapa Penyangga.
12. Tumbuhan obat yang digunakan: Rimpang, Daun, Akar, Batang, Kulit Batang, Buah, Biji, Bunga dan Seluruh Bagian dari Jahe, Lada, Jeruk Purut, Kunyit, Sereh, Sirih (Batubara, 2017).



Sumber : Batubara, Rima Pratiwi, Ervial, A M Zuhut, Hermawan,dkk. 2017.

Gambar 10.3

Cara penggunaan *Herbal Steam Bath*: Secara tradisional (a); Modern di Kamar Mandi (b); Tradisional Tikar Timung (c); Sauna Portabel (d)

E. Evidence Based Kebidanan

1. Hubungan *Herbal Steam Bath* dengan Peningkatan Produksi ASI

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul "*Warm Steam Therapy to Increase Breast Milk Production of Post-Partum Mothers*" yang dilakukan oleh Rosnani, Jawiyah, Mediarti, Devi, 2019 di Puskesmas wilayah Palembang yang meneliti sekitar 64 sampel dimana dibagi menjadi 32 kelompok perlakuan yang diberikan terapi mandi uap dan 32 kelompok kontrol menunjukkan bahwa rata-rata produksi ASI mengalami peningkatan setelah dilakukan perlakuan.

Penelitian lain tentang pemberian Kombinasi *Herbal Steam Bath* dan pijat endorphine pada ibu nifas dalam peningkatan produksi ASI dikatakan bahwa terapi *herbal steam bath* memiliki pengaruh yang signifikan pada peningkatan produksi ASI. Terapi panas yang masuk ke dalam tubuh dan meningkatkan aliran darah, melebarkan pembuluh darah, meningkatkan oksigen dan pengiriman nutrisi ke jaringan lokal, dan mengurangi kekakuan sendi dengan cara meningkatkan elastisitas otot, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan ibu, menurunkan depresi, meningkatkan fungsi jantung ibu sehingga peredaran darah lancar dan bisa membantu mengeluarkan bahan bersifat racun dari sel dan jaringan, sehingga tubuh menjadi sehat dan jiwa pun tenang dan nyaman sehingga membantu menstimulasi hormon oksitosin dan prolaktin dalam memproduksi ASI (Maharani et al., 2019).

Steam bath hampir sama dengan mandi sauna namun masih ada kelembaban udara disekitarnya (Duda, 1987), prinsipnya sama dengan perilaku kesehatan modern yaitu proses mandi uap dan *aromatherapy* dari rempah daun yang digunakan. Herbal yang biasa digunakan pada proses ini yaitu serai dan daun jeruk perut, bahan tersebut mengandung bahan senyawa bioaktif terutama minyak atsiri, alkoid yang berfungsi sebagai aromaterapi dengan efek meningkatkan relaksasi fisik dan menyegarkan untuk kesehatan (Zumsteg & Weckerle, 2007). Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pengobatan dengan terapi uap hangat sangat bermanfaat bagi kesehatan ibu nifas dan dapat dijadikan alternatif pengobatan non-farmakologi (Shinta Wurdiana dan Dianita, 2022).

2. Hubungan Kombinasi *Herbal Steam Bath* dan *Massage Terapi* pada Ibu Nifas dalam Mencegah *Postpartum Blues*.

Berdasarkan penelitian dengan judul "*Kombinasi Herbal Steam Bath dan Massage Terapi pada Ibu Nifas dalam Mencegah Postpartum Blues*" yang dilakukan oleh Maharani, Kristina Anwar, Choirul Suwandono, Agus, 2019 menunjukkan bahwa mandi uap herbal dan terapi pijat lebih efektif dibandingkan perawatan nifas konvensional sehingga hal ini dapat dijadikan terapi alternatif dalam pencegahan *postpartum blues*.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, R. P. (2017). Potensi dan Strategi Pengembangan Oukup sebagai Ekowisata Kesehatan di Kabupaten Karo. In *Diss. Bogor Agricultural University (IPB)*. Bogor Agricultural University (IPB).
- Batubara, R. P., Ervizar, A. M. Z., Hermawan, R. A., & Umanggor, dan R. T. (2017). Nilai Guna Spesies Tumbuhan Dalam Oukup (Mandi Uap) Masyarakat Batak Karo. *Media Konservasi*, 22(1), 79–86.
- Duda, M. (1987). The Medical Risks and Benefits of Sauna, Steam Bath, and Whirlpool Use. *The Physician and Sportsmedicine*, 15(5), 170–182. <https://doi.org/10.1080/00913847.1987.11709359>
- Indriastuti, D., & Tahiruddin, T. (2021). Tomboro: Praktik mandi uap untuk ibu nifas berdasarkan budaya Suku Muna. *NURSCOPE: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan*, 7(1), 6. <https://doi.org/10.30659/nurscope.7.1.6-12>
- Maharani, K., Anwar, C., & Suwandono, A. (2019). Kombinasi Herbal Steam Bath dan Massage Terapi pada Ibu Nifas dalam Mencegah Post Partum Blues. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 2(2), 123–133. <https://doi.org/10.31539/jks.v2i2.509>
- Pattinasarany, G. M., Nusawakan, A. W., & Probowati, H. (2020). Praktik Tradisional Pada Perawatan Masa Nifas. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 5(1), 324.
- Polii, S., Rumampuk, J. F., & Lintong, F. (2016). Pengaruh mandi uap terhadap tekanan darah pada wanita dewasa normal. *Jurnal E-Biomedik*, 4(1), 141–145. <https://doi.org/10.35790/ebm.4.1.2016.10857>
- Purnawan, I., Upoyo, A. S., & Awaluin, S. (2015). Pengaruh Terapi Mandi Uap Terhadap Respon Fisiologis Stress Penderita Hipertensi. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 10(1), 60–66.
- Rosnani, ., Jawiyah, ., & Mediarti, D. (2019). *Warm Steam Therapy to Increase Breast Milk Production of Post-Partum Mothers. Inc*, 373–378. <https://doi.org/10.5220/0008325503730378>
- Sinuhaji, L. N. B. (2015). Oukup Dalam Perawatan Kesehatan Ibu Nifas Pada Suku Karo Di Berastagi Kab. Karo tahun 2014. *Wahana Inovasi*, 4(2), 700.
- Zumsteg, I. S., & Weckerle, C. S. (2007). Bakera, a herbal steam bath for postnatal care in Minahasa (Indonesia): Documentation of the plants used and assessment of the method. *Journal of Ethnopharmacology*, 111(3), 641–650. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2007.01.016>

BAB 12

HYPNOBRESTFEEDING

Muayah, S.KM., SST., M.Tr.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 12

HYPNOBREASTFEEDING

Oleh: Muayah, S.KM., SST., M.Tr.Keb

A. Pengertian Hypnosis/Hypnoterapi

Hipnosis berasal dari bahasa Yunani yang artinya tidur, tapi tidak benar-benar tidur, dimana merupakan suatu kondisi seseorang berada dalam alam bawah sadar. Seseorang yang berada dalam kondisi hipnosis, meskipun tubuhnya beristirahat (layaknya orang tidur), masih bisa mendengar dengan jelas dan merespons informasi yang diterimanya dari luar.

Perkembangan ilmu hipnosis dalam dunia kesehatan, sejak tahun 1890 Dr. Grantley Dick Read mengembangkan dan menerapkan ilmu hipnosis ke dalam ilmu kebidanan dengan program yang disebut "childbirth without fear". Penemuan ini kemudian dilanjutkan oleh Marie F. Mongan dengan mencetuskan program pertama yaitu *Hypno-birthing* dan saat ini di Indonesia, Lanny Kuswandi (seorang perawat dan bidan) sudah mulai mengembangkan dan memperkenalkan ilmu *hipnostetri* kepada para bidan dan dokter dengan berbagai aplikasi *hipnosis* yang salah satunya adalah yang akan dibahas disini tentang *Hypnobreastfeeding*. Hipnosis telah dipelajari secara ilmiah selama lebih dari 200 tahun sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipnosis merupakan suatu kondisi pikiran dimana fungsi analisis logis pikiran direduksi sehingga memungkinkan individu masuk ke dalam kondisi bawah sadar (*subconscious/unconscious*), dimana tersimpan beragam potensi internal yang dapat dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan kualitas hidup. Individu yang berada pada kondisi *hypnotic* atau "*hypnotic trance*" lebih terbuka terhadap sugesti.

Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa hypnotherapy menstimulir otak untuk melepaskan neurotransmitter yaitu zat kimia yang terdapat di otak, encephalin dan endorphin yang berfungsi untuk meningkatkan mood sehingga dapat merubah penerimaan individu terhadap sakit atau gejala fisik lainnya. Sementara menurut Profesor John Gruzelier, seorang pakar psikologi di Caring Cross Medical School, London, guna menginduksi otak dilakukan dengan memprovokasi otak kiri untuk non-aktif dan memberikan kesempatan kepada otak kanan untuk mengambil kontrol atas otak secara keseluruhan.

Hypnoterapi dapat dikelompokkan menjadi beberapa cabang hipnosis seperti: *Hypnobirthing* (*melahirkan* tanpa rasa takut dan meminimalkan rasa sakit), *Hypnobreastfeeding* (bagaimana hipnosis dapat membantu melancarkan ASI),

Hypnoslimming (menurunkan berat badan dengan cara menanamkan program ke bawah sadar supaya dapat mengontrol nafsu makannya), *Hypnobeauty* (hipnosis membantu menghaluskan kulit atau memperbesar payudara), *Hypnosex* (hipnosis membantu keharmonisan suami istri di atas ranjang), *Hypnolearning* (bagaimana hipnosis dapat membantu seorang anak agar dapat lebih optimal dalam belajar), dan masih banyak lagi manfaat hipnosis dalam kehidupan kita.

B. Pengertian Hipnobreastfeeding

Hypnos berasal dari kata Yunani yang berarti tidur/pikiran tenang. Breastfeeding adalah proses menyusui. Jadi pengertian hypnobreastfeeding adalah upaya alami menggunakan energi bawah sadar agar proses menyusui berjalan dengan nyaman lancar, serta ibu dapat menghasilkan ASI yang mencukupi untuk kebutuhan tumbuh kembang bayi. Caranya adalah dengan memasukkan kalimat-kalimat afirmasi positif yang membantu proses menyusui disaat si ibu dalam keadaan sangat rileks atau sangat berkonsentrasi pada suatu hal (keadaan hipnosis)

Hypnobreastfeeding merupakan persiapan ibu menyusui dalam segi pikiran meliputi ketenangan pikiran, sehingga ibu percaya diri bahwa dirinya mampu memberikan ASI yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang bayinya. Persiapan yang dapat dilakukan ibu dari segi jiwa meliputi niat yang tulus dan ikhlas akan memberikan yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk bayinya. Hypnobreastfeeding dilakukan dengan cara memasukkan kalimat-kalimat afirmasi positif yang membantu proses menyusui saat si ibu dalam keadaan sangat rileks atau sangat berkonsentrasi pada suatu hal (keadaan hipnosis). Seperti kita ketahui produksi ASI dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan oksitosin. Produksi kedua hormon ini sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis ibu dan Hypnobreastfeeding ini mampu memberikan ketenangan pada ibu nifas. (Indriyani dan Asmuji, 2016) Semakin ibu tenang, percaya diri dalam memberikan ASI, dan yakin akan memberikan yang terbaik untuk bayinya maka hormon prolaktin dan oksitosin semakin banyak diproduksi.

C. Manfaat Hipnobreastfeeding

Keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan *hipnosis* dalam hypnobreastfeeding adalah sebagai sarana relaksasi, biayanya relatif rendah karena tanpa penggunaan obat-obatan, metode yang digunakan relatif sederhana sehingga mudah dipahami dan dipraktikkan oleh orang banyak, termasuk subjek, dapat dilakukan sendiri oleh subjek (ibu menyusui) dan cukup dibantu oleh satu terapis (bidan), dapat menyehatkan unsur tindakan, perilaku, hasrat, semangat, motivasi, inisiatif, kebiasaan buruk, dan lain-lain, serta mempersiapkan ibu agar

berhasil pada masa menyusui dan mempersiapkan bayi menjadi generasi yang sehat, cerdas dan kreatif.

D. Tujuan Hipnobreastfeeding

1. Mengurangi kecemasan dan stres pada ibu sehingga dapat meningkatkan produksi ASI
2. Menghilangkan kecemasan dan ketakutan sehingga ibu dapat memfokuskan pikiran kepada hal-hal yang positif
3. Meningkatkan kepercayaan diri ibu, sehingga membuat ibu merasa lebih baik dan percaya diri dalam perannya sebagai seorang "*new mum*"

E. Syarat Melakukan Hipnobreastfeeding

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melakukan Hypnobreastfeeding adalah mempersiapkan secara menyeluruh tubuh, pikiran dan jiwa agar proses pemberian ASI sukses, meniatkan yang tulus dari batin untuk memberi ASI eksklusif pada bayi yang kita sayangi dan yakin bahwa semua ibu, bekerja atau di rumah, memiliki kemampuan untuk menyusui/memberi ASI pada bayinya. Kegiatan dimulai dengan memberi sugesti positif. Contoh kalimat sugesti atau afirmasi, misalnya "ASI saya cukup untuk bayi saya sesuai dengan kebutuhannya" atau "Saya selalu merasa tenang dan rileks saat mulai memerah". Kalimat sugesti juga dapat diberikan suami. Tujuan afirmasi positif tersebut adalah untuk menjadikan aktifitas menyusui sebagai suatu kegiatan yang mudah, sederhana dan menyenangkan. Kita harus menyiapkan suasana yang benar-benar nyaman. Hypnobreastfeeding juga bisa dilakukan oleh ibu-ibu hamil untuk mempersiapkan ASI eksklusif buat sang buah hati.

F. Teknik Terapi

Carles Tebbetts dalam bukunya *Miracles on Demand*, mengatakan bahwa pada prinsipnya ada empat langkah *hipnoterapi* untuk memfasilitasi perubahan yaitu:

1. *Sugesti post hipnotis* dan imajinasi (*Posthypnotic suggestion and imagery*)
Sugesti ini dilakukan dalam bentuk memberikan dorongan dalam bentuk sugesti secara benar dan diperkuat dengan imajinasi atau visualisasi, maka ibu hamil akan merasakan perubahan dari apa yang dirasakan sebelumnya.
2. Menemukan Akar masalah (*Discovering the root cause*)
Apabila masalah yang dialami oleh ibu hamil trimester pertama pada masa sekarang adalah akibat dari pengalaman atau persepsi masa kecil, maka dalam hal ini seorang bidan perlu menemukan akar masalah yang sesungguhnya dan menyelesaikan dengan emosi negatif akibat kejadian yang menjadi akar masalah

3. *Release* Terapi dilakukan untuk membantu ibu hamil trimester pertama melepas atau *merelease* perasaan atau emosi negatif dari pengalaman dimasa lalu.
4. Pemahaman Baru/*Re-learning (New Undertanding)*
Tujuannya adalah untuk membantu ibu hamil untuk membuat pemahaman baru, berdasarkan cara pandang dan kebijaksanaan orang dewasa, terhadap masalah yang dialami, akar masalah, dan solusinya.

G. Teknik Relaksasi

Teknik *hypnobreastfeeding* sama dengan teknik *hypnobirthing* karena juga melibatkan *pikiran* bawah sadar dengan cara mengistirahatkan alam sadar melalui teknik relaksasi.

Teknik *relaksasi* dalam *hypnobreastfeeding* terdiri atas tiga tahap yaitu:

1. Ibu melakukan relaksasi otot mulai dari puncak kepala sampai telapak kaki, termasuk wajah, bahu kiri dan kanan, kedua lengan, daerah dada, perut, pinggul, sampai kedua kaki. Caranya bisa dengan membayangkan otot-otot menjadi relaksasi.
2. Relaksasi napas.
Zaman sekarang orang-orang rentan mengalami stress. Stres karena dituntut untuk melakukan segala sesuatu serba cepat dan terburu-buru. Apalagi, perempuan yang memiliki peran ganda sebagai seorang ibu sekaligus wanita karier. Untuk mencapai kondisi relaks adalah dengan cara tarik napas panjang melalui hidung dan hembuskan keluar pelan-pelan melalui hidung atau mulut (fokuskan pernapasan di perut). Lakukan selama beberapa kali sampai ketegangan mengendur dan berangsur hilang
3. Relaksasi pikiran.
Seringkali pikiran seseorang berkelana jauh dari raganya. Untuk itu, belajarliah memusatkan pikiran agar berada di tempat yang sama dengan raga. Salah satu cara dengan berdiam diri atau meditasi dengan mengosongkan pikiran dan memejamkan mata dengan napas yang lambat, mendalam dan teratur selama beberapa saat. Setelah otot-otot rileks, nafas teratur, serta pikiran tenang, baru dilakukan sesi *hypnobreastfeeding*. Ibu-ibu menyusui juga bisa melakukan *hypnobreastfeeding* di rumah, caranya mudah, masuklah ke dalam ruangan yang tenang, nyalakan musik khusus untuk relaksasi, sediakan *aromatherapy*, dan ikuti panduan relaksasi otot, napas, dan pikiran yang telah dipelajari sebelumnya, baru melakukan afirmasi yang positif.
Pikiran bawah sadar secara otomatis akan membimbing untuk melakukan atau *memikirkan* hal-hal tertentu, misalnya yakin bahwa kita bisa menyusui dan ASI akan mengalir deras. Cara lain yang sederhana adalah dengan mendengarkan suara bayi serta perhatikan alur napasnya. Jika hal tersebut dilakukan secara

teratur, akan menimbulkan bonding dan selanjutnya memicu tubuh untuk menghasilkan hormon endorfin (hormon pembawa rasa senang dan tenang) sehingga tubuh merasa rileks.

H. Pikiran, Tubuh dan ASI

Produksi ASI tergantung pada dua faktor yaitu faktor fisiologis dan psikologis. Kondisi stres dan kesibukan sehari-hari dapat memengaruhi produksi ASI. Jadi *pikiran* bisa memengaruhi sistem di dalam tubuh. *Hypnobreastfeeding* merupakan cara yang bagus untuk mendorong pola pikir dalam menyusui yang tepat.

Beberapa studi penelitian menunjukkan bahwa bayi yang diberi ASI terlindungi dari sebagian besar penyakit anak-anak dan memiliki perkembangan otak lebih baik. *Selain* itu wanita yang menyusui memiliki resiko lebih rendah dari kanker payudara, kanker ovarium dan bahkan patah tulang panggul (akibat osteoporosis) di kemudian hari. Jadi menyusui merupakan simbiosis mutualisme antara bayi dan ibu dimana bisa saling menguntungkan.

I. Menyusui dan Relaksasi

Relaksasi yang dalam dan teratur membuat sistem endokrin, aliran darah, persyarafan dan system lain di dalam tubuh anda akan berfungsi lebih baik. Sikap positif sangatlah penting seperti merasa tenang dan rileks selama menyusui. Pada saat ibu rileks dikala menyusui maka hormon endorphin yang diproduksi ibu pun akan mengalir ke bayi Anda melalui ASI, dan ini membuat bayi anda akan merasakan kenyamanan, ketenangan yang ibu rasakan.

Relaksasi hypnobreastfeeding mampu menghadirkan rasa santai, nyaman dan tenang selama menyusui dengan demikian maka seluruh sistem di dalam tubuh akan berjalan jauh lebih sempurna sehingga proses menyusui pun menjadi proses yang penuh arti dan menyenangkan baik bagi ibu dan bayi. Bahkan hypnobreastfeeding mampu membantu ibu yang mengalami kesulitan saat menyusui juga dapat membuat ibu mampu untuk relaktasi. Dengan demikian produksi ASI cukup untuk kebutuhan bayi sampai usia 6 bulan. Kemudian bayi tetap menyusu hingga berumur dua tahun karena otak bayi mengalami perkembangan paling pesat di usia tersebut.

J. Pengeluaran ASI Sebelum Hypnobreastfeeding

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebelum dilakukan teknik hypnobreastfeeding kepada ibu nifas mayoritas ASI yang tidak lancar yaitu sebanyak 27 orang (90%) dan yang normal sebanyak 3 orang (10%). Kecemasan yang dialami ibu postpartum saat menyusui bayinya membuat ibu menghindari dan tidak mau memberikan ASI pada bayinya, akan berdampak terhadap kurangnya isapan pada bayi dan akan berpengaruh terhadap kurangnya produksi ASI sehingga membuat ASI tidak lancar. Ibu yang berhenti menyusui dan tidak memberikan ASI tetapi malah memberikan susu formula kepada bayinya, akan mengakibatkan penurunan dan

kinerja hormon oksitosin dan prolaktin yang akan membuat produksi ASI semakin sedikit serta menyebabkan bendungan dan statis ASI.

Salah satu penyebab kurangnya cakupan ASI adalah terjadinya puting lecet yang parah, bayi rewel selanjutnya ibu merasa air susu yang keluar tidak mungkin akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bayinya karena ASI masih sedikit. Penyebab minimnya cakupan air susu ibu juga dapat dipengaruhi oleh cara menyusui yang salah. Cara menyusui yang salah akan menyebabkan putingmsusu ibu lecet, ibu enggan menyusui sehingga bayi jarang menyusu. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya produksi air susu ibu.

Berdasarkan asumsi dari peneliti rasa nyaman serta ketenangan bagi ibu nifas sangat mempengaruhi terhadap pengeluaran ASI, dengan dilakukan teknik hypnobreastfeeding dapat memengaruhi kerja oksitosin sehingga ibu bisa merasakan rileks pada saat menyusui. Kurangnya asupan, istirahat dan dukungan pada ibu juga memengaruhi dalam proses pembentukan ASI. Ibu-ibu nifas kurang memahami pentingnya ASI pada bayi sampai usia 2 tahun.

K. Pengeluaran ASI Sesudah Teknik Hypnobreastfeeding

Teknik hypnobreastfeeding adalah suatu upaya alamiah yang dilakukan dengan menggunakan terapi dengan memberikan kalimat-kalimat sugesti positif supaya pada saat sedang menyusui tidak terjadi hambatan dalam pengeluaran air susu ibu. Dengan menggunakan kalimat-kalimat sugesti positif dan memotivasi pada saat kondisi ibu dalam keadaan tenang dan fokus terhadap suatu hal/keadaan hypnosis sehingga air susu yang dihasilkan akan mampu mencukupi kebutuhan bayinya.

Keadaan ini sebenarnya tergantung bagaimana ibu dalam mengendalikan pikiran, sebab jika didalam niat dan pikiran ibu konsisten untuk menyusui bayinya dan selalu memikirkan nilai-nilai yang positif, dukungan suami dan keluarga memungkinkan akan tercapainya dalam pemberian air susu secara eksklusif selama minimal enam bulan tidak akan sulit bagi ibu. Diharapkan dengan teknik hypnobreastfeeding akan memberikan jalan keluar dalam proses pemecahan masalah dalam pengeluaran air susu ibu, serta akan mampu mengatasi hambatan dalam proses menyusui. Dengan menggunakan teknik hypnobreastfeeding bisa membuat perasaan ibu menjadi tenang dan nyaman sehingga akan memepercepat proses pengeluaran ASI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan dilakukannya teknik hypnobreastfeeding dapat membuat ibu menjadi lebih tenang dan rileks sehingga meningkatkan hormon oksitosin dan menghasilkan volume air susu pada ibu nifas. Menurut asumsi peneliti teknik hypnobreastfeeding sebaiknya dilakukan sebelum menyusui. Dengan adanya perlakuan teknik hypnobreastfeeding ini membuktikan bahwa penting dilakukan teknik hypnobreastfeeding pada ibu menyusui.

DAFTAR PUSTAKA

- Armini Ni Wayan. 2016. Hypnobreastfeeding Awali Suksesnya ASI Eksklusif. Jurnal Skala Husada.
- Asih, Yusari dan Risneni. 2016. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui dilengkapi dengan Evidence Based Practise dan Daftar Tilik Asuhan Nifas. Jakarta: Trans Info Media
- Dewi. 2013. Hipnosis pada Kehamilan, Persalinan dan Periode Pasca Persalinan dapat Mencegah Depresi Pasca Melahirkan. Jurnal Ilmiah Kebidanan.
- Indriyani dan Heni. 2014. Efektifitas Kombinasi Hypnobreastfeeding dan Konsumsi Blustru Terhadap Optimalisasi Produksi Kolostrum pada Ibu Postpartum di Rumah Sakit dr. Soebadi Jember. The Indonesian Journal of Health Sciene.
- Yuni dan Heni. 2014. Pengaruh Hypnobreastfeeding terhadap Kecemasan dan Waktu Pengeluaran ASI pada Ibu Postpartum Primipara di Yogyakarta. Jurnal Teknologi Kesehatan.

BAB 13

***PARENTING SELF-EFFICACY* PADA IBU NIFAS**

Rini Mustikasari Kurnia Pratama,S.Si.T.,M.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 13

***PARENTING SELF-EFFICACY* PADA IBU NIFAS**

Rini Mustikasari Kurnia Pratama,S.Si.T.,M.Keb

A. Parenting Self-Efficacy

Parenting merupakan suatu proses yang kompleks, sedangkan *self-efficacy* mengacu pada keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam melakukan suatu perilaku. *Parenting Self-Efficacy* disingkat sebagai PSE. PSE merupakan keyakinan orang tua terhadap kemampuan dirinya dalam menjalankan peran sebagai orang tua atau memberikan pengaruh positif sehingga memberikan pengaruh terhadap perilaku anaknya (Nurbaiti et al., 2021). PSE akan memengaruhi anak di kemudian hari dalam menghadapi masalah, misalnya individu dengan tingkat PSE tinggi akan mampu melewati tahapan-tahapan perkembangan dengan baik tanpa adanya stres bahkan depresi. Tingkat *Parenting Self-Efficacy* yang baik akan mendapatkan responsivitas terhadap kebutuhan anak, keterikatan dalam interaksi langsung dengan orang tua, serta beberapa persepsi tentang masalah perilaku pada anak (Leahy-Warren & McCarthy, 2011).

Parenting self-efficacy tinggi ditemukan pada ibu yang cenderung memiliki anak dengan *tingkat* emosional lebih rendah dan lebih ramah, berpendidikan lebih baik, memiliki pendapatan keluarga lebih tinggi dan lebih berpengalaman dalam hal pengasuhan anak. Tingkat *Parenting Self-Efficacy* yang rendah berkaitan dengan kecenderungan orang tua untuk fokus pada kesulitan-kesulitan dalam hubungan, pengaruh negatif, perasaan ketidakmampuan dalam berperan sebagai orang tua, *autonomic arousal* yang tinggi, dan cenderung menghukum anak. *Parenting Self-Efficacy* sangat penting untuk dimiliki oleh orang tua untuk dapat memberikan pengasuhan yang positif (Salonen et al., 2009).

Keyakinan orang tua pada efikasi diri mereka sendiri telah dihubungkan dengan fokus yang lebih besar pada perencanaan, yang pada gilirannya menyebabkan tingkat kepuasan orang tua yang lebih tinggi dan kesejahteraan afektif yang lebih besar. Orang tua dengan keyakinan *Self-Efficacy* yang lebih kuat cenderung merencanakan tindakan saat merawat anak. Orang tua dengan PSE rendah mungkin memiliki akses terbatas ke strategi regulasi kognitif yang efektif untuk menyesuaikan respons emosional mereka. PSE dipengaruhi secara negatif oleh stres ibu, kecemasan, depresi pascapersalinan, kelelahan, kepuasan pengasuhan, dan kompetensi dalam peran pengasuhan (Botha et al., 2020).

Self-efficacy ibu *postpartum* sangat penting untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ibu dalam melakukan perawatan bayi baru lahir secara efektif.

Self-efficacy memengaruhi penilaian, usaha, ketahanan, pilihan hidup, dan ketekunan ibu dalam beradaptasi menjadi orang tua. Proses menjalankan peran sebagai orang tua melibatkan hubungan dengan bayi dan pengembangan keterampilan dalam tugas pengasuhan anak. *Parenting Self-Efficacy* sangat berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak yang optimal. Ibu dengan *Parenting Self-Efficacy* tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan tugas sebagai orang tua, lebih responsif setiap terdapat isyarat dan kebutuhan bayi, serta memiliki hubungan interaksi yang lebih baik dengan anak. Keadaan ini akan meningkatkan tanggung jawab ibu dalam merawat anak dan menurunkan kejadian kekerasan pada anak (Botha et al., 2020; Oktafia et al., 2022).

Parenting Self-Efficacy memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan ibu. *Parenting Self-Efficacy* yang tinggi akan menurunkan risiko terjadinya stres, depresi postpartum, dan kecemasan ibu. *Parenting self-efficacy* berhubungan positif dengan kesejahteraan orang tua, kepuasan perkawinan dan fungsi keluarga, serta kepuasan peran menjadi orang tua. Sebaliknya, *parenting self-efficacy* yang rendah dapat menimbulkan konflik perkawinan, kurang memiliki waktu santai dan menyenangkan dengan anak, dan mengalami kesulitan yang tinggi dalam melakukan tugas pengasuhan bayi. *Parenting self-efficacy* juga menjadi *predictor* dalam praktik pengasuhan bayi dan berhubungan erat dengan perkembangan anak. Pengkajian *Parenting Self-Efficacy* pada periode awal *postpartum* dalam mengidentifikasi ibu atau kelompok yang berisiko serta menentukan intervensi yang tepat dalam membantu menyelesaikan masalah ibu (Nurbaiti et al., 2021; Oktafia et al., 2022).

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Parenting Self-Efficacy*

Parenting self-efficacy dapat dibangun dan ditingkatkan melalui beberapa komponen sumber informasi sebagai berikut (Botha et al., 2020):

1. *Enactive Mastery Experience* (pengalaman dalam penguasaan tindakan)

Komponen ini berhubungan dengan pengalaman keberhasilan dan kegagalan dalam melakukan suatu tugas tertentu. Pengalaman masa lalu ibu sangat berpengaruh terhadap *self-efficacy* nya, baik kegagalan maupun keberhasilan dalam merawat anaknya akan memengaruhi kepercayaan diri dan meningkatkan *self-efficacy* dalam mencari solusi saat menghadapi kesulitan dalam merawat anak selanjutnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa ibu primipara memiliki skor *parenting self-efficacy* lebih rendah dibandingkan ibu *multipara* atau *grandemultipara*.

2. *Vicarious Experience* (pengalaman pemodelan/kinerja orang lain)

Keberhasilan ibu dalam menguasai suatu tindakan akan memengaruhi *self-efficacy* nya. Persepsi *self-efficacy* ibu akan meningkat ketika melihat ibu lain berhasil melakukan tugas tertentu, namun sebaliknya kegagalan ibu lain juga dapat

menurunkan *self-efficacy* ibu. Keberhasilan orang lain biasanya akan memberikan motivasi pada ibu untuk berhasil terutama apabila melakukan model atau tindakan yang sama. Semakin ibu memiliki kesamaan model atau tindakan maka akan semakin besar pengaruh keberhasilan atau kegagalan model terhadap *self-efficacy*. Perbedaan model atau tindakan juga tidak akan berpengaruh terhadap *self-efficacy* ibu.

3. *Persuasion Verbal*

Persuasi verbal sebagai upaya untuk meyakinkan ibu dalam kemampuannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Persuasi dapat diberikan dapat melalui informasi dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan setiap ibu. Informasi dan dukungan dari tenaga kesehatan serta suami maupun keluarga selama periode *postpartum* akan memengaruhi keyakinan ibu terhadap kemampuannya dalam menjalankan perannya sebagai orang tua. Ibu yang diberi persuasi akan memiliki motivasi dan kemauan yang lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak diberi persuasi untuk menyelesaikan perannya sebagai orang tua.

4. *Physiological and Affective State*

Physiological and Affective State disebut juga sebagai kondisi emosi dan fisik. Keadaan cemas dan stres dapat mengancam kemampuan diri seorang ibu dalam menyelesaikan perannya sebagai orang tua. Penurunan fungsi fisik akan menghasilkan kinerja yang buruk. Kelemahan dan kelelahan setelah melahirkan dapat memengaruhi *parenting self-efficacy* ibu *postpartum*. Hasil akhir asuhan kebidanan pada ibu nifas dan menyusui ditujukan untuk pemulihan dan peningkatan fungsi fisik, serta memberikan kesejahteraan psikologis ibu sehingga ibu mampu beradaptasi selama periode *postpartum* dan menjalankan peran sebagai orang tua dengan baik. Adanya *parenting self-efficacy* yang tinggi berhubungan negatif dengan kejadian gejala depresi konsep diri yang tidak baik.

Kecemasan selama masa nifas dapat dianggap sebagai faktor yang mengkhawatirkan karena secara negatif mengganggu ikatan afektif antara ibu dan bayi, mengurangi kemampuan ibu untuk mengatasi transformasi yang melekat pada periode *postpartum*, dengan kemungkinan memburuk selama pertumbuhan bayi. Ibu yang menunjukkan gejala kecemasan memiliki kompleksitas yang lebih besar untuk memahami emosinya dan akan mengganggu pemberian pengasuhan kepada bayinya (Melo et al., 2021).

C. Dimensi *Self-Efficacy*

Terdapat tiga dimensi berdasarkan pembentukan *self-efficacy* antara lain (Botha et al., 2020):

1. Dimensi Tingkat Kesulitan (*Magnitude*)

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas, keyakinan ibu terhadap kemampuannya dalam menjalankan tugas pada tingkat kesulitan tertentu. Ketika

ibu dihadapkan pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, ibu akan memilih mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya dan menghindari tugas yang menurutnya di luar batas kemampuan. Tingkat kesulitan dapat dibagi menjadi:

- b. Tingkat keterampilan yaitu tingkatan pada keyakinan ibu terhadap keterampilan yang ibu miliki untuk menyelesaikan tugas sebaik-baiknya
- c. Tingkat usaha yaitu tingkatan pada keyakinan ibu terhadap kemampuan mengarahkan usaha yang maksimal untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik
- d. Tingkat ketepatan yaitu tingkatan pada keyakinan ibu terhadap kemampuan menyelesaikan tugas dengan tepat
- e. Tingkat produktivitas yaitu tingkatan pada keyakinan ibu terhadap kemampuan akan menghasilkan sesuatu
- f. Tingkat cara menghadapi ancaman yaitu tingkatan pada keyakinan ibu terhadap kemampuan dalam menghadapi setiap hambatan yang datang.

2. Dimensi Tingkat Keyakinan (*Generality*)

Dimensi *generality* merupakan keyakinan ibu dalam melakukan tugas tertentu berdasarkan kemampuan menguasai keterampilan baik yang bersifat khusus/spesifik maupun umum. Keyakinan diri yang tinggi akan meningkatkan kemampuan ibu untuk melakukan tugas lebih banyak dan pada cakupan bidang yang lebih luas. *Self-efficacy* yang tinggi akan memotivasi ibu mampu melakukan tugas-tugas sebagai orang tua dari yang bersifat umum seperti memandikan bayi, menyusui bayi, menjaga kehangatan bayi, dan lain-lain sampai tugas yang bersifat khusus seperti merespon bayi saat merasa haus atau lapar. Dimensi tingkat keyakinan ini terdiri dari keyakinan bahwa ibu mampu untuk melakukan tugas-tugas lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan aktifitas dengan tugas yang mampu dikerjakannya (derajat kesamaan aktifitas), serta keyakinan bahwa dalam menyelesaikan tugas ibu harus memiliki modalitas ekspresi meliputi *kognitif*, *afektif*, dan *behavior* (modalitas ekspresi).

3. Dimensi Tingkat Kekuatan (*Strength*)

Dimensi ini melihat dari ketahanan ibu dalam melakukan tugasnya. Ibu yang memiliki keyakinan tinggi akan tekun dan gigih dalam menjalankan perannya meskipun terdapat hambatan dan kesulitan. *Self-efficacy* yang tinggi memberikan kemampuan pada ibu dalam menghadapi setiap hambatan atau masalah yang ditemui selama periode *postpartum*.

Parenting self-efficacy seorang ibu dipengaruhi oleh banyak faktor, tergantung dari jenis tugas yang harus ibu selesaikan. Faktor-faktor yang memengaruhi *parenting self-efficacy* sebagai berikut (Nurbaiti et al., 2021):

1. Usia Ibu

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa usia ibu berhubungan dengan *parenting self-efficacy*. Pada umumnya *self-efficacy* yang tinggi pada usia ibu 40 – 65 tahun. Pada usia ini dapat disebut sebagai tahap usia keberhasilan karena memiliki pengaruh yang maksimal, mampu membimbing dan menilai diri sendiri. Ibu yang berusia lebih tua memiliki skor *parenting self-efficacy* lebih tinggi dibandingkan ibu dengan usia muda.

2. Paritas

Pada faktor paritas dihubungkan dengan pengalaman mengasuh dan merawat anak sebelumnya. Ibu primipara tidak memiliki pengalaman dalam merawat anak sebelumnya sehingga memiliki *parenting self-efficacy* yang lebih rendah dibandingkan ibu dengan multipara. Pengalaman masa lalu sangat memengaruhi *self-efficacy* ibu.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan ibu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa berhubungan dengan *parenting self-efficacy*. Tingkat pendidikan umumnya akan memengaruhi kemampuan ibu dalam menerima dan mengolah informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang ibu akan semakin tinggi pula *parenting self-efficacy* yang dimilikinya.

4. Dukungan

Dukungan suami, keluarga dan dukungan sosial lainnya yang adekuat akan memberikan keyakinan ibu untuk melakukan tugas asuhan pada bayinya dengan baik. Ibu yang mendapatkan *rooming-in* dan didampingi oleh suami selama persalinan dan nifas memiliki *parenting self-efficacy* lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak dilakukan *rooming-in* dan tanpa pendampingan persalinan oleh suami.

5. Status Kesehatan Anak

Status kesehatan anak berhubungan dengan tingkat kesulitan dalam melakukan perawatan yang diberikan. Ibu dengan bayi yang terganggu kesehatannya atau cacat akan menyebabkan *parenting self-efficacy* rendah. Beberapa ibu akan meminta bantuan kepada tenaga kesehatan dalam perawatan bayinya. Keadaan ini akan menghambat pembentukan *parenting self-efficacy*.

D. Parenting Self-Efficacy Pada Ibu Nifas

Bidan berperan sebagai edukator dan model yang memfasilitasi individu meningkatkan kemampuan beradaptasi dan melakukan aktifitas fisik. Ibu *primipara* diberikan intervensi edukasi *postpartum* untuk meningkatkan *self-efficacy* dalam perawatan bayi dan menyusui. Pendampingan ibu *postpartum* dilakukan selama di Rumah Sakit, Klinik, atau Puskesmas tempat persalinan kemudian dilanjutkan dengan

melakukan kunjungan rumah (*home care*) atau kunjungan nifas ke fasilitas kesehatan untuk memantau proses involusi uteri (Germeroth et al., 2019).

Dalam meningkatkan *parenting self-efficacy*, bidan perlu menyediakan informasi terkait tugas-tugas dalam membina hubungan baik antara ibu dan bayi selama periode *postpartum* dengan merespon setiap isyarat dan pemenuhan kebutuhan bayi, serta memantau tumbuh kembangnya. Beberapa pokok bahasan dalam disampaikan yang berkaitan dengan perawatan dan pengasuhan bayi seperti karakteristik perilaku bayi, pola aktivitas/tidur bayi, kebutuhan nutrisi, perawatan dasar bayi seperti merawat tali pusat, menjaga *personal hygiene*, menggendong bayi, menenangkan bayi serta melakukan stimulasi tumbuh kembang bayi (Rachmawati et al., 2021).

Peningkatan *parenting self-efficacy* dapat dikembangkan melalui intervensi edukasi *postpartum* untuk meningkatkan *self-efficacy* seperti pada proses menyusui. Intervensi lain dengan diskusi kelompok dan pemberian *booklet* untuk menilai efektivitas *parenting self-efficacy* (Pramudianti, 2017).

Dukungan dan informasi tentang tugas pengasuhan bayi baru lahir juga dapat digunakan sebagai intervensi yang disediakan dalam bentuk *database* yang nantinya dapat diakses oleh ibu via internet. Tersedianya forum diskusi dapat menjadi alat komunikasi secara *online* dengan penyedia layanan. Ibu juga diberi kesempatan untuk bertanya seputar keluhan-keluhan atau hambatan yang dihadapi selama pengasuhan pada periode *postpartum* (Leahy-Warren & McCarthy, 2011).

Edukasi *postpartum* bertujuan untuk membantu ibu beradaptasi terhadap peran barunya sebagai ibu dan proses belajar untuk merawat bayinya, serta mengidentifikasi masalah kesehatan yang umum terjadi. Kurangnya pengalaman ibu primipara menjadi penyebab *self-efficacy* tidak berhasil atau gagal. Hal ini dapat menjadi penyebab menurunnya kepercayaan diri ibu melakukan tugas perawatan bayi secara mandiri. Peran bidan dituntut dalam kondisi ini, dengan memberikan perhatian lebih khususnya pada ibu *primipara* (Pramudianti, 2017).

Fokus perawatan *postpartum* menempatkan ibu sebagai individu yang sehat, memiliki kemampuan dan kepercayaan diri, membutuhkan dukungan baik dari tenaga kesehatan maupun suami dan keluarganya untuk melakukan aktivitas secara mandiri (Wittkowski et al., 2017).

Kesiapan belajar dan keadaan emosional ibu yang stabil juga menjadi faktor penentu keberhasilan intervensi peningkatan *parenting self-efficacy*. Kualitas interaksi dan dukungan sosial bidan secara langsung dapat memengaruhi *self-efficacy* ibu. Interaksi yang telah terbina dengan baik memiliki sisi positif antara bidan dan ibu sehingga ibu akan menjadikan bidan sebagai *role model* yang layak untuk ditiru dan diikuti apa yang menjadi nasihat atau sarannya. Intervensi lain yang dapat digunakan dalam peningkatan *parenting self-efficacy* adalah dengan metode redemonstrasi. Metode ini bermanfaat dalam menurunkan kecemasan dan

kekhawatiran ibu terhadap kesalahan yang mungkin terjadi. Redemonstrasi juga terbukti efektif untuk melihat dan menilai keterampilan ibu dalam melakukan tindakan perawatan bayi baru lahir. Metode demonstrasi dan redemonstrasi menyebabkan peningkatan kepuasan ibu terhadap edukasi yang diberikan sehingga peningkatan *parenting self-efficacy* ibu meningkat (Botha et al., 2020; Salonen et al., 2009).

E. Instrumen Parenting *Self-Efficacy*

Parenting self-efficacy biasanya dinilai melalui pengukuran laporan diri yang tepat mengingat bahwa *parenting self-efficacy* mencerminkan kepercayaan atau penilaian orang tua atas kemampuannya untuk berhasil melakukan tugas pengasuhan yang diberikan.

Laporan diri tersebut menilai empat domain yaitu:

1. *Self-efficacy* umum atau sifat

Langkah-langkah menilai dari *self-efficacy* umum dengan menilai secara keseluruhan dalam peran pengasuhan dan item tidak terikat dengan tugas pengasuhan khusus, contohnya: Apakah yang saya lakukan memiliki pengaruh kecil terhadap perilaku anak saya”.

2. Spesifik/khusus domain

Parenting self-efficacy spesifik/ khusus menilai keyakinan orang tua dalam kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas tertentu dari peran pengasuhan anak pada usia tertentu, contohnya : Seberapa baik Anda membuat bayi Anda bersenang-senang dengan Anda?”. Spesifik domain memiliki item yang seluruhnya spesifik seperti spesifik dalam tugas, spesifik usia, spesifik situasi, dll (Wittkowski et al., 2017).

3. Domain umum

4. Domain khusus (Leahy-Warren & McCarthy, 2011).

Parenting Self-Efficacy Scale (PSES) merupakan skala yang digunakan untuk menilai keyakinan orang tua terhadap kemampuan dalam pengasuhan anak (Salonen et al., 2009). PSES meliputi aspek kognitif, afektif, dan keterampilan sebagai berikut:

1. **Aspek Kognitif**

- a. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini dalam memilih makanan yang baik untuk bayi?
- b. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini dalam melakukan perawatan dan menjaga *personal hygiene* bayi?
- c. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini tentang cara mengganti pakaian bayi?

- d. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini tentang pola aktivitas/tidur bayi?
- e. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini tentang perkembangan normal bayi?
- f. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini tentang cara merangsang perkembangan bayi?
- g. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini tentang lingkungan yang aman untuk bayi?
- h. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini dalam mengenal setiap isyarat bayi?
- i. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini tentang cara menghibur dan menenangkan bayi?
- j. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengalaman ibu saat ini yang mendukung dalam mengambil suatu keputusan perawatan bayi?
- k. Bagaimana keyakinan ibu terhadap pengetahuan ibu saat ini kemana mencari bantuan atau dukungan ketika bayi memiliki masalah?

2. Aspek Afektif

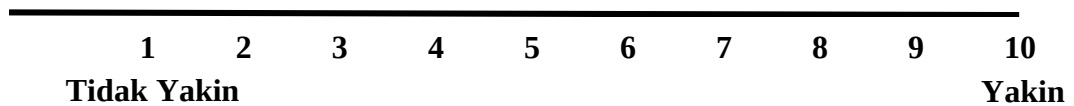
- a. Bagaimana keyakinan ibu saat ini dalam kemampuan mengenali tanda-tanda bayi lapar?
- b. Bagaimana keyakinan ibu saat ini dalam kemampuan merespon setiap tangisan bayi?
- c. Bagaimana keyakinan ibu saat ini dalam kemampuan merespon setiap kondisi bayi?
- d. Bagaimana keyakinan ibu saat ini dalam kemampuan merespon setiap isyarat bayi dan perilaku yang tidak bisa?
- e. Bagaimana keyakinan ibu saat ini dalam kemampuan merespon setiap penampilan yang ditunjukkan bayi?
- f. Bagaimana keyakinan ibu saat ini dalam kemampuan memberikan rangsangan pada bayi?
- g. Bagaimana keyakinan ibu saat ini dalam kemampuan memberikan kesenangan atau hiburan pada bayi?

3. Aspek Keterampilan

- a. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan ibu saat ini menjaga dan memelihara bayi dengan baik?
- b. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan ibu saat ini melakukan semua aktivitas perawatan dasar pada bayi?
- c. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan ibu saat ini menidurkan bayi dengan nyaman?

- d. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan ibu saat ini menilai setiap kondisi yang ditunjukkan bayi?
- e. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan ibu saat ini terhadap kemampuan ibu melakukan perawatan bayi dengan aman?
- f. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan ibu saat ini untuk menghibur dan menenangkan bayi?
- g. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan ibu saat ini dalam menyayangi bayi dengan sepenuh hati?
- h. Bagaimana pengetahuan terhadap kemampuan ibu saat ini untuk memberikan rangsangan untuk perkembangan bayi?
- i. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan ibu saat ini untuk melakukan seluruh perawatan bayi?

Pertanyaan di atas dengan jawaban rentang angka sesuai dengan keyakinan sebagai berikut:



Gambar 12.1
Rentang Angka Jawaban sesuai dengan Keyakinan

DAFTAR PUSTAKA

- Botha, E., Helminen, M., Kaunonen, M., Lubbe, W., & Joronen, K. (2020). Mothers' parenting self-efficacy, satisfaction and perceptions of their infants during the first days postpartum. *Midwifery*, 88, 102760. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102760>
- Germeroth, L. J., Wang, Z., Emery, R. L., Cheng, Y., & Levine, M. D. (2019). The Role of Self-Efficacy and Motivation in Postpartum Sustained Smoking Abstinence. *Women's Health Issues*, 29(3), 259–266. <https://doi.org/10.1016/j.whi.2019.03.006>
- Leahy-Warren, P., & McCarthy, G. (2011). Maternal parental self-efficacy in the postpartum period. *Midwifery*, 27(6), 802–810. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2010.07.008>
- Melo, L. C. de O., Bonelli, M. C. P., Lima, R. V. A., Gomes-Sponholz, F. A., & Monteiro, J. C. D. S. (2021). Anxiety and its influence on maternal breastfeeding self-efficacy. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 29, e3485. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.5104.3485>
- Nurbaiti, F. N., Herniyatun, & Astutiningrum, D. (2021). Hubungan Karakteristik Personal Terhadap Parenting Self Efficacy Pada Ibu Post Partum Di Rs Pku Muhammadiyah Gombong. *University Research Colloquium*, 251–263, 251–263.
- Oktafia, R., Rahmayanti, R., Maghpira, D. A., & Indriastuti, N. A. (2022). Psychosocial Condition and Parenting Self-Efficacy Among Postpartum Mothers. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7, 241–246. <https://doi.org/10.30604/jika.v7iS2.1435>
- Pramudianti, D. N. (2017). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Parenting Self-Efficacy Pada Periode Awal Postpartum Di Bidan Praktik Mandiri (Bpm) Gunarti , Banjarbaru. *Jurnal Of Midwifery & Reproduction*, 1(1), 15–20. <https://journal.umbjm.ac.id/index.php/midwiferyandreproduction/article/view/86%0Ahttps://journal.umbjm.ac.id/index.php/midwiferyandreproduction/article/download/86/44>
- Rachmawati, D., Marcelina, L. A., & Permatasari, I. (2021). Hubungan Dukungan Sosial Dengan Self-Efficacy Ibu Postpartum. *Jkep*, 6(2), 160–172. <https://doi.org/10.32668/jkep.v6i2.761>
- Salonen, A. H., Kaunonen, M., Åstedt-Kurki, P., Järvenpää, A. L., Isoaho, H., & Tarkka, M. T. (2009). Parenting self-efficacy after childbirth. *Journal of Advanced Nursing*, 65(11), 2324–2336. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05113.x>
- Wittkowski, A., Garrett, C., Calam, R., & Weisberg, D. (2017). Self-Report Measures of Parental Self-Efficacy: A Systematic Review of the Current Literature. *Journal of Child and Family Studies*, 26(11), 2960–2978. <https://doi.org/10.1007/s10826-017-0830-5>

BIOGRAFI PENULIS



Tonasih, SST., M.Kes. Lahir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia pada tanggal 22 Oktober 1981. Jenjang Pendidikan D4 Bidan Pendidik di Poltekkes Kemenkes Bandung, Lulus Tahun 2006. Pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro Semarang, Lulus tahun 2013. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua I (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) di STIKes Muhammadiyah Cirebon.

Beberapa buku yang sudah di terbitkan antara lain: Latihan Soal Uji Kompetensi D III Bidan, Tahun 2022; Pengantar Ilmu Komunikasi, Tahun 2021; Psikologi Pendidikan, Tahun 2021; Tablet Tambah darah (Fe) untuk Remaja Putri (Rematri), Tahun 2021; Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui (Edisi Covid-19), Tahun 2020; Sosioantropologi bagi Mahasiswa Kebidanan, Tahun 2020; Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui (Edisi Revisi), Tahun 2019; Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui, Tahun 2018; Program Kemitraan Bidan-Dukun, Tahun 2016.

Penulis bisa dihubungi melalui e-mail: asih_islamiyah@yahoo.co.id dan No. HP/WA: 0812-1908-5783



Evi Dwi Prastiwi, SST., M.Kes.

Dosen Program Studi D3 Kebidanan, STIKes Maharani Penulis lahir di Sidoarjo tanggal 1 April 1987. Penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi D3 Kebidanan STIKes Maharani sejak 2019 sampai sekarang.

Penulis menyelesaikan pendidikan D3 dan D4 Kebidanan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dan melanjutkan S2 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Reproduksi di Universitas Respati Indonesia Jakarta.

Penulis juga mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui di Program Studi D3 Kebidanan. Selain dalam bidang pengajaran, penulis juga aktif dalam melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.

BIOGRAFI PENULIS



Dewi Andariya Ningsih, S.S.T., M.Keb.

Penulis menyelesaikan pendidikan D4 di STIKES Husada jombang pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Padjajaran Bandung lulus tahun 2017. Pada tahun 2023 lulus profesi bidan di Stikes Bnayuwangi

Sejak tahun 2017, penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen kebidanan dan saat ini aktif mengajar di Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimy.

Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Penulis pernah mengikuti pelatihan management Laktasi oleh Perinasia (Perkumpulan Perinatologi Indonesia) tahun 2022

Penulis dapat dihubungi melalui email dewiandariya01@gmail.com

Pesan untuk para pembaca: Karyamu akan menempati bagian tersendiri dalam hidupmu



Kusumastuti, S.Si.T., M.Kes.

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Prodi DIV Kebidanan STIKES Ngudi Waluyo Ungaran pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (MIKM) Minat Kesehatan Ibu dan Anak (MKIA) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, lulus tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Profesi

Kebidanan di Univeritas Muhammadiyah Gombong. Saat ini, penulis melanjutkan pendidikan S3 di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gajah Mada (UGM). Sejak tahun 2008, penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen kebidanan dan saat ini aktif mengajar di Prodi Kebidanan Program Diploma dan Sarjana Univeritas Muhammadiyah Gombong.

Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta Jurnal Nasional Dan Internasional lainnya.

Penulis pernah mendapatkan Beasiswa Retooling Kompetensi Dosen Vokasi pada Tahun 2019 dari Kemenristekdikti. Penulis juga telah mengikuti pelatihan Training of trainer (TOT) Prenatal dan Post Natal Gentle Yoga serta Yoga Kids.

Penulis dapat dihubungi melalui email ncuz.kusuma26@gmail.com

Pesan untuk para pembaca:

Hidup adalah tentang belajar....maka bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat...dan jangan pernah berhenti belajar....karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan.

BIOGRAFI PENULIS



Niken Bayu Argaheni, S.ST, M.Keb., dosen di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Founder dari Perempuan Berdaya. Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Riset Group "Pengaruh Mat *Pilates Exercise* Terhadap Skala Nyeri, Kecemasan, Frekuensi Nadi Pada Remaja Putri Dengan Dismenorrhea Primer di Surakarta (2020)", "Pembelajaran Daring Research Group Ibu Hamil Guna Pencegahan Covid-19 (2020)", Bimbingan Konseling Spiritual Bagi Pengasuh Dan Anak Asuh Panti Asuhan Anak Penderita HIV/AIDS Di Yayasan Lentera Surakarta (2021)". Penerima Penghargaan Inovasi dan P2M Award tahun 2022, Peringkat 1 Kategori Tenaga Pengajar Bidang Sains dan Teknologi, Mendapat Rewards dari Qatar Airways untuk kategori: *Frontline healthcare professionals (doctor, medical practitioner, nurse, paramedic, pharmacist, lab technician and clinical researcher) during the current Covid-19 pandemic tahun 2022*. Penerima Hibah Bidan Inspiratif Untuk Negeri dari Kimia Farma dan Dompot Dhuafa tahun 2022. Dapat dihubungi di kontak: +6285740888008, email: kinantiniken@gmail.com



Rini Deska, S.ST. M.KM.CTM-MT

Penulis lahir di Tanjung karang, 16 Desember 1976. Penulis adalah alumni dari Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Muhammadiyah Jakarta tahun 2017. Penulis merupakan dosen pengajar pada Program Studi D3 kebidanan STIKes Panca Bhakti Bandar Lampung. Beberapa mata kuliah yang pernah diampu penulis diantaranya Asuhan kebidanan komunitas, Asuhan Pasca Persalinan dan Menyusui, Dokumentasi dan Entrepreneurship Kebidanan.

BIOGRAFI PENULIS



Bdn. Lia Fitria, S.S.T., M.Keb.

Lahir di Situbondo, 31 Mei 1986. Penulis menyelesaikan pendidikan D4 Kebidanan di STIKES Insan Unggul Surabaya pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjajaran Bandung lulus tahun 2017. Pada tahun 2023 lulus profesi bidan di STIKES Banyuwangi.

Sejak tahun 2017, penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen kebidanan dan saat ini aktif mengajar di Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimy. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya.

Penulis dapat dihubungi melalui email leeafitria@gmail.com

Pesan untuk para pembaca:

Buku adalah gerbang dunia dan membaca adalah kuncinya



Siti Rusyanti, S.ST., M.Keb

Menyelesaikan pendidikan D III di Program Studi Kebidanan Cirebon Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Penulis melanjutkan pendidikan D IV Kebidanan UNPAD, kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan UNPAD.

Sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang penulis aktif mengajar di Program Studi D III Kebidanan Rongkasbitung Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta artikel pada prosiding serta jurnal Nasional dan Internasional.

Penulis dapat dihubungi melalui email siti.rusyanti@poltekkesbanten.ac.id

Pesan untuk para pembaca: Penulis sangat berharap buku ini dapat menjadi bahan literasi oleh akademisi, praktisi kesehatan dan masyarakat umum dalam hal komplementer bagi ibu masa nifas dan menyusui berdasarkan bukti ilmiah sehingga status kesehatan ibu nifas dan menyusui semakin meningkat.

BIOGRAFI PENULIS



Shinta Wurdiana Rhomadona, S.ST.,M.Tr.Keb

Menyelesaikan pendidikan: Lulus D3 Kebidanan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya tahun 2007. Lulus D4 Kebidanan dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2012. Lulus S2 di Program Pascasarjana Magister Terapan Kebidanan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang tahun 2018. Sejak tahun 2012, penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen kebidanan dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi D3 Kebidanan di STIKes William Booth Surabaya. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta Jurnal Nasional dan Internasional lainnya. Pernah mengikuti beberapa pelatihan seperti Pelatihan *Prenatal Gentle Yoga* dan Pelatihan *Massage and Spa for Baby and Mom*. Pernah mengikuti Program Residensi di Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand untuk belajar *Thai Tradisional Medicine* serta presentasi oral pada *Internasional Conference On Applied Science and Health (ICASH)* di Mahidol University.

Penulis dapat dihubungi melalui email shintawurdiana24@gmail.com. Pesan untuk pembaca: Kenapa bidan boleh menggunakan pelayanan komplementer? Karena pada dasarnya Bidan adalah profesi yang memberikan pelayanan secara holistik, sehingga penggunaan Terapi Komplementer merupakan salah satu cara untuk membantu pasien secara fisik, mental, sosial dan emosional serta ini merupakan peluang untuk *entrepreneurship*. Oleh Karena itu, tepat sekali jika buku ini digunakan sebagai bahan ajar pelayanan kebidanan komplementer.



Muayah, S.KM., SST., M.Tr.Keb Penulis biasa dikenal dengan nama panggilan Yayah, lahir di Tangerang pada tanggal 02 Februari 1989 dan menyelesaikan Pendidikan D III Kebidanan di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Tahun 2010, Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia pada Tahun 2012, D IV Bidan Pendidik di Universitas Muhammadiyah Tangerang pada Tahun 2016 dan Magister Terapan Kebidanan di STIKes Dharma Husada

Bandung pada Tahun 2019. Penulis saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap di STIKes Widya Dharma Husada Tangerang Selatan, aktif sebagai penulis pada Program Penerbitan Buku UKOM dengan Tim Optimal.

Penulis dapat dihubungi melalui E-mail yayahwdh@gmail.com

Motivasi penulis adalah Bermimpilah setinggi-tingginya, kemudian berusaha dan berdo'a "Ya Allah kabulkanlah impian-impian hamba". Aamiin Yaa Robbal'aalamiin.

BIOGRAFI PENULIS



Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.Si.T., M.Keb

Lahir di Sarolangun, tanggal 17 Maret 1990. Telah menyelesaikan studi pada DIII Kebidanan STIKes A. Yani Yogyakarta (sekarang Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta) tahun 2010, lulus DIV Kebidanan STIKes Ngudi Waluyo Ungaran (sekarang Universitas Ngudi Waluyo) tahun 2011, lulus S2 Ilmu Kebidanan di Universitas Andalas tahun 2017. Pernah menjadi dosen tetap Prodi Kebidanan Program Sarjana dan menjabat sebagai Wakil Ketua I STIKes Keluarga Bunda Jambi. Saat ini bekerja sebagai dosen di Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan IPA Universitas Bengkulu. Pernah mendapatkan Hibah Penelitian Kemdikbudristek dengan skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) sebanyak 2 kali sebagai ketua dan 1 kali sebagai anggota, dan skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT) sebanyak 1 kali sebagai ketua. Saat ini masih menjadi sekretaris dalam kepengurusan IBI Ranting Di Provinsi Jambi dan sebagai pengurus daerah perkumpulan Relawan Jurnal Indonesia (RJI) Jambi. Pernah menjadi narasumber di beberapa kesempatan baik seminar maupun kuliah pakar yang berkaitan dengan ilmu kebidanan, menjadi pengajar dalam bimbingan belajar uji kompetensi bidan serta telah menerbitkan beberapa buku ajar, buku referensi serta saat ini sedang menyusun buku monograf.

BIOGRAFI PENULIS



Bdn. Pande Putu Indah Purnamayanthi, S.ST., M.Kes

Lahir di Gianyar, 25 Juni 1989 menamatkan Pendidikan Formal terakhir di Program Studi Magister Kesehatan Minat Utama Pendidikan Profesi Kesehatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam keseharian bekerja sebagai Dosen Kebidanan di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Bali, yang dilakoni sejak tahun 2015. Sebagai dosen telah menghasilkan beberapa karya publikasi ilmiah. Untuk dapat terhubung dengannya, dapat melalui email pandeindah25@gmail.com atau akun sosial media IG.indahmoet.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Sinduadi Timur Yogyakarta, 1994-1995
2. SD Negeri Sinduadi Timur Yogyakarta, 1995-2001
3. SLTP Negeri 1 Rendang, 2001-2004
4. SMA Negeri 1 Kediri, 2004-2007
5. DIII Kebidanan STIKES Bali, 2007-2010
6. DIV Bidan Pendidik Universitas Respati Yogyakarta, 2011-2012
7. Magister Kesehatan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012-2014

RIWAYAT PEKERJAAN

1. 2010 – 2011: Asisten Praktik Mandiri Bidan Rai Citawati, S.ST
2. 2011-2012: Magang di Praktik Mandiri Bidan Yosi Trihanna di Klaten Jawa Tengah
3. 2015 - sekarang : Dosen Kebidanan di STIKES Bina Usada Bali

SINOPSIS

Masa nifas adalah masa sejak melahirkan sampai dengan pulihnya tubuh dan organ reproduksi. Periode ini berlangsung selama enam minggu atau kurang lebih 40–42 hari setelah ibu melahirkan. Periode pascapersalinan meliputi masa transisi kritis bagi ibu, bayi dan keluarganya secara fisiologis, emosional dan sosial.

Selama masa nifas, seorang ibu akan mengalami perubahan baik perubahan fisiologis maupun psikologis. Jika perubahan-perubahan ini tidak dapat ditangani dengan baik, maka dapat terjadi komplikasi pada ibu nifas. Oleh karena itu, perlu adanya suatu upaya untuk memulihkan kondisi kesehatan seseorang yang sakit, diantaranya meliputi perawatan (*treatment*) dan pengobatan penyakit.

Terapi komplementer berarti suatu upaya pengobatan yang dapat digunakan bersamaan dengan perawatan medis *konvensional* (bukan pengganti perawatan medis konvensional). Terapi ini dapat membantu merasa lebih baik dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup, serta dapat membantu mengatasi gejala-gejala suatu penyakit tertentu.

Terapi komplementer pada masa nifas merupakan salah satu alternatif non medis yang dapat dimanfaatkan oleh ibu dalam mengatasi keluhan dan pemulihan selama masa nifas karena dapat menghindari efek samping dari penggunaan obat-obatan dan bahan kimia.

Metode Terapi Komplementer pada Ibu Nifas dan Menyusui yang biasa diterapkan antara lain: Akupresure, Pijat *Endorphin*, Pijat Oksitosin, Yoga, *Pilates*, Pijat, Aromatherapi, Senam Nifas, Terapi Madu, *Herbal Steam Bath*, *Hypnobreastfeeding*, dan *Parenting Self-Efficacy*.

Masa nifas adalah masa sejak melahirkan sampai dengan pulihnya tubuh dan organ reproduksi.

Periode ini berlangsung selama enam minggu atau kurang lebih 40–42 hari setelah ibu melahirkan. Periode pascapersalinan meliputi masa transisi kritis bagi ibu, bayi dan keluarganya secara fisiologis, emosional dan sosial.

Selama masa nifas, seorang ibu akan mengalami perubahan baik perubahan fisiologis maupun psikologis. Jika perubahan-perubahan ini tidak dapat ditangani dengan baik, maka dapat terjadi komplikasi pada ibu nifas. Oleh karena itu, perlu adanya suatu upaya untuk memulihkan kondisi kesehatan seseorang yang sakit, diantaranya meliputi perawatan (treatment) dan pengobatan penyakit.

Terapi komplementer berarti suatu upaya pengobatan yang dapat digunakan bersamaan dengan perawatan medis konvensional (bukan pengganti perawatan medis konvensional). Terapi ini dapat membantu merasa lebih baik dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup, serta dapat membantu mengatasi gejala-gejala suatu penyakit tertentu.

Terapi komplementer pada masa nifas merupakan salah satu alternatif non medis yang dapat dimanfaatkan oleh ibu dalam mengatasi keluhan dan pemulihan selama masa nifas karena dapat menghindari efek samping dari penggunaan obat-obatan dan bahan kimia.

Metode Terapi Komplementer pada Ibu Nifas dan Menyusui yang biasa diterapkan antara lain:

Akupresure, Pijat Endorphin, Pijat Oksitosin, Yoga, Pilates, Pijat, Aromatherapi, Senam Nifas, Terapi Madu, Herbal Steam Bath, Hypnobreastfeeding, dan Parenting Self-Efficacy.

ISBN 978-623-8411-31-3



Anggota IKAPI
No. 624/DKI/2022

Penerbit :
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919